

INFORME DE SALUD

DISTRITO ZAIDÍN (GRANADA)

Abril 2023



AYUNTAMIENTO
DE GRANADA



Red Local de
Acción en
Salud

I. ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. METODOLOGÍA

3. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO

4. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO

5. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA ANDALUZA DE SALUD. PROBLEMAS DE SALUD Y FACTORES DE RIESGO

6. IV PLAN ANDALUZ DE SALUD. PROVINCIALIZACIÓN

7. RECURSOS/ACTIVOS EN SALUD

(salud, educación, sociales, deportivos,...)

ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN: MARCO CONCEPTUAL

En este período, nos encontramos frente a **una serie de demandas de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida** en el contexto, en el que nos movemos. Es este un momento histórico en el que las sociedades desarrolladas hemos alcanzado un nivel de salud inimaginable pero, paradójicamente, nos encontramos ante una etapa claramente crucial en la que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más urbanizado y, con ello, hacia la necesidad de admitir las consecuencias que esto pueda tener en la salud, tanto en beneficios como en problemas y riesgos.

En lo que respecta a la salud, **la ciudadanía demanda cada vez más, no solo tener acceso a una atención sanitaria de calidad que resuelva sus problemas de salud, sino vivir en un entorno ya sea social, laboral o de ocio, seguro y saludable**; en el que se le garantice la seguridad de los alimentos, la calidad del aire que respira y la potabilidad de las aguas que consume. El diseño de ciudades compactas, accesibles y adaptadas a todas las franjas de edad, a diferentes colectivos y necesidades influirá, indudablemente, en la calidad de vida de las personas que las habitan.

Sobre **la salud** actúan diversos determinantes o factores, que es necesario tener en cuenta a la hora de delimitar el concepto de salud, y que hacen referencia a aspectos tan variados como factores biológicos, hereditarios, personales, familiares, sociales, ambientales, alimenticios, económicos, laborales, culturales, de valores, educativos, sanitarios y religiosos. La incidencia de unos sobre otros es tal que no puede disociarse claramente la biología humana del ambiente, ni de los estilos de vida, ni de la organización de los sistemas de salud.

La prestación de servicios de atención de salud y la inversión en tecnología y tratamiento médicos no son suficientes para mejorar las condiciones de salud en la población, y además, los múltiples factores que determinan el estado de salud y la enfermedad en la población trascienden la esfera individual y se proyectan al colectivo social (postulados de Lalonde 1974).

Cabe recordar que la **Salud Pública**, definida como “el esfuerzo organizado por la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y prolongar la vida”¹, tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la población”; y para ello es necesario contribuir, de forma coordinada con otros sectores e instituciones, en la creación de las condiciones estructurales de la sociedad y en las condiciones de vida de la población más favorecedoras para la salud; en promover las conductas individuales y estilos de vida más saludables; y en luchar contra la enfermedad y minimizar la pérdida de la salud.

En las **Políticas de Salud** llevadas a cabo por los distintos países, han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar adecuadamente intervenciones sobre las "causas de las causas", tales como, por ejemplo, las acciones sobre el entorno social, y en consecuencia, los resultados obtenidos con intervenciones en salud centradas en lo curativo han sido insuficientes y no permitirán alcanzar las metas de salud de los Objetivos para el Milenio.

¹ Last, JM. *A dictionary of epidemiology*. New York: Oxford University Press; 1995.

Así, es fundamental promover el **conocimiento de los factores medioambientales y sociales** sobre la salud, facilitar la creación de entornos saludables (en consonancia con lo establecido en el Plan de Acción Comunitario de Medio Ambiente y Salud (2004-2010), fomentar las acciones tendentes a evitar, reducir o retrasar el inicio y desarrollo de los factores de riesgo: el refuerzo de la autoestima y la autonomía de las personas en la construcción de un proyecto de vida saludable, el impulso y apoyo a las familias cuidadoras, el asociacionismo y otras organizaciones de ayuda mutua y participación ciudadana.

Cabe matizar que, en lo que respecta a la aportación de los servicios sanitarios en la mejora del estado de salud de la población, así como en la reducción de las desigualdades, hay suficiente evidencia contrastada de que estos contribuyen comparativamente de una forma muy modesta ya que los servicios asistenciales están demasiado orientados hacia el mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y no lo suficiente hacia su prevención y la promoción de la salud.

Por tanto, los problemas de las desigualdades en salud como los de la carga de enfermedad, no pueden resolverse sólo desde el sistema sanitario aunque se pudieran incrementar los recursos destinados a ésta, hay que ir más allá de los servicios sanitarios, más allá de la atención a las enfermedades, resultando necesario incorporar un cambio en el punto de vista y actuar antes de que se produzcan éstas.

Para conseguir una comunidad más sana con estos criterios, significa dirigir las actuaciones hacia **los determinantes de la salud** y por ello hacia los sectores competentes.

Se entiende como determinantes sociales de la salud aquellas circunstancias configuradas por las condiciones económicas, sociales, normativas y políticas, en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen; así como los sistemas establecidos para combatir las enfermedades. Son **cuatro los determinantes de la salud**: el sistema sanitario, el medioambiente (físico y social), la genética, y los estilos de vida (Informe Lalonde, 1976).

La Salud en Todas las Políticas (STP) aparece como una estrategia innovadora transversal que da respuesta al rol crítico que juega la salud en la economía y sociedad del siglo XXI. Ésta introduce la mejora de la salud para nuestra población y la reducción de las desigualdades en salud como un objetivo compartido entre todos los niveles, sectores y agentes de gobierno, y dirige una respuesta política integrada, coherente, coordinada y transparente a los retos complejos de la salud de la población mediante la actuación en los determinantes de la salud.

El reto o requisito primordial de la estrategia de STP se refiere a la capacidad para convencer a los demás sectores y agentes de la importancia que tiene situar la salud en las agendas de todos los responsables políticos que previamente no habían considerado de manera expresa que sus políticas tuviesen un impacto positivo o negativo sobre la salud de la ciudadanía.

Es una obviedad que **la sociedad** ha cambiado profundamente y continúa transformándose. Tiende a convertirse en una compleja red donde las personas actúan, cada vez más, en calidad de consumidores y usuarios, de colectivos que comparten problemas, de miembros de corporaciones profesionales, de asociaciones, de medios de comunicación, etc.

El panorama de **nuestras ciudades** está experimentando una evidente transformación: pequeñas y grandes poblaciones se unen creando un continuo urbano en el que los límites territoriales se diluyen cada vez más: los transportes facilitan las conexiones entre barrios, ciudades y regiones, proporcionando conexiones rápidas entre lugares de trabajo, vivienda y ocio.

Los movimientos producidos por **la inmigración** facilitan el intercambio entre culturas y ofrecen una mayor riqueza, diversidad y complejidad a la vida de la ciudad. De ahí que uno de los principales retos con los que se enfrentan nuestras ciudades sea la capacidad de conexión, no sólo territorial sino también en lo que respecta a sus estructuras sociales y diferencias culturales.

El aumento de la **movilidad**, la incorporación de las tecnologías de la información a la vida cotidiana y la proliferación y la creciente importancia de los medios de comunicación abren paso a nuevas formas sociales. Con ello han adquirido especial relevancia los “estilos de vida”, que integran a las personas de comportamientos similares de ocio y consumo, al tiempo que los segmenta en grupos diferenciados: mayores, jóvenes inmigrantes...

Por otro lado, **la globalización** tiene a su vez un “dialéctico efecto” de forma que en una sociedad cada vez más globalizada se plantea a la vez la necesidad de recuperación del entorno local, cuyos espacios de participación y decisión deben estar cada vez más próximos a la realidad cotidiana. Así, el sentimiento de identidad y de pertenencia a la comunidad local (barrio, pueblo, ciudad) sigue siendo más intenso que el de Estado-Nación.

En este momento histórico en el que las sociedades desarrolladas han alcanzado un nivel de salud inimaginable hace unas décadas, con una esperanza de vida media muy alta, han hecho su aparición **las enfermedades crónicas y degenerativas**, en estrecha correlación con el envejecimiento poblacional y los estilos de vida.

Se dispone de suficiente evidencia como para afirmar que gran parte de la mortalidad y morbilidad asociadas a los factores de riesgo se podrían prevenir con estilos de vida saludables. El diseño de **ciudades saludables**, accesibles y adaptadas a todas las franjas de edad y a los diferentes colectivos y necesidades de las personas que las habitan, influirá indudablemente en la calidad de vida y en la salud de las personas que viven en ellas.

1.1 Nuevos Retos en Salud Pública y Salud Local

En este sentido, con todo lo expuesto anteriormente, **el nuevo modelo de Salud Pública en Andalucía**, tiene la misión de “*trabajar por mejorar la salud de la población*”; y para ello es necesario contribuir, de forma coordinada con otros sectores e instituciones, en la creación de las condiciones estructurales de la sociedad y en las condiciones de vida de la población más favorecedoras para la salud; en promover las conductas individuales y estilos de vida más saludables.

En este contexto, se concibe un campo de trabajo local, en el espacio de encuentro más cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su convivencia, establece sus relaciones y construye su entorno.

Actualmente, y después del camino andado, sabemos que para muchos temas de Salud Pública, es preciso un proceso de organización de varios de los elementos que constituyen una ciudad y que pueden tener un impacto positivo en la salud (la vivienda, la seguridad vial, la actividad física, la calidad del aire...); y que la implicación de estos sectores y administraciones es muy complicada si no existe un marco legal que establezca con claridad los compromisos, competencias y recursos de cada uno de ellos.

Además, lo que estas medidas exigen no es necesariamente más financiación, sino el compromiso de orientar los recursos hacia las intervenciones priorizadas y, de ese modo, incrementar la eficacia.

Cobra fuerza el concepto de **salud urbana, salud local** porque dimensiona esta visión global de la salud de la población en los diferentes pueblos y ciudades, así como el abordaje de las causas que provocan las diferentes situaciones de salud derivados del entorno urbano, tanto físico como social; y especialmente si generan desigualdades.

Y todo ello tomando como punto de partida “**lo local**”: el lugar donde viven y se desenvuelven las personas es decisivo para las intervenciones en salud. **La intervención local** comienza por la identificación, descripción y dirección de una red, en la que actúen todos los agentes que pueden influir en la salud de un determinado territorio.

Lo importante es escuchar, relacionarse y liderar grupos de ciudadanos y ciudadanas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales a la vez que se articulan las responsabilidades del gobierno local a un nivel institucional superior como el autonómico.

Contribuir a recopilar datos, proponer y desarrollar métodos y herramientas de trabajo, a establecer *Redes* y diferentes tipos de cooperación, así como promover políticas pertinentes, debe ayudar a desarrollar un espacio local de salud.

Todo ello en relación directa a las necesidades que plantea la ciudadanía, preocupada por aspectos que atañen a sus entornos, la calidad del espacio que habitan, las aguas que consumen, los alimentos que constituyen su mejor dieta, la preocupación por las relaciones del marco familiar, por sus jóvenes, por sus proyectos vitales y de familia, por sus mayores, etc.

La **Planificación Municipal** así entendida, no es posible sin una **Participación Ciudadana** activa, continua y capaz de aglutinar el mayor número de colectivos. Sin duda, la implicación de la propia ciudadanía favorece la efectividad de las intervenciones en salud. Para ello se debe conseguir, en primera instancia, que las personas se sientan protagonistas y responsables de las decisiones que afectan a su salud en el marco de su ciudad.

Así mismo, debe fomentarse el acceso a la información sobre los problemas y riesgos, sus consecuencias y las acciones posibles –individuales y colectivas- para evitarlos o reducirlos, así como recoger sus aportaciones e informar sobre el desarrollo de las acciones que se pongan en marcha.

Dotando al proceso de la participación de la ciudadanía, la ejecución requiere del consenso tanto de los responsables municipales como de toda la comunidad local (asociaciones de consumidores, empresas, centros docentes, centros sanitarios, etc.)

Esta planificación Municipal exige la concurrencia de las responsabilidades a distintos niveles de los servicios públicos (local, autonómico, estatal y europeo).

Y es que, la salud como factor de bienestar personal y social, es un elemento significativo de pacto local donde resulta posible **aunar los intereses de la ciudadanía, los intereses de los profesionales de los servicios y las corporaciones locales y dirigirlos hacia el avance de los pueblos y ciudades en el ámbito de la salud.**

Ello exige un nivel de corresponsabilidad superior a la hora de centrar la misión de cada nivel institucional de forma cooperativa. Este proyecto significa **la continuidad de un trabajo en el municipio de GRANADA, donde la intersectorialidad, la participación ciudadana y el apoyo institucional** juegan un papel fundamental

Su proyección va más allá del sector sanitario, mediante las alianzas con otros sectores implicados en el desarrollo de una planificación de la salud en el entorno urbano; fomentando la promoción de comportamientos saludables colaborando en el diseño de ciudades para una mejora de las condiciones de vida urbana; y contribuyendo al desarrollo de una gestión urbana, saludable y participativa.

En Andalucía, para afrontar estos retos, **el III Plan Andaluz de Salud (III PAS 2003-2008)**, entre sus líneas prioritarias, propone la definición y el desarrollo de un modelo integrado de salud pública, moderno, innovador y transparente que permita el liderazgo necesario para abordar una nueva etapa de la Salud en Andalucía; e **identifica la “Acción local” como uno de los 6 ejes transversales de actuación para el alcance de todos sus objetivos. El siguiente paso ha sido el IV Plan Andaluz de Salud 2013-2020.**

1.2.- MARCO LEGAL

Incorporada a la Constitución Española, **la Carta Europea de Autonomía Local**² identifica en los municipios la capacidad de ordenar y gestionar bajo la propia responsabilidad una parte importante de los asuntos públicos mediante el impulso de políticas propias. Esto se sustenta sobre el ejercicio del liderazgo político del gobierno local para que tanto los actores públicos como privados, desde sus propios ámbitos, formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y de dar una respuesta adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa.

En Andalucía, desde 1998, la Ley de Salud³, dedicada directa y principalmente al ciudadano, representa un marco legislativo más amplio para la administración sanitaria en materia de protección de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, con el que, además, se pretende regular el campo de actuación y relación con el sector privado, siempre dentro del ámbito competencial de la administración local. Con ella se potencia el papel de los municipios, con el principal objetivo de regular las actuaciones que hacen efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al sector salud, se fomenta la participación, y consecuentemente la corresponsabilidad en el derecho a la protección de la salud.

En la actualidad el **nuevo Estatuto Andaluz** confiere a los Ayuntamientos un mayor protagonismo y, sobre todo, establece que las competencias propias que les son asignadas deben conllevar la necesaria suficiencia financiera. Esto significa una apuesta de adecuación a una sociedad más actual, en la que la ciudadanía goce de muchos más derechos en los que trabajar de forma cercana y activa, de ahí que el mayor protagonismo de los ayuntamientos sea algo previsible.

En lo que respecta a la municipalidad este cambio que vivimos y que afecta a la organización de los gobiernos locales, es solo el principio de un proyecto de gobierno que se está concretando desde el nivel autonómico y que, de forma escalonada, se materializará en una descentralización de competencias y reparto de tributos a los entes locales.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía (BOJA número 255 de 31 de diciembre de 2011) y la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía (BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010) contemplan, al amparo de una gobernanza local el desarrollo de la acción local en salud en las entidades locales mediante un instrumento clave: **el Plan Local de Acción en Salud**, con el que poder incorporar los objetivos de salud en las políticas locales de los diferentes sectores. Esto convierte el pacto local en un instrumento de integración para la conexión de las inquietudes y prioridades de la ciudadanía y sus problemas de salud.

Desde el sector Salud, se deberá ejercer una actitud proactiva en relación al resto de las políticas públicas determinantes en el ámbito de la salud, y por ello se convierte en referente de las mismas.

² Consejo de Europa: Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985. Ratificada por España el 20 de enero de 1988 (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989)

³ [Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía.](#)

Esto requerirá una **convergencia de los objetivos de los diferentes sectores** en torno a la salud pública en la que cada sector actúa desde su marco de competencias, hacia otra nueva forma de gobernanza, de funcionamiento en Red local⁴; con un nodo central que representa el liderazgo del gobierno local y su corresponsabilidad, lo que supone asumir entre todas las partes:

- Una nueva forma de trabajo local liderada por los gobiernos locales, a los que también se les plantea la acción conjunta de varios departamentos;
- La acción participada de la ciudadanía como protagonista en la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas;
- Unos contenidos de protección y de promoción de la salud así como de la prevención de la enfermedad y de los riesgos para la salud y el desarrollo, explícitos.
- Una forma de abordaje capaz de implicar a todos los actores que concurren en estos espacios, con un lenguaje común, diferentes formas de comunicación y fomento de las alianzas;
- Un estilo de trabajo: “trabajar con los otros”.

En este período en el que nos encontramos, **el desarrollo del IV Plan Andaluz de Salud, incorpora la perspectiva local** como un instrumento clave capaz de garantizar sus objetivos mediante la conexión de las políticas de salud con las estrategias de respuesta que se ejecutan en el nivel local.

⁴ **Red Local:** estructura operativa de acción intersectorial en el entorno más cercano de la ciudadanía, por la que se establecen relaciones entre las personas, los grupos y la comunidad; se posibilita el desarrollo de actividades conjuntas; se generan conexiones entre las instituciones y otras entidades territoriales; y que permite la combinación de intereses de los diferentes actores, en el proceso de alcanzar objetivos comunes de progreso, compartiendo los recursos.

1.3.- JUSTIFICACIÓN PROYECTO RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (RELAS)

- ❑ **La integración de la salud** como eje transversal en todas las políticas es necesaria para el desarrollo de respuestas eficaces a los retos actuales de la salud y mucho más efectiva en el entorno más próximo a la ciudadanía.
- ❑ **La salud es un recurso fundamental** para la sociedad porque las personas en buena salud incrementan su capacidad productiva y su competitividad frente a sociedades menos saludables; generan riqueza, mejoran el capital de las ciudades.
- ❑ **El círculo virtuoso entre salud, bienestar, desarrollo social y económico** justifica, la implementación de este Proyecto en el nivel local.

Se trata de desarrollar una “forma de hacer” única a nivel central, pero con visión territorial y apuesta local. Los Ayuntamientos, como socios estratégicos para la acción periférica, se convierten en agentes clave de la salud pública, por su capacidad de rentabilizar todas aquellas actuaciones poblacionales y del entorno en relación con la salud (estilos de vida, entornos físico y social...).

Esto significa apostar por el nivel local, fortaleciendo la capacidad de respuesta e implicándoles en la toma de decisiones, formulación de objetivos en Salud Pública y asignación de recursos. Es imprescindible estrechar la relación y coordinación con los ayuntamientos, al mismo tiempo que se crean las bases para avanzar en una red funcional integrada de servicios de Salud Pública.

El objetivo es conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las respuestas a los problemas, lo que conlleva una tarea compartida, en la que se investiguen e incorporen nuevos instrumentos.

Pero no partimos de cero, **el proyecto piloto de la Red Local de Acción en Salud (RELAS), desarrollado en 10 municipios de Andalucía (2008-2010)**, ha permitido identificar una metodología de acción local mediante un funcionamiento en red de los diferentes sectores implicados con la situación de salud en el territorio, que bajo el liderazgo del gobierno local ha desarrollado un Plan Local de Salud como respuesta a la mejora de la salud y calidad de vida de la población.

2. METODOLOGÍA

Unidad de análisis

En el análisis de los resultados, se ha tenido en cuenta, la demarcación territorial que aparece en el Mapa de Atención Primaria de Salud en Andalucía, correspondiente al municipio de Granada, en base al Distrito Sanitario Granada-Metropolitano.

El análisis comparativo de los indicadores empleados y de los resultados, se ha realizado teniendo en cuenta, los datos de una serie de municipios seleccionados con diferentes perfiles de la provincia de Granada, que están adheridos a la Acción Local en Salud, también se tiene presente los datos globales a nivel provincial, autonómico y cuando procede, por la disponibilidad de la información requerida, a nivel nacional.

En este caso, se ha tenido en cuenta, la información desagregada para el Distrito Censal del Zaidín, en función de la información disponible, y que desde el punto de vista de la atención primaria en salud, se correspondería con las Unidades Asistenciales (UA) de Zaidín Sur y Zaidín Centro-Este, cubriendo la zona denominada como Zaidín-Vergeles.

Fuentes de datos

Las fuentes de datos que se emplean son las siguientes:

- Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Base de Datos de Usuarios (BDU) del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
- Diábaco (aplicación que permite la explotación de DIRAYA, la Historia Clínica Digital de AP en el SSPA).
- Sistema de Información para la Gestión en Atención Primaria (SIGAP).
- Registros propios del Centro de Salud o del Distrito.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA).
- Infoweb y las Bases Poblacionales en Salud (BPS)
- Página web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- Encuesta Andaluza de Salud 1999-2017.

3. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO

3.1.- Localización geográfica

Granada es un municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en el centro de la comarca Vega de Granada, a una altitud de 680 metros, en una amplia depresión intrabética formada por el río Genil y por el macizo más alto de la península ibérica, Sierra Nevada, que condiciona su clima.

En este año, según censo, la población es de 228.682. Los barrios que posee son muy diferentes entre sí, en parte por la continuada inmigración acaecida hasta la década de 1990; los más importantes son el Zaidín, el Albaicín, el Sacromonte, el Realejo, La Chana, Almanjáy y Cartuja.

El término municipal está situado en la parte más oriental de la depresión de Granada, en contacto con el pie de monte de Sierra Nevada (formación de unos 87,8 km²). La depresión se sitúa estratégicamente en el Surco Intrabético. De esta forma, a partir del pasillo de [Iznalloz](#) tiene acceso al [desfiladero](#) de Despeñaperros, que comunica a la región de Andalucía con el centro de la península ibérica; a partir de [Valle de Lecrín](#) tiene acceso a la costa Subtropical granadina; por el [Puerto de la Mora](#) tiene acceso a las [Hoyas de Guadix](#) y [Baza](#) y por lo tanto a [Almería](#) y Murcia; y por último, a partir del pasillo de Loja tiene acceso a la [Depresión de Antequera](#) y a la Depresión Bética.

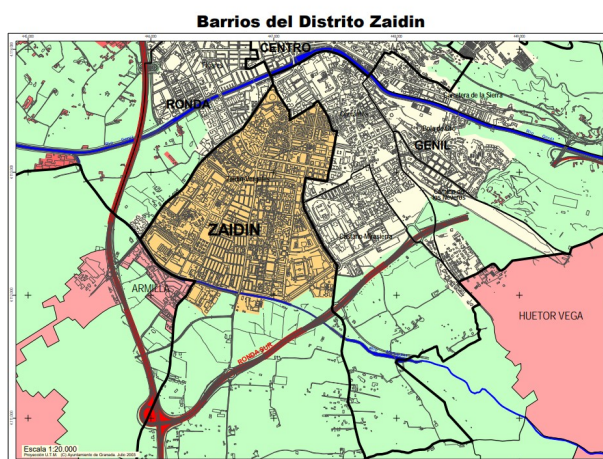


El Distrito del Zaidín es un barrio y **distrito** situado al sur de la ciudad de **Granada**. Es el barrio, que no el distrito, más populoso de la ciudad. Limita al **noreste** con el barrio de **Cervantes**, al **sureste** con **Castaño-Mirasierra**, al **noroeste** con el barrio **Fígares** (**distrito Ronda**), al **suroeste** con el **término municipal** de **Armilla** junto a su **pedanía**; **Santa Juliana** y al **sur** con el de **La Zubia**.³

Está conformado por las antiguas barriadas de Casillas Bajas, Santa Adela, Santa Rosalía, Vergeles, Madrigales, La Cruzada, Comandante Valdez, Ciudad Jardín, Divina Infantita, Parque de las Infantas y por las recientes de Cruz de Lagos, Palacio de Deportes y Campus de la Salud.

El Zaidín es histórica y etimológicamente el territorio comprendido entre los ríos **Genil** y **Monachil**; por tanto, en este sentido, pueden considerarse incluidos en la denominación Zaidín zonas que administrativamente pertenecen a los distritos colindantes.³

El 27 de febrero de 1994 se hermanó con **Zaidín**, un **municipio** de la **provincia de Huesca**.



Población Municipio de Granada y Distrito Zaidín 2022

Núcleos de población	Población		
	Total	Hombres	Mujeres
Granada	228.682	105.522	123.160
Alquería del Fargue	492	239	253
Bobadilla	373	216	157
Cerrillo de Maracena	1.949	930	1.019
Granada	223.857	103.184	120.673
Lancha del Genil	1.574	753	821
Población en diseminados	437	200	237
Distrito Zaidín	42.163	19.518	22.645

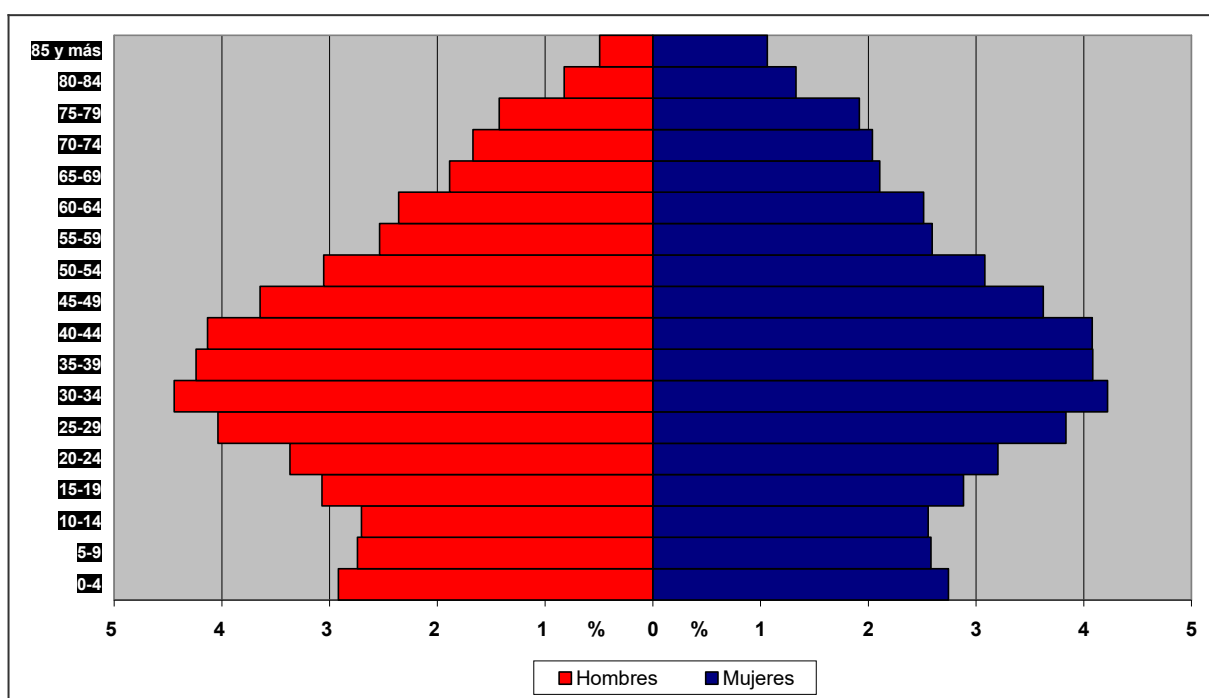
3.2.- Estructura Socio-Demográfica

El municipio de Granada cuenta en la actualidad con los siguientes datos:

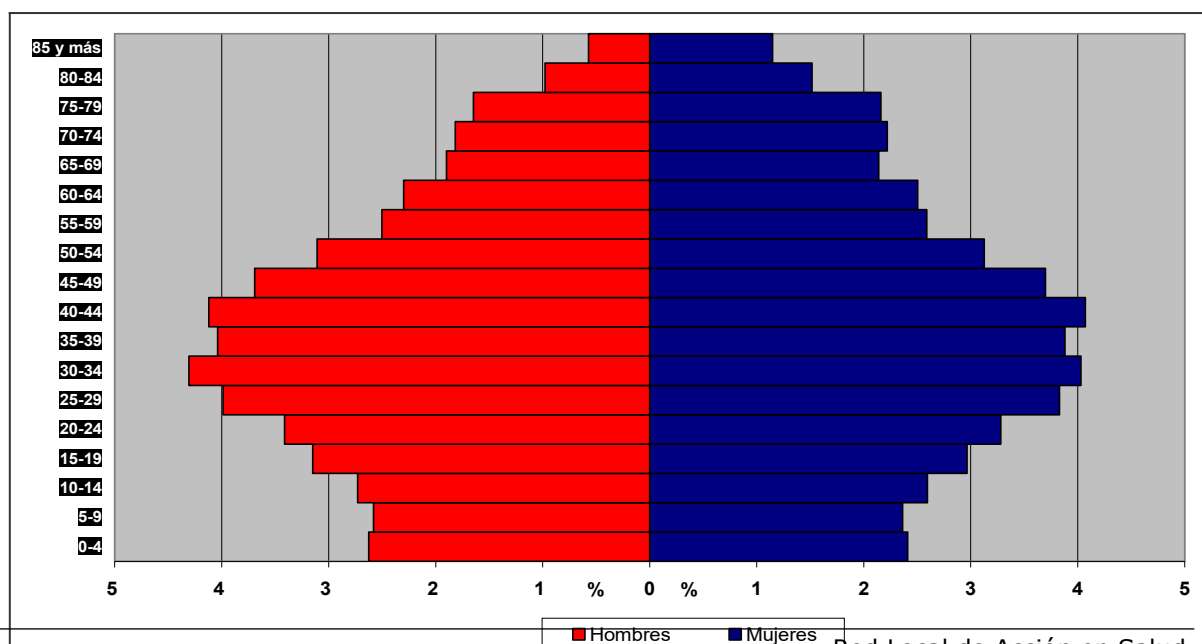
La densidad de población se sitúa en 2.631,93 hab/Km², muy por encima de la media provincial y de Andalucía (73 hab/Km² y 96 hab/Km² respectivamente).

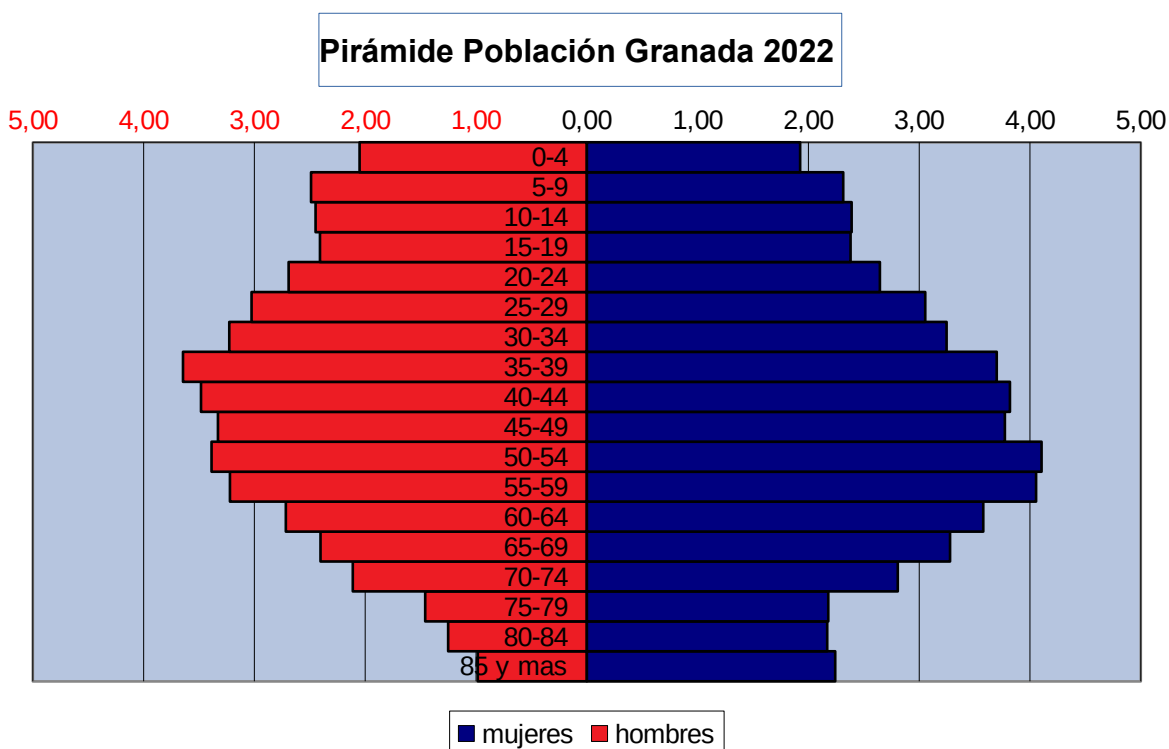
A continuación, la pirámide de población muestra la estructura por edad y sexo de la población de Granada y comparándola con la provincia de Granada y Andalucía (pirámides de población de elaboración propia con datos extraídos del INE):

Pirámide Población Andalucía 2022



Pirámide Población Granada Provincia 2022



**Comentario:**

La pirámide de población de Granada capital, tiene un perfil regresivo, debido al progresivo envejecimiento de su población; intensificándose de forma paulatina por la reducción de población en favor del área metropolitana.

Si la comparamos la Provincia de Granada y Andalucía, tienen un perfil muy similar, mientras que en la capital, cabe destacar el perfil más que regresivo, sobre todo, en la parte alta, donde se concentra una gran proporción de personas mayores (destacando las mujeres), mientras que la base y los tramos de edad intermedios es ligeramente inferior.

3.2.1.- Análisis indicadores socio-demográficos A continuación se realiza un análisis comparativo de una serie de indicadores sociodemográficos *(en algunos casos, no se tiene disponible, los datos a nivel del Distrito Censal del Zaidín)*.

3.2.1.1.- Edad Media Población La media de edad, resume en un sólo número la distribución por edades de de una población. Se obtiene dividiendo la suma total de las edades de todas las personas que la componen, por el número de dichas personas. En esta tabla, se recoge la edad media de algunos municipios que forman parte de RELAS

Municipios	Edad Media
Alfacar	42,06
Armillá	39,97
Baza	43,51
Benamaurel	45,82
Cenes de la Vega	40,13
Cúllar	48,00
Cúllar Vega	39,01
Fuente Vaqueros	42,22
Granada (capital)	44,92
Guadix	43,25
Huéscar	45,98
Huétor Tájar	41,00
La Zubia	40,97
Las Gubias	37,87
Loja	42,91
Montefrío	46,51
Moraleda de Zafayona	44,32
Motril	41,19
Padul	42,04
Pinos Puente	42,87
Salar	43,00
Santa Fe	41,99
Granada Provincia	43,10
DS Granada-Metrop.	42,51

Comentario: *La edad media de Granada capital, se sitúa por encima de la media provincial, con valores similares a los municipios más envejecidos de la provincia, la zona nordeste fundamentalmente, frente a la mayoría de los municipios del área metropolitana con una edad media por debajo de los 40 años. Destacar el progresivo aumento de la edad media, asociado a múltiples factores, como vendrá corroborado en el análisis de los indicadores relacionados con el movimiento natural de la población (natalidad, mortalidad, fecundidad, dependencia....).*

3.2.1.2.- Población extranjera. El volumen de población extranjera es de 18.125 personas. Del total de población extranjera, un 25% corresponden a personas procedentes de Marruecos. En este caso, veamos la comparativa con algunos municipios RELAS (tasa población extranjera):

Municipios	Tasa Población extranjera
Alfacar	2,95
Arenas del Rey	14,74
Armillá	8,33
Baza	7,47
Benalúa	1,25
Benamaurel	6,09
Cenes de la Vega	6,38
Chauchina	2,74
Cúllar	5,47
Cúllar Vega	4,53
Fuente Vaqueros	4,30
Granada (capital)	7,96
Guadix	5,47
Huéscar	3,03
Huétor Tájar	6,62
La Zubia	4,50
Las Gubias	5,00
Loja	5,39
Monachil	6,22
Montefrío	6,62
Moraleda de Zafayona	4,35
Motril	9,62
Padul	4,32
Pinos Puente	2,10
Salar	2,05
Santa Fe	4,51
Provincia Granada	7,31
DS Granada-Metrop.	5,92
Zaidín	9,22

Comentario:

El volumen de población extranjera en la capital, se sitúa por debajo de la media provincial, manteniendo la tendencia de todos los municipios, al haber perdido población extranjera en los últimos años. Y para el Distrito Zaidín, destaca el hecho de que se sitúa en torno al 10%, por encima de la tasa provincial.

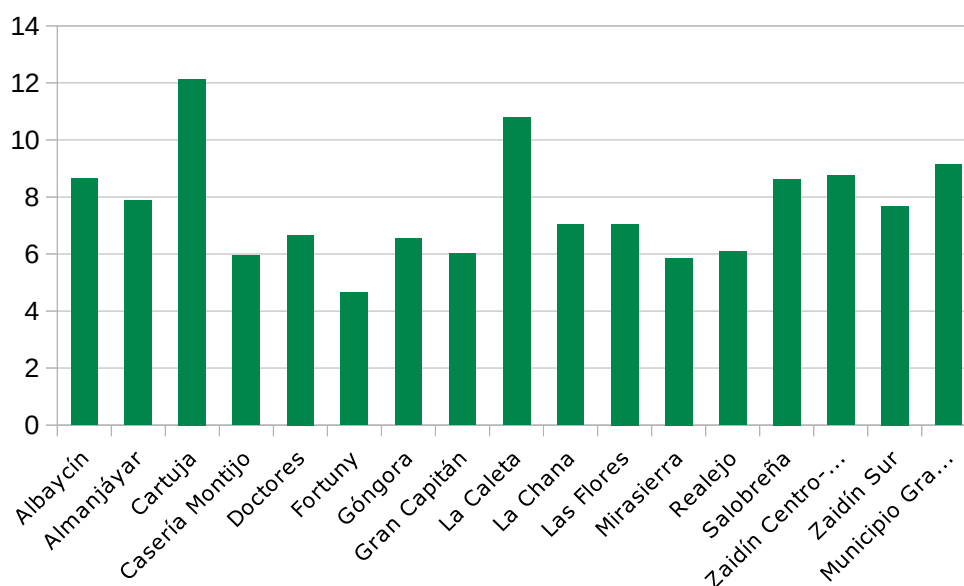
3.2.1.3.- Movimientos Naturales de Población (MNP)

1. Tasa Bruta de Natalidad (TBN): En la siguiente gráfica queda reflejada la TBN

municipios	TBN
Alfacar	8,00
Arenas del Rey	3,21
Armillá	9,14
Baza	8,19
Benalúa	7,30
Benamaurel	9,63
Cenes de la Vega	6,60
Chauchina	9,78
Cúllar	6,86
Cúllar Vega	7,38
Fuente Vaqueros	10,65
Granada (capital)	7,64
Guadix	7,53
Huéscar	7,88
Huétor Tájar	8,94
La Zubia	7,50
Las Gubias	9,48
Loja	7,62
Monachil	7,25
Montefrío	7,87
Moraleda de Zafayona	3,86
Motril	8,44
Padul	7,95
Pinos Puente	9,24
Salar	5,69
Santa Fe	6,46
Provincia Granada	7,65
DS Granada-Metrop.	7,81

La siguiente tabla, muestra la TBN de la ciudad de Granada por Unidad de Gestión Clínica (UGC). (Ver su correspondencia por barrios en el Mapa Sanitario, apartado 7.1.)

Tasa Bruta Natalidad TBN 2017



2. Tasa Bruta de Mortalidad (TBM): En la siguiente gráfica queda reflejada la TBM comparada con municipios de la provincia:

municipios	tbm
Alfacar	11,10
Arenas del Rey	14,42
Armillá	6,64
Baza	10,35
Benalúa	12,77
Benamaurel	13,13
Cenes de la Vega	6,23
Chauchina	8,53
Cúllar	14,95
Cúllar Vega	7,90
Fuente Vaqueros	11,55
Granada (capital)	12,59
Guadix	10,89
Huéscar	17,00
Huétor Tájar	10,75
La Zubia	7,65
Las Gabias	5,58
Loja	10,36
Monachil	7,37
Montefrío	15,37
Moraleda de Zafayona	9,98
Motril	8,68
Padul	8,95
Pinos Puente	13,50
Salar	12,51
Santa Fe	11,00
Provincia Granada	10,42
DS Granada-Metrop.	10,10

4. Índice de Dependencia (ID), refleja la proporción: *Población joven 0-15 años + Población más de 65/Población adulta 16-64 años) x 100*

municipios	indice dependencia
Alfacar	43,60
Arenas del Rey	45,12
Armillá	42,11
Baza	52,02
Benalúa	56,17
Benamaurel	64,32
Cenes de la Vega	36,92
Chauchina	50,82
Cúllar	63,16
Cúllar Vega	42,87
Fuente Vaqueros	49,76
Granada (capital)	56,73
Guadix	51,86
Huéscar	58,86
Huétor Tájar	46,48
La Zubia	43,95
Las Gabias	42,14
Loja	50,78
Monachil	44,27
Montefrío	54,18
Moraleda de Zafayona	52,33
Motril	49,40
Padul	47,01
Pinos Puente	54,36
Salar	57,02
Santa Fe	51,15
Provincia Granada	48,66
DS Granada-Metrop.	49,38

Comentario:

Mide la proporción de personas que no están en edad legal para trabajar sobre las que si lo están; se sitúa en la media provincial, aunque superada por los municipios de la zona nordeste de la provincia, y por encima de los municipios del área metropolitana. Muestra el progresivo envejecimiento de Granada frente a los municipios de los alrededores.

5. El índice de juventud (población menor de 16 años frente a la población total).

municipios	Índice juventud
Alfacar	13,90
Arenas del Rey	7,85
Armilla	15,73
Baza	14,09
Benalúa	16,90
Benamaurel	14,27
Cenes de la Vega	14,69
Chauchina	17,44
Cúllar	11,11
Cúllar Vega	17,26
Fuente Vaqueros	14,65
Granada (capital)	13,08
Guadix	14,48
Huéscar	12,51
Huétor Tájar	15,33
La Zubia	15,26
Las Gubias	18,61
Loja	14,49
Monachil	14,89
Montefrío	10,83
Moraleda de Zafayona	13,30
Motril	16,04
Padul	14,60
Pinos Puente	15,29
Salar	15,05
Santa Fe	15,66
Provincia Granada	14,47
DS Granada-Metrop.	14,82

Comentario:

De los municipios analizados, Granada tiene una pérdida progresiva de población joven.

6. La tasa de envejecimiento, refleja el porcentaje de población mayor de 65 años sobre la población total:

municipios	Tasa envejecimiento
Alfacar	15,34
Arenas del Rey	22,76
Armillá	12,64
Baza	19,04
Benalúa	17,76
Benamaurel	24,04
Cenes de la Vega	10,82
Chauchina	14,78
Cúllar	26,72
Cúllar Vega	11,17
Fuente Vaqueros	17,26
Granada (capital)	22,14
Guadix	18,52
Huéscar	23,42
Huétor Tájar	15,31
La Zubia	14,04
Las Gabias	9,83
Loja	18,06
Monachil	14,50
Montefrío	23,37
Moraleda de Zafayona	19,86
Motril	15,75
Padul	16,25
Pinos Puente	18,93
Salar	20,13
Santa Fe	16,83
Provincia Granada	18,27
DS Granada-Metrop.	17,58

7. Incremento relativo de población 2022-2011

municipios	
Alfacar	-0,45
Arenas del Rey	-222,38
Armillá	7,36
Baza	-4,91
Benalúa	-1,81
Benamaurel	-6,03
Cenes de la Vega	4,12
Chauchina	18,99
Cúllar	-10,32
Cúllar Vega	11,91
Fuente Vaqueros	-1,49
Granada (capital)	-4,41
Guadix	-1,92
Huéscar	-10,20
Huétor Tájar	3,81
La Zubia	5,38
Las Gabias	13,84
Loja	-3,37
Monachil	8,97
Montefrío	-12,75
Moraleda de Zafayona	-4,59
Motril	-3,27
Padul	5,18
Pinos Puente	-33,08
Salar	-5,37
Santa Fe	-0,69
Provincia Granada	-0,08
DS Granada-Metrop.	1,53

Comentario:

Granada capital ha ido perdiendo población de forma progresiva en los últimos 10-12 años. En el período 2011-2022, ha perdido un 4,41%, que se traduce en unos 12 mil. habitantes, ganando población los municipios del área metropolitana.

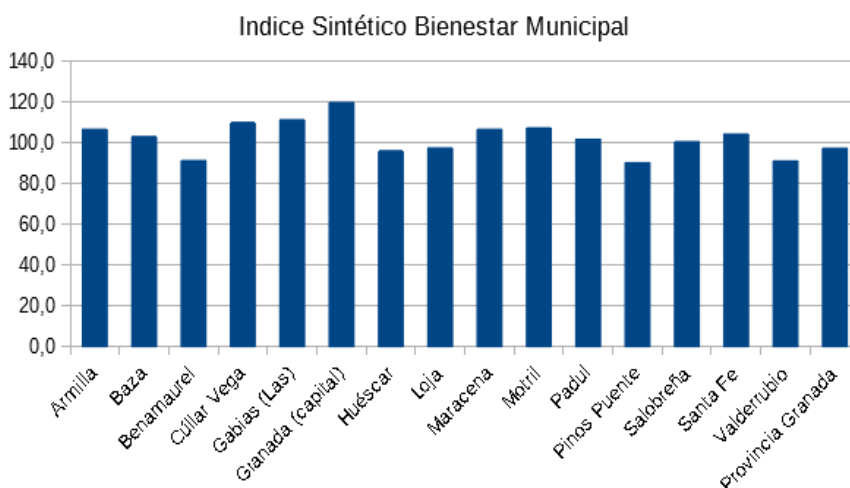
En el conjunto de la provincia de Granada, también ha ido perdiendo población, como consecuencia de diferentes factores, entre ellos, la vuelta de la población extranjera a su países de origen u otros destinos y la emigración.

3.3.- Indicadores Económicos

Indicador	Granada
Índice sintético de bienestar	119,7
Nº de hombres parados	10.718
Nº de mujeres paradas	12.665
Nº establecimientos con actividad económica de 20 y más trabajadores/as sobre el total de establecimientos	526
Nº establecimientos con actividad económica de 6-19 trabajadores/as sobre el total de establecimientos	1557
Nº establecimientos con actividad económica hasta 5 trabajadores/as sobre el total de establecimientos	20.253
Nº total de parados	23.383
Renta bruta per cápita	16.954,2
Tasa de vehículos por habitantes	0,74
Total de Restaurantes	327
Total Plazas de los Establecimientos hoteleros (se incluye hoteles, hostales y pensiones)	14.448

3.3.1.- Análisis comparativo indicadores económicos (selección):

a. Indicador Sintético de Bienestar Municipal (ISBM)



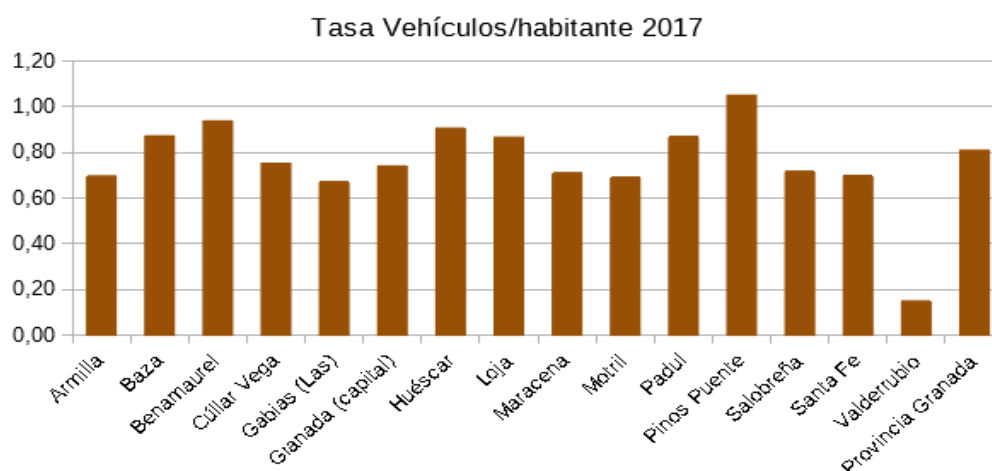
Fuente: Boletín economía andaluza <https://www.analistaseconomicos.com/>

Comentario:

Este indicador recoge una amalgama de recursos a todos los niveles para “sumarlos” de alguna manera y analizar que volumen de recursos, servicios,...que están a disposición de la ciudadanía en los municipios en los que habitan.

Granada capital se sitúa por encima de todos los municipios analizados, dado que es dónde se encuentran gran parte de los recursos y servicios públicos y privados.

Le sigue muy de cerca aquellos municipios situados en el área metropolitana, frente a aquellos que se localizan más lejanos, que el índice es muy inferior.

b. Tasa Vehículos/habitante

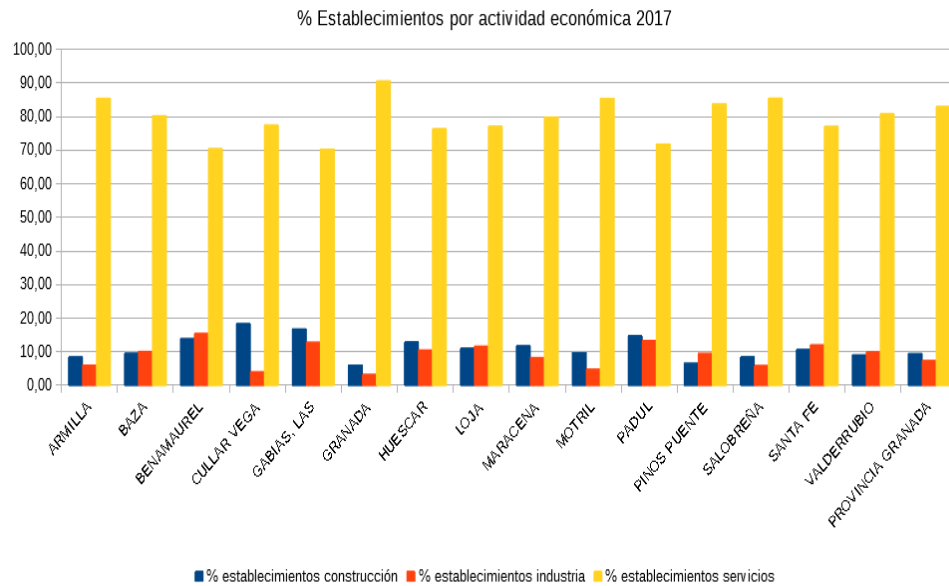
Fuente: IECA y datos elaboración propia

Comentario:

La tasa de vehículos por habitante es un indicador que incide sobre los estilos de vida y el medio ambiente, repercutiendo en posibles problemas de salud/factores de riesgo derivados de unos hábitos de vida muy sedentarios, al emplear el vehículo muy frecuentemente y también pueden repercutir sobre la calidad del aire y de nuestro medio ambiente (contaminación ambiental y acústica fundamentalmente).

La tasa en Granada capital se sitúa en 0,74 vehículos/habitante, en algunos municipios de los alrededores la tasa de vehículos es superior a 1, es decir, que existen más vehículos censados que habitantes empadronados, incidiendo en lo que anteriormente hemos expuesto.

c. Establecimientos por actividad económica



Comentario: La tendencia se mantiene en todos los municipios analizados, más del 70-80 % de los establecimientos están dedicados al sector servicios. En el caso de Granada capital, el valor supera el 90%, sobre todo, establecimientos de hostelería y turísticos.

d. Otros recursos incluidos

municipio	Centros Educativos Infantil	Centros Educativos Primaria	Centros Educativos Secundaria y superiores	Centros Educación Especial
Armillá	6	4	8	3
Baza	6	4	14	4
Benamaurel	1	1	1	2
Cúllar Vega	1	1	1	0
Gabias (Las)	2	2	4	2
Granada	52	33	83	17
Huésca	4	3	10	1
Loja	9	8	13	3
Maracena	5	3	2	1
Motril	16	13	29	7
Padul	3	2	2	1
Pinos Puente	5	3	6	2
Salobreña	5	3	5	2
Santa Fe	4	3	8	2
Valderrubio	1	1	0	0

Comentario: Gran parte de los recursos incluidos en estas tablas se localizan en Granada capital, dónde se concentran gran parte los servicios públicos de la provincia.

municipio	programa creciendo en salud nº centros educativos	puntos forma joven centros educativos	puntos forma joven externos	Rutas de Vida Sana	proyecto RELAS	Centros de Adultos	Centros de participación activa (centros de día de mayores)	Plazas Residencias 3ª Edad
Armillá	2	2		1	1	1		210
Baza	2	2		2	1	1	1	674
Benamaurel	1	1			1	1		32
Cúllar Vega	1	1		1	1			387
Gabias (Las)	2	1	1		1	1	1	-
Granada	27	16	15		1	5	12	-
Huésca		2	1		1	1		313
Loja	5	3	1	4	1	1		536
Maracena		1		2	1	1		417
Motril	14	5	2		1	1	1	
Padul	2	1		1	1	1		41
Pinos Puente	6	2		3	1	1	1	145
Salobreña	3	2			1	1		
Santa Fe	2	2		1	1	1	1	30
Valderrubio					1			

Relación de centros educativos Municipio Granada

Nombre	Enseñanzas
Centro autorizado de enseñanzas artísticas elementales de música Orfeo	MUS
Centro autorizado de enseñanzas artísticas profesionales de música SCAEM	MUS
CENTRO AUTORIZADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Escuela CRBC-Granada	CRBC
Centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de diseño ESADA	APD
Centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de diseño ESADA II	APD
Centro autorizado de Enseñanzas Deportivas Sierra Nevada	ED
Centro autorizado de Enseñanzas Deportivas Centro de Formación Académica de Entrenadores de Fútbol (ACADEF)	ED
Centro autorizado de Enseñanzas Deportivas Iundenia	ED
Centro autorizado de Enseñanzas Deportivas Tándem	ED
Centro autorizado de Enseñanzas Deportivas The Play Coach	ED
Centro de Convenio Arlequín	Inf
Centro de Convenio Belén	Inf
Centro de Convenio Duende	Inf
Centro de Convenio Luna	Inf EE
Centro de Educación Infantil Aldeas Infantiles SOS	Inf
Centro de Educación Infantil Amanecer	Inf
Centro de Educación Infantil Bola de Oro	Inf
Centro de Educación Infantil Bubú	Inf
Centro de Educación Infantil Caracoles	Inf
Centro de Educación Infantil Centro de Atención Familiar	Inf
Centro de Educación Infantil Centro Infantil Abierto "Luden"	Inf
Centro de Educación Infantil Chiquitines	Inf
Centro de Educación Infantil Churretes	Inf
Centro de Educación Infantil Colorines	Inf
Centro de Educación Infantil El Recreo	Inf
Centro de Educación Infantil Garabatos	Inf
Centro de Educación Infantil Garabatos de Arabial	Inf
Centro de Educación Infantil La Cartuja	Inf
Centro de Educación Infantil Los Ángeles	Inf
Centro de Educación Infantil Luna Lunera	Inf
Centro de Educación Infantil Mami	Inf
Centro de Educación Infantil Mar de Ágata	Inf
Centro de Educación Infantil María Inmaculada	Inf
Centro de Educación Infantil Mi Muñeco	Inf
Centro de Educación Infantil Pasito a Pasito	Inf
Centro de Educación Infantil Pizarrín	Inf

Centro de Educación Infantil Sagrada Familia	Inf
Centro de Educación Infantil San Francisco Javier	Inf
Centro de Educación Infantil Snoopy	Inf
Centro de Educación Infantil Virgen de Montserrat	Inf
Centro de Educación Infantil Virgen del Pilar	Inf
Centro de Educación Infantil Virgen Madre	Inf
Centro de Educación Permanente Albayzín	ADU
Centro de Educación Permanente Almanjáyar-Cartuja	ADU
Centro de Educación Permanente San Matías	ADU
Centro de Educación Permanente Zaidin-Fuentenueva	ADU
Centro Docente Privado Academia Teba	FPE
Centro Docente Privado Alcazaba Superior	FPE
Centro Docente Privado Alhamar	CFGM FPE
Centro Docente Privado Alquería	Inf Pri
Centro Docente Privado Amor de Dios	Inf Pri ESO CFGM EE FPE
Centro Docente Privado Atlántida Centro de Investigación y Desarrollo de Estudios Profesionales	CFGM FPE
Centro Docente Privado Ave María-Casa Madre	Inf Pri ESO BAC EE
Centro Docente Privado Ave María-La Quinta	Inf Pri ESO EE
Centro Docente Privado Ave María-San Cristóbal	Inf Pri ESO BAC CFGM EE FPE
Centro Docente Privado Ave María-San Isidro	Inf Pri ESO EE
Centro Docente Privado Ave María-Vistillas	Inf Pri ESO EE
Centro Docente Privado Bucle, Centro de Formación de Peluquería y Estética	CFGM
Centro Docente Privado Caja General de Ahorros	Pri ESO EE
Centro Docente Privado Campus Formación CB	CFGM FPE
Centro Docente Privado Centro de Estudios Hermanos Naranjo	CFGM FPE
Centro Docente Privado Centro de Estudios Jurídicos Granada	FPE
Centro Docente Privado Centro de Estudios Jurídicos Granada II	FPE
Centro Docente Privado Centro de Estudios Jurídicos Granada III	FPE
Centro Docente Privado Centro de Estudios Técnicos en Sanidad	CFGM
Centro Docente Privado Centro de Formación F.A.A.S.	FPE
Centro Docente Privado Centro de Formación Internacional Reina Isabel	CFGM FPE
Centro Docente Privado Centro de Formación Profesional La Inmaculada	CFGM FPE
Centro Docente Privado Centro de Formación Profesional Napoleón	FPE
Centro Docente Privado Centro de Formación y Atención Social Averroes	FPE
Centro Docente Privado Cerrillo de Maracena	Inf Pri EE
Centro Docente Privado Ciudad de los Niños	Inf Pri ESO CFGM EE

Centro Docente Privado Compañía de María	Inf	Pri	ESO	EE	
Centro Docente Privado Cristo Rey	BAC	FPE			
Centro Docente Privado Cruz Roja	CFGM	FPE			
Centro Docente Privado Curva Polar Escuela Técnica de Imagen y Sonido	FPE				
Centro Docente Privado Didacta	FPE				
Centro Docente Privado Divino Maestro	Inf				
Centro Docente Privado Divino Maestro	Pri	ESO	EE		
Centro Docente Privado Dulce Nombre de María	Inf	Pri	ESO	BAC	EE
Centro Docente Privado EAAI Formación Profesional	FPE				
Centro Docente Privado El Carmelo	Inf	Pri	ESO	BAC	EE
Centro Docente Privado Escolapios Cartuja Luz Casanova	Inf	Pri	ESO	EE	
Centro Docente Privado Escuela Arte Granada, Centro de Formación	FPE				
Centro Docente Privado Escuela Internacional de Gerencia	FPE				
Centro Docente Privado Escuela Internacional de Protocolo	FPE				
Centro Docente Privado Escuela Técnica Audiovisual de Andalucía	FPE				
Centro Docente Privado Galilea Centro de Formación	FPE				
Centro Docente Privado Gaviota	Inf	EE			
Centro Docente Privado Grupo 7	CFGM	FPE			
Centro Docente Privado Inmaculada Niña	Inf	Pri	ESO	BAC	EE
Centro Docente Privado Instituto Europeo de Formación y Empleo	FPE				
Centro Docente Privado Jesús y María-Cristo de la Yedra	Inf	Pri	ESO	EE	
Centro Docente Privado Jobesa Granada	FPE				
Centro Docente Privado Jorbalán	CFGM				
Centro Docente Privado Juan XXIII-Cartuja	Inf	Pri	ESO	BAC	EE
Centro Docente Privado Juan XXIII-Chana	Inf	Pri	ESO	BAC	EE
Centro Docente Privado Juan XXIII-Zaidín	Inf	Pri	ESO	BAC	EE
Centro Docente Privado La Asunción	Inf	Pri	ESO	EE	
Centro Docente Privado La Inmaculada	Pri	ESO	BAC	EE	
Centro Docente Privado La Presentación de Nuestra Señora	Inf	Pri	ESO	BAC	EE
Centro Docente Privado Luisa de Marillac	Inf	Pri	EE		
Centro Docente Privado María Nebrera	CFGM	FPE			
Centro Docente Privado María Nebrera	Inf	Pri			
Centro Docente Privado MEDAC Almenara	CFGM	FPE			
Centro Docente Privado Monaita	Inf	Pri	ESO	BAC	
Centro Docente Privado Mulhacén	Pri	ESO	BAC		
Centro Docente Privado Nazaret	Inf				
Centro Docente Privado Nuestra Señora de la Consolación	Inf	Pri	ESO	EE	

Centro Docente Privado Nuestra Señora de las Mercedes	Inf	Pri	ESO	EE
Centro Docente Privado Nuestra Señora del Rosario	Inf	Pri	ESO	
Centro Docente Privado Padre Manjón	Inf	Pri	ESO	EE
Centro Docente Privado Progreso			ESO	BAC
Centro Docente Privado Regina Mundi	Inf	Pri	ESO	BAC EE
Centro Docente Privado Sagrada Familia	Inf	Pri	ESO	BAC EE
Centro Docente Privado Sagrado Corazón	Inf	Pri	ESO	BAC EE
Centro Docente Privado San Agustín	Inf	Pri	EE	
Centro Docente Privado San Francisco Javier			Inf	
Centro Docente Privado San Isidoro	Inf	Pri	ESO	BAC
Centro Docente Privado San José	Inf	Pri	ESO	EE
Centro Docente Privado San Juan Bosco	Inf	Pri	ESO	BAC CFGM EE FPE
Centro Docente Privado Santa Cristina	Inf	Pri	ESO	EE
Centro Docente Privado Santa María	Inf	Pri	ESO	EE
Centro Docente Privado Santa María Micaela	Inf	Pri	EE	
Centro Docente Privado Santa Marta			Inf	Pri
Centro Docente Privado Santa Rosalía			Inf	
Centro Docente Privado Santiago Ramón y Cajal			ESO	BAC CFGM EE FPE
Centro Docente Privado Santo Domingo	Inf	Pri	ESO	BAC
Centro Docente Privado Santo Tomás de Villanueva	Inf	Pri	ESO	BAC EE
Centro Docente Privado UDS Granada				CFGM FPE
Centro Docente Privado Virgen de Gracia	Inf	Pri	ESO	BAC EE
Centro Docente Privado Virgen de las Angustias			Inf	Pri
Centro Docente Privado Virgen del Pilar II			Inf	
Centro Docente Privado Virgen Madre II			Inf	
Centro Docente Privado de Educación Especial Clínica San Rafael			EE	
Centro Docente Privado de Educación Especial Purísima Concepción			EE	
Centro Docente Privado de Educación Especial Sagrada Familia			EE	
Centro Docente Privado de Educación Especial Santa Teresa de Jesús			EE	
Centro público integrado de formación profesional Aynadamar			CFGM	FPE
Centro público integrado de formación profesional Hurtado de Mendoza			CFGM	FPE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Abencerrajes	Inf	Pri	EE	
Colegio de Educación Infantil y Primaria Alcazaba	Inf	Pri	EE	
Colegio de Educación Infantil y Primaria Andalucía	Inf	Pri	EE	
Colegio de Educación Infantil y Primaria Andrés Segovia	Inf	Pri	EE	
Colegio de Educación Infantil y Primaria Arrayanes	Inf	Pri	EE	

Colegio de Educación Infantil y Primaria Elena Martín Vivaldi	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Eugenia de Montijo	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Fuentenueva	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Gallego Burín	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria García Lorca	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Genil	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Gómez Moreno	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Inmaculada del Triunfo	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Jardín de la Reina	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria José Hurtado	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Jiménez	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Cármenes	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Rosales	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria María Zambrano	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Hernández	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Parque de las Infantas	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Parque Nueva Granada	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Profesor Tierno Galván	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Reyes Católicos	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria San José	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria San Juan de Dios	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Sancho Panza	Inf	Pri	
Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Juliana	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Sierra Elvira	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Sierra Nevada	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Aleixandre	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Victoria Eugenia	Inf	Pri	EE
Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de las Nieves	Inf	Pri	EE
Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía		DAN	
Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios		MUS	
Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia		MUS	
Escuela de Arte	BAC	APD	
Escuela Infantil Almanjáy	Inf		
Escuela Infantil Asunción Linares	Inf		
Escuela Infantil Cristo de la Yedra	Inf		
Escuela Infantil El Príncipe	Inf		
Escuela Infantil Generalife	Inf	EE	
Escuela Infantil Juan Latino	Inf		

Escuela Infantil Los Mondragones	Inf
Escuela Infantil Portal de Belén	Inf
Escuela Infantil Santo Domingo	Inf
Escuela Infantil Virgen de Loreto	Inf
Escuela Infantil Virgen del Carmen	Inf
Escuela Infantil Virgen Inmaculada	Inf
Escuela Oficial de Idiomas Granada	ID I
Instituto de Educación Secundaria Albayzín	ESO BAC CFGM FPE
Instituto de Educación Secundaria Alhambra	ESO BAC EE FPE
Instituto de Educación Secundaria Ángel Ganivet	ESO BAC CFGM FPE
Instituto de Educación Secundaria Cartuja	ESO BAC CFGM EE FPE
Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala	ESO BAC CFGM EE FPE
Instituto de Educación Secundaria Fray Luis de Granada	ESO BAC FPE
Instituto de Educación Secundaria Generalife	ESO BAC FPE
Instituto de Educación Secundaria La Madraza	ESO BAC CFGM EE
Instituto de Educación Secundaria La Paz	ESO
Instituto de Educación Secundaria Mariana Pineda	ESO BAC EE
Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes	ESO BAC FPE
Instituto de Educación Secundaria Padre Manjón	ESO BAC CFGM FPE
Instituto de Educación Secundaria Padre Suárez	ESO BAC CFGM
Instituto de Educación Secundaria Pedro Soto de Rojas	ESO BAC CFGM EE FPE
Instituto de Educación Secundaria Politécnico Hermenegildo Lanz	ESO BAC CFGM FPE
Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa	ESO BAC CFGM EE
Instituto de Educación Secundaria Veleta	ESO EE
Instituto de Educación Secundaria Virgen de las Nieves	ESO BAC CFGM FPE
Instituto de Educación Secundaria Zaidín-Vergeles	ESO BAC CFGM FPE
Instituto Provincial de Educación Permanente Granada	ESO BAC AD U
Sección de Educación Permanente Chana	AD U

4. Análisis Epidemiológico

La información que aporta la Epidemiología contribuye al conocimiento de la situación de salud una población y es una ayuda importante para la planificación y diseño de las estrategias de intervención para el control de los distintos problemas de Salud Pública.

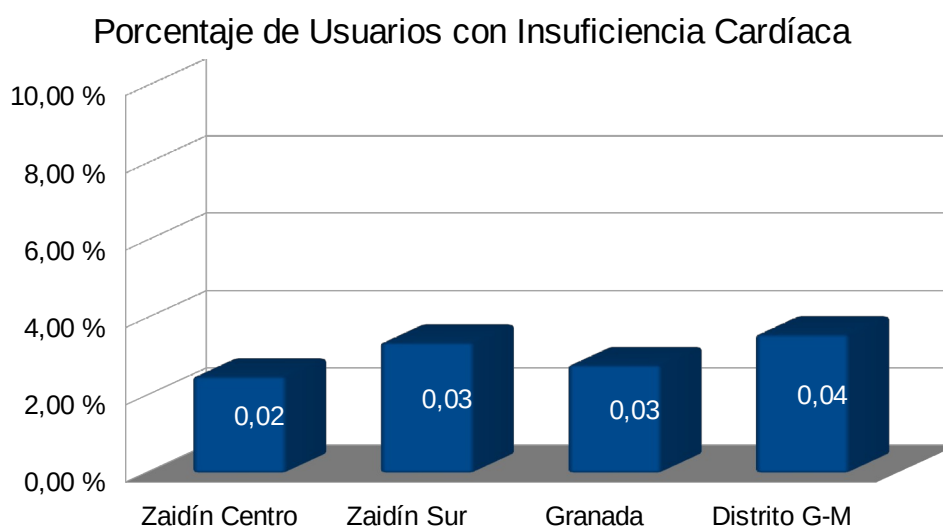
4.1 Morbilidad y principales problemas de salud.

La Morbilidad es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es un dato estadístico de importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.

4.1.1.-Enfermedades Crónicas: Las enfermedades crónicas, según la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta, como las cardiovasculares y respiratorias, el cáncer o la diabetes mellitus. Son patologías para las cuales aún no se conoce una solución definitiva, relacionándose con el 63% de las muertes en el mundo. Se han seleccionado las patologías crónicas más prevalentes y de mayor relevancia.

La distribución de estas enfermedades crónicas entre la población del barrio del Zaidín de Granada y en sus correspondientes Unidades Asistenciales del Zaidín Centro y Sur puede verse a continuación:

Insuficiencia Cardíaca (IC): Durante el año 2021, el porcentaje de personas diagnosticadas de IC, en relación a los mayores de 65 años en la U.A. Zaidín Sur es ligeramente superior a U.A. Zaidín Centro y a la ciudad de Granada, aunque inferior a la del Distrito Sanitario Granada Metropolitano.

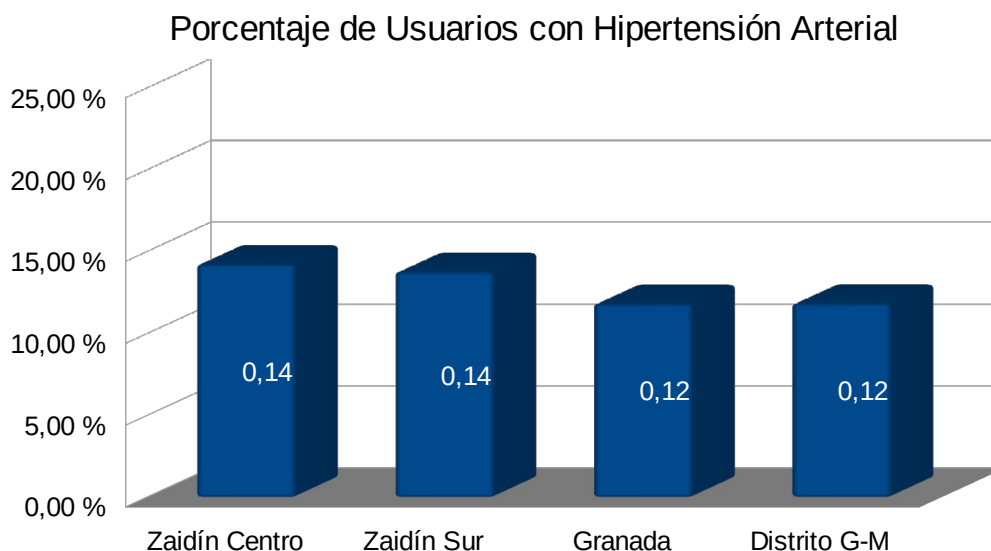


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas mayores de 65 años, incluidos en el Proceso Asistencial de Insuficiencia Cardíaca, año 2021.

- Hipertensión Arterial :

El porcentaje de personas hipertensas durante el año 2021, en las UA del Zaidín son similares entre ellas y ligeramente superiores a las de la ciudad de Granada y Distrito Sanitario Granada Metropolitano.

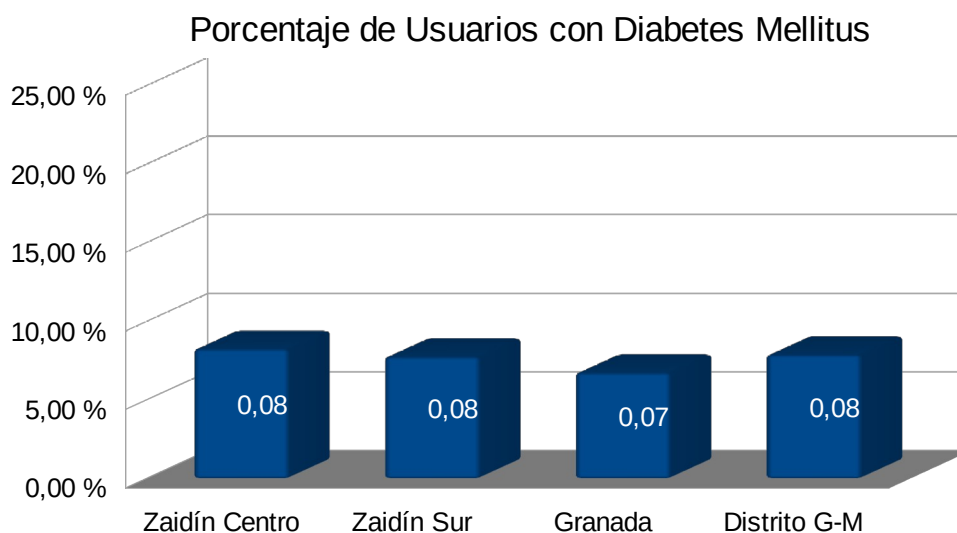


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas diagnosticadas de Hipertensión Arterial, año 2021.

- Diabetes Mellitus:

Durante 2021, el porcentaje de personas diabéticas es muy similar en los diferentes ámbitos geográficos, destacando ligeramente la UA Zaidín Centro.

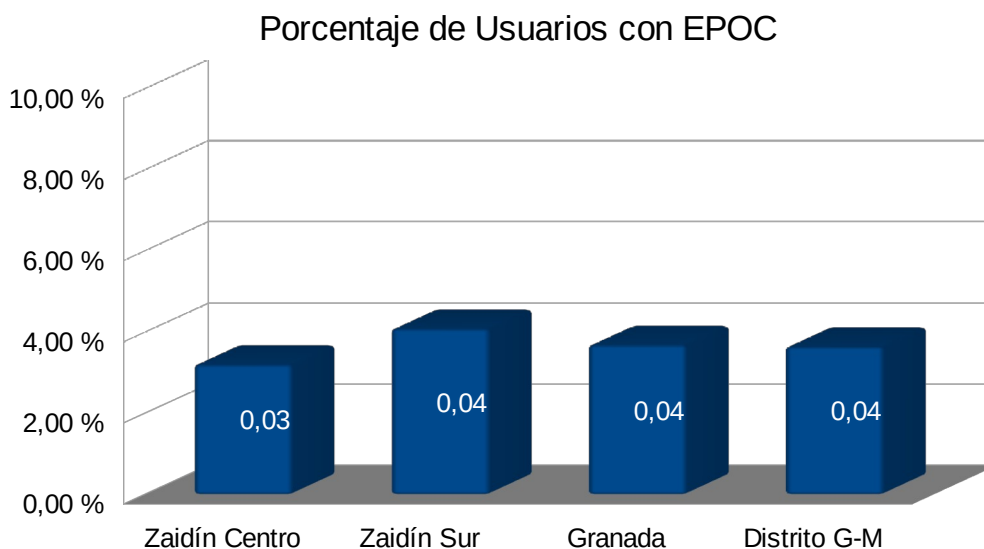


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas con Diabetes Mellitus, año 2021.

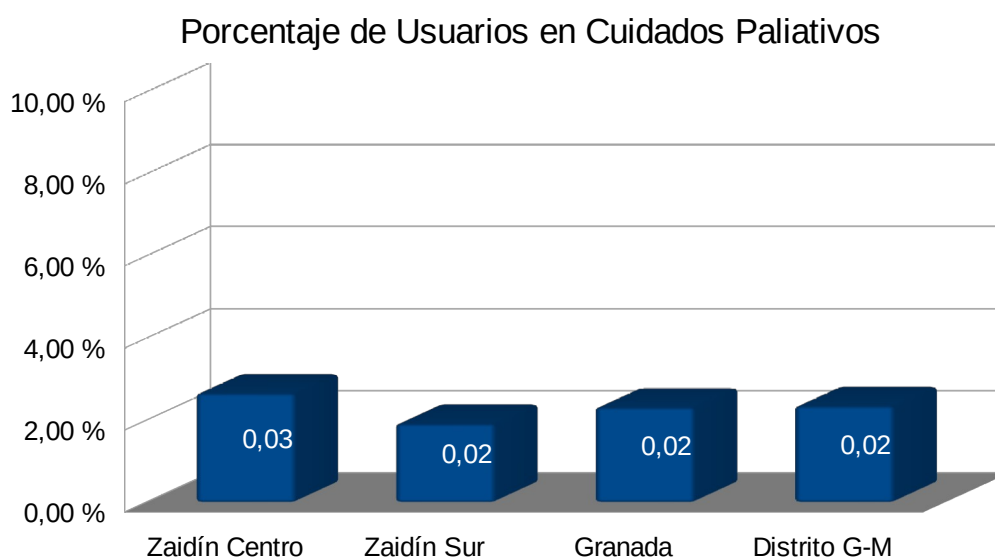
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC):

El porcentaje de personas con EPOC mayores de 40 años durante 2021, fue similar en los diferentes ámbitos geográficos; la mayor prevalencia se localiza en la UA Zaidín Sur.



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.
 Tabla: Porcentaje de personas diagnosticadas de EPOC, año 2021.

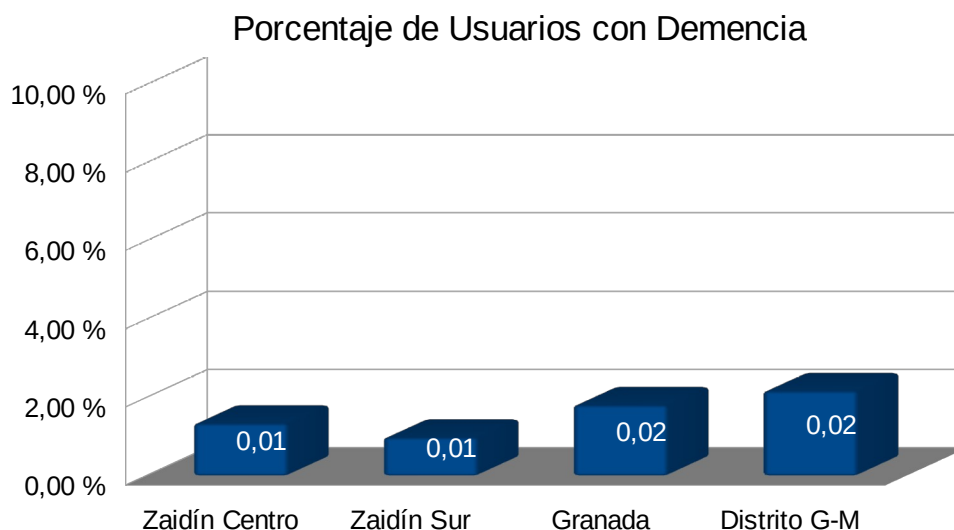
- Cuidados Paliativos: El porcentaje de personas incluidas en Cuidados Paliativos durante 2021, fue similar en los diferentes ámbitos geográficos; destaca ligeramente la prevalencia en la UA Zaidín Centro.



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.
 Tabla: Porcentaje de personas incluidas en Cuidados Paliativos, año 2021.

Demencias:

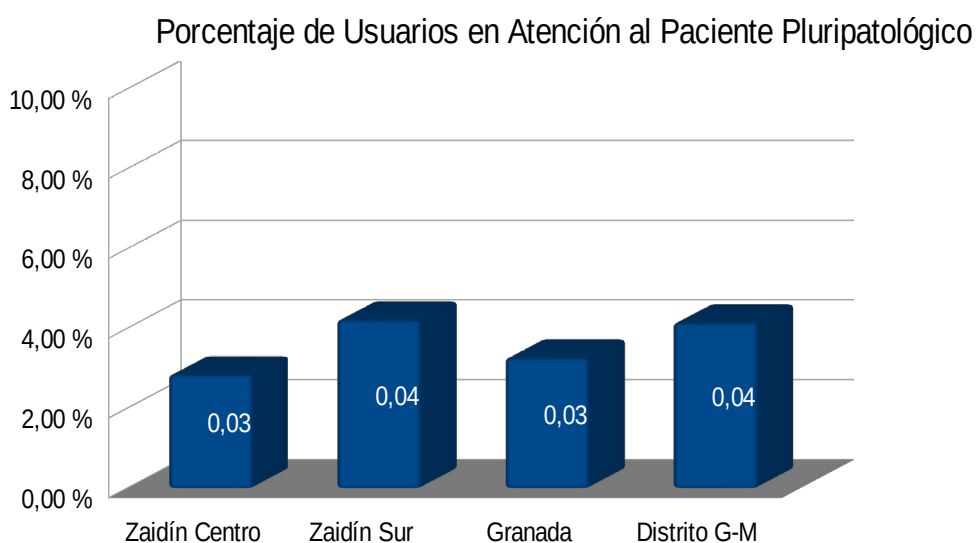
El porcentaje de personas diagnosticadas de Demencia, en relación a los mayores de 65 años en las UA del Zaidín, es inferior a las del Distrito Sanitario y ciudad de Granada. Estas cifras pueden estar vinculadas con la mayor existencia de Residencias de Mayores en otros ámbitos.



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.
 Tabla: Porcentaje de personas mayores de 65 años con Demencia, año 2021.

- Atención al Paciente Pluripatológico:

Las personas incluidas en el Proceso Asistencial Integrado de Atención al Paciente Pluripatológico (pacientes crónicos con necesidades complejas de salud), en relación a los mayores de 65 años, es inferior en a UA Zaidín Centro.

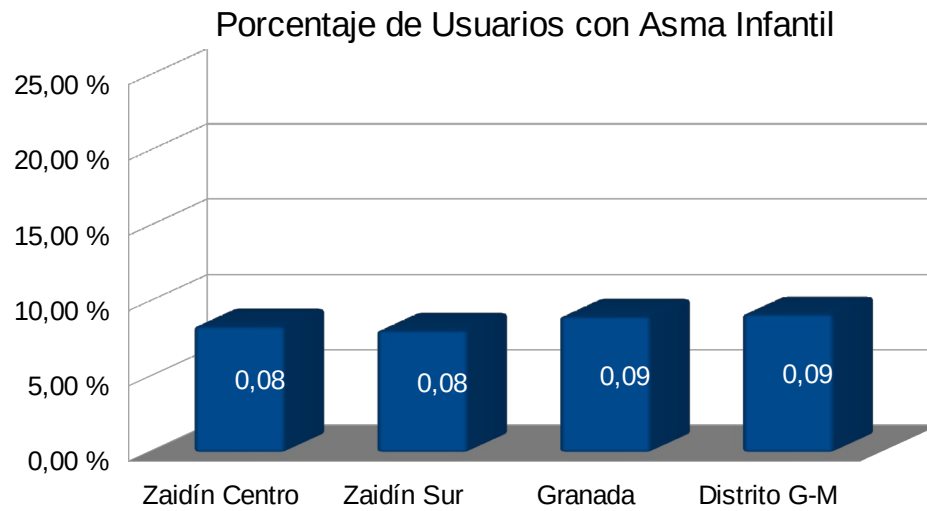


Fuente:

Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.
 Tabla: Porcentaje de personas mayores de 65 años incluidas en el Proceso de Atención al Paciente Pluripatológico, año 2021.

- Asma Infantil:

La prevalencia de Asma Infantil (menores de 14 años), es similar en los diferentes ámbitos geográficos, siendo ligeramente más baja en la UA Zaidín Sur.



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas menores de 14 años con diagnóstico de Asma Infantil, año 2021.

– 4.1.2.- Incidencia de Cáncer:

No hay estadísticas oficiales consistentes y fiables por barrios o Unidades Asistenciales, por lo que se analiza el municipio de Granada.

La incidencia de cánceres en la ciudad de Granada ha aumentado un 9% entre los quinquenios 2009/2013 al 2013/2017, debido fundamentalmente al crecimiento del cáncer de piel no melanoma, que es un tumor de buen pronóstico en general; así, la Tasa Bruta de incidencia pasó de 760 casos por 100.000 habitantes a 839, en el segundo quinquenio.

TIPO CÁNCER	Nº de Cánceres Hombres (2013-2017)	Nº de Cánceres Mujeres (2013-2017)	Nº de Cánceres Ambos Sexos (2013-2017)	Nº de Cánceres Ambos Sexos (2009-2013)	Tasas Brutas GRANADA (Municipio) Media anual (2013- 2017)
Piel (no melanoma)	1524	1437	2961	2190	251,2
Mama	10	984	994	867	155,8 (mujeres)
Colón-Recto	550	419	969	957	82,2
Próstata	719	-	719	795	131,4 (hombres)
Pulmón, Tráquea, Bronquios	491	153	644	596	54,6
Vejiga	436	111	547	533	46,4
Cerebro, Sistema Nervioso	94	136	230	271	19,5
Linfoma No Hodgkin	115	104	219	217	18,6
Útero (cuerpo)	-	219	219	211	34,7 (mujeres)
Melanoma de Piel	101	102	203	203	17,2
Total todos los Cánceres	5160	4732	9892	9046	839,2

Fuente: Registro de Cáncer de Granada. Tasas por 100.000 habitantes

Tabla- Incidencia y Tipos de Cáncer en el municipio de Granada, periodo 2013- 2017

En los hombres, para el periodo 2013-2017, los cánceres más frecuentes en Granada fueron el Cáncer de Piel no Melanoma, Cáncer de Próstata, de Colon-Recto, de Pulmón, de Vejiga y Linfoma No Hodgkin.

Si esta frecuencia de cánceres la comparamos en la misma población para el quinquenio 2009-2013, se comprueba que para los 6 tumores más frecuentes, han aumentado los cánceres de Piel no Melanoma y de Pulmón, mientras que el cáncer de Próstata ha descendido y se estabilizan el cáncer de Colon-Recto, de Vejiga y Linfoma No Hodgkin.

En las mujeres, para el periodo 2013-2017, los tumores más frecuentes fueron el Cáncer de Piel no Melanoma, de Mama, de Colon-Recto, de Útero, Pulmón y Cerebro. Si la comparamos con la frecuencia del quinquenio 2009-2013 se comprueba que han aumentado la frecuencia de los cánceres de Piel No Melanoma, de Mama y Pulmón, permanecen estables el cáncer de Colon-Recto y Útero, descendiendo el cáncer de Cerebro.

Para poder comparar la frecuencia de cáncer de la población de Granada (Tasa Bruta) con otra población, es necesario estandarizar para descartar el factor edad, debido a que la diferente estructura de la población por el envejecimiento, produce un aumento en la frecuencia de cáncer; así, el mayor número de nuevos diagnósticos de cáncer se produce en los estratos de edad más altos.

La Tasa de Incidencia Estandarizada (por estructura de población europea) por todos los cánceres en Granada ciudad es de 569 casos por 100.000 habitantes, que es superior a la de la provincia de Granada que fue para el mismo periodo 2013-2017 de 491.

Los diferentes tipos de Cáncer en el municipio también tienen tasas más altas a las de la provincia de Granada.

TIPO CÁNCER	Tasas Estandarizadas GRANADA (Municipio) Media anual (2013-2017)	Tasas Estandarizadas PROVINCIA (Provincia) Media anual (2013-2017)
Piel (no melanoma)	162,1	131,2
Mama	116,2 (mujeres)	92,6 (mujeres)
Colón-Recto	52,4	46,7
Próstata	96,1 (hombres)	79,3 (hombres)
Pulmón, Tráquea, Bronquios	35,9	33,8
Vejiga	28,7	25,4
Cerebro, Sistema Nervioso	15	13,7
Linfoma No Hodgkin	14,1	11,2
Útero (cuerpo)	24,0 (mujeres)	22,7 (mujeres)
Melanoma de Piel	13,5	12,1
Total todos los Cánceres	569,5	491,5

Fuente: Registro de Cáncer de Granada. Tasas por 100.000 habitantes
 Tabla- Comparativa de tasas estandarizadas de cáncer entre el Municipio y Provincia de Granada periodo 2013- 2017.

La mayoría de estos cánceres tienen relación con nuestro estilo de vida (consumo de tabaco y alcohol, dieta pobre en fibra, sedentarismo, etc.).

- 4.1.3.- Enfermedades de Declaración Obligatoria (Extracto):

Es la notificación que hacen los Médicos/as ante la sospecha de la existencia de cualquiera de las enfermedades comprendidas dentro del listado de ellas, para definir estrategias de prevención y control, o establecer medidas de intervención inmediata sobre los contactos o el medio.

Las tasas de incidencia de las enfermedades de declaración obligatoria en el quinquenio 2018-2022, son similares en las UA del Zaidín, e inferiores al resto de barrios de la ciudad.

Entre las enfermedades destaca la covid19 y las infecciones de transmisión sexual (infección gonocócica, Chlamydia trachomatis, sífilis, herpes genital).

Se aprecia la baja incidencia de enfermedades vacunables, salvo los casos de parotiditis y tosferina que están asociados a brotes nacionales.

Baja incidencia de enfermedades como Tuberculosis y VIH/SIDA.

Resumen del número de Casos de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), 2018-2022	ZAIDIN CENTR O	ZAIDI N SUR	D. ZAIDIN VERGEL ES	GRANA DA MUNICIPIO
Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae	1	1	2	9
Enfermedad meningocócica	0	1	1	6
Enfermedad neumocócica invasora	7	5	12	68
Enfermedad por Coronavirus COVID-19	3771	5436	9207	60223
Hepatitis A	0	2	2	17
Hepatitis B	1	2	3	22
Hepatitis C	6	8	14	109
Herpes Genital	13	8	21	293
Infección genital por Chlamydia trachomatis	34	52	86	646
Infección gonocócica	36	51	87	711
Infección por VIH y SIDA	2	10	12	198
Legionelosis	0	2	2	20
Leishmaniasis	0	2	2	7
Listeriosis	4	3	7	42
Meningitis víricas	8	3	11	55
Parotiditis	6	14	20	315
Sífilis	17	30	47	316
Tosferina	2	0	2	30

Tuberculosis	3	6	9	106
Viruela de los monos	0	3	3	31
Total EDO	3909	5632	9541	64413
Tasas Incidencia anual (por 100.000 hab.)	3996	3860	3914	4683

Fuente: Redalerta

Tabla- Extracto del listado de Enfermedades de Declaración Obligatoria de las Unidades Asistenciales Zaidín Centro, y Sur, junto con Distrito Zaidín y Municipio de Granada; periodo 2018-2022.

- 4.1.4.- Alertas Sanitarias:

Las Alertas Sanitarias detectadas en el último quinquenio en las UA del Zaidín han sido escasas y predominan fundamentalmente los brotes por covid19.

Tipo de Brote o Alerta Sanitaria	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Brote de T.I.A.	0	1	1	0	0	2
Brote de brucelosis	0	0	0	0	0	0
Brote de enfermedad vacunable	0	1	0	0	0	1
Brote de gastroenteritis inespecífica	1	1	0	0	0	2
Brote de gripe	0	0	0	0	1	1
Brote de hepatitis A	0	0	0	0	0	0
Brote de origen hídrico	0	0	0	0	0	0
Brote Covid19	0	0	3	6	10	19
Brote de tuberculosis	0	0	0	0	0	0
Brote o Cluster de meningitis	0	0	0	0	0	0
Brote o Cluster de legionelosis	0	0	0	0	0	0
Brote por exposición a tóxicos	0	0	0	0	0	0
Brote por infestación	0	0	0	0	0	0
Total Zaidín Centro y Zaidín Sur	1	3	4	6	11	25
Total Granada (Municipio)	29	51	166	149	133	528

Fuente: Redalerta

Tabla- Tipos de brotes del Distrito Zaidín Vergeles y municipio de Granada; periodo 2018-2022.

4.2 Atención a la salud a lo largo de la vida:

- 4.2.1- Diagnostico Precoz Cáncer y Cribados:

- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Colon.

El cáncer de colon, es el más frecuente en la población si exceptuamos el de piel no melanoma. Puede detectarse antes de que aparezcan síntomas, cuando está aún en las fases iniciales, que es cuando es más fácil de tratar y con más posibilidades de curación.

Esta enfermedad empieza con el crecimiento anormal del tejido del propio intestino, dando lugar a pólipos o adenomas, en los que es frecuente el sangrado. La mayoría de los pólipos intestinales son benignos (no cancerosos), pero un pequeño porcentaje de casos son malignos.

El cribado consiste en la realización de una prueba para analizar la presencia de sangre oculta en las heces; se recomienda a todos los hombres y mujeres entre los 50 y 69 años (una prueba cada dos años). En el caso de resultar positiva esta prueba, se da cita en el centro de salud para informar y recomendar otras exploraciones (Colonoscopia).

En la ciudad de Granada, en el año 2022, la población diana elegible era de 77.835 personas, de las que 13.250 corresponden al barrio del Zaidín (4.963 a la UA de Zaidín Centro y 8.287 a la UA Zaidín Sur).

La participación en el programa es baja, aunque superior a la cifra en Andalucía que es del 37%. Se detecta sangre en heces en aproximadamente en el 8% de las muestras recogidas en el programa de prevención.

	Población Invitada Participar	Población Acepta (%)	N.º Test sangre en heces Válidos	N.º Test Positivos	% Positivida d
U.A. Zaidín Centro	4963	2145 (43%)	1563	124	7,9 %
U.A. Zaidín Sur	8287	3262 (39%)	2311	194	8,4 %
Granada	77835	31402 (40%)	22111	1697	7,7 %

Fuente BPS y elaboración propia.

Tabla: coberturas de participación y de positividad de test de sangre oculta en heces, año 2022.

De las personas que han resultado con Test positivos, en las que se indicó la realización de Colonoscopias para detectar lesiones, se diagnosticaron fundamentalmente lesiones premalignas (adenomas). El resultado fue ligeramente superior en la UA Zaidín Sur.

	Adenomas	Cáncer invasivo	Diagnósticos Totales	% Diagnósticos
U.A. Zaidín Centro	59	3	62	4,0%
U.A. Zaidín Sur	130	2	132	5,7%
Granada	757	23	780	3,5%
Andalucía				3,7%

Fuente BPS y elaboración propia.

Tabla. Resultados del cribado de cáncer de Colon en la ciudad de Granada y Unidades Asistenciales (U.A.) Zaidín Centro y Sur, año 2022.

- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama.

El Cáncer de Mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas. En la actualidad no es posible llevar a cabo medidas para evitar que la enfermedad aparezca, pero se puede detectar en fases tempranas cuando aún no ha producido síntomas, por lo que aplicando el tratamiento adecuado, se mejora el pronóstico y aumenta la supervivencia.

La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas.

Consiste en la realización de mamografías cada 2 años a toda la población femenina entre 50 y 69 años, residente en Andalucía.

Las mujeres son citadas mediante carta que reciben en su domicilio para acudir a una Unidad de exploración mamográfica específica en donde se hacen dos placas por mama.

El resultado lo recibe la interesada por correo y en el caso de que deba ser derivada al hospital para completar el estudio o para realizar algún tipo de tratamiento también recibirá dicha cita por correo.

La población diana en la ciudad de Granada es de 33.775 mujeres, de las que 5.528 corresponden al barrio del Zaidín (2.246 a la UA de Zaidín Centro y 3282 a la UA Zaidín Sur, respectivamente).

La proporción de mujeres a las que se ha ofrecido la realización de la exploración de cribado (captación) es alto, diagnosticándose entre 3 y 4 tumores por cada mil mujeres participantes en el programa de prevención.

	Tasa Captación	N.º Tumores	Tasa Detección (‰)
UA Zaidín Centro	87%	3	3,23
UA Zaidín Sur	86%	6	4,42
Hospital San Cecilio	84%	23	1,63
Hospital Virgen de las Nieves	86%	52	4,48

Fuente: PPCM y elaboración propia.

Tabla: Tasa de captación y de Detección de tumores de mama en el Programa de Prevención Precoz de Cáncer de Mama, año 2022.

- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Cérvix/Útero.

El Programa de Detección de Cáncer de Cérvix/Útero es muy efectivo para identificar lesiones precursoras, disminuyendo la probabilidad de desarrollarlo.

El cáncer de cuello de útero tarda más de 10 años en desarrollarse, por lo que se dispone de un plazo prolongado para detectarlo, tratarlo y curarlo; al no producir molestias o síntomas al principio, la manera de saber su existencia es a través del cribado.

El programa va dirigido a mujeres entre 25 y 65 años a las que se realiza citología, a través de la cuál es posible detectar precozmente las células cervicales anómalas, pudiendo ser tratadas antes de que el cáncer aparezca.

La población diana en el municipio de Granada es de 80.586 mujeres, de las que 14.482 corresponden al barrio del Zaidín (6015 a la UA de Zaidín Centro y 8.467 al Zaidín Sur).

	N.º mujeres estudiadas (25-64 años)	Población Diana (25-64 años)	% Mujeres estudiadas (25-64 años)
UA Zaidín Centro	4395	6015	73,0%
UA Zaidín Sur	6323	8567	72,6%
Granada	60680	81622	74,3%
Distrito Granada Metropolitano	150854	196386	76,8%

Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número y porcentaje de mujeres entre 25 y 64 años, incluidas en el Diagnóstico Precoz de cáncer de Cérvix/útero, año 2021.

La proporción de mujeres que participan en el programa de Diagnóstico Precoz es muy similar en los diferentes ámbitos geográficos.

- Diagnóstico Precoz de Cáncer de Próstata/Hiperplasia Benigna Próstata (HBP).

El Cáncer de Próstata es el cáncer más frecuente en hombres, si se exceptúa el cáncer de piel no melanoma. No hay un cribado poblacional, pero sí existe un Proceso Asistencial donde se especifican la realización de una serie de actividades secuenciales destinadas a establecer el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con manifestaciones clínicas y/o analíticas de hipertrofia benigna de próstata y/o cáncer de próstata.

	N.º Hombres estudiados (50-70 años)	N.º total hombres (50-70 años)	% hombres estudiados (50-70 años)
UA Zaidín Centro	768	2302	33,4%
UA Zaidín Sur	954	3750	25,4%
Granada	8402	33150	25,3%
Distrito Granada Metropolitano	20410	86199	23,7%

Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número y porcentaje de hombres entre 50 y 70 años, incluidos en el Proceso Asistencial de HBP/Cáncer de Próstata, año 2021.

La proporción de hombres incluidos y estudiados en el Proceso Asistencial de HBP/Cáncer de Próstata es superior en la UA Zaidín Centro al resto de ámbitos geográficos.

- Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-metabólicas de Andalucía

El Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-metabólicas de Andalucía, popularmente conocido como la prueba del talón, tiene como objetivo la detección precoz de un grupo de enfermedades, en las que existe una intervención eficaz que permite modificar favorablemente su pronóstico, reduciendo la morbimortalidad y las posibles discapacidades asociadas a esas enfermedades.

Se ofrece activa y sistemáticamente a todos los recién nacidos con independencia de su nacimiento en un centro público o privado.

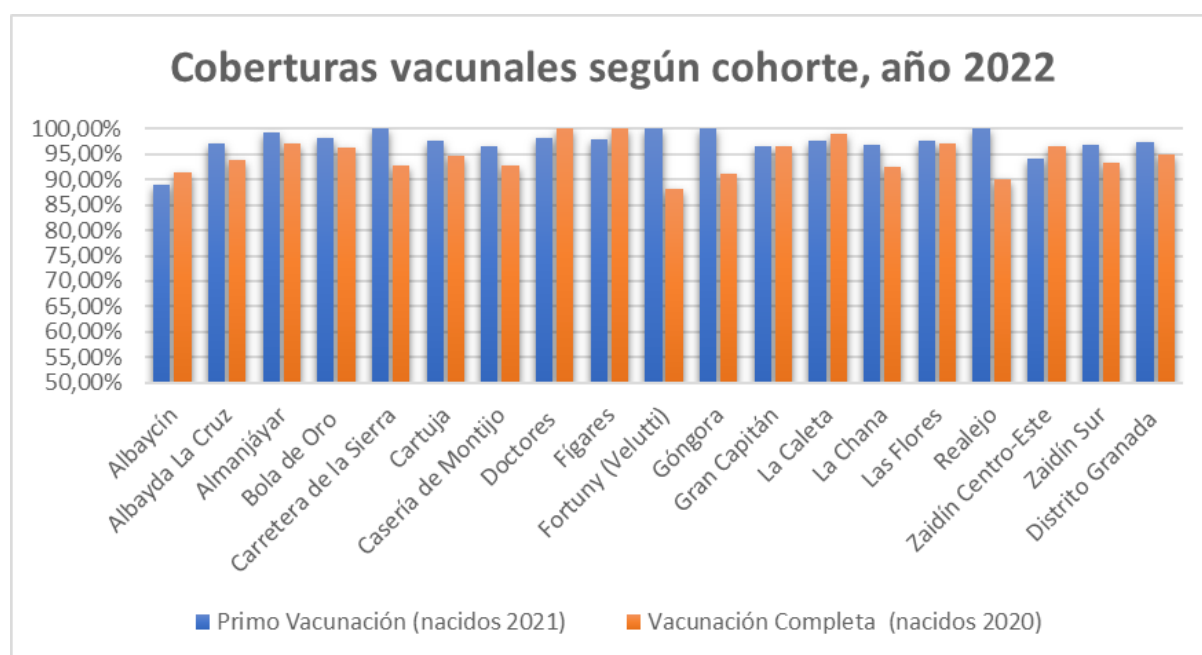
El cribado de Fenilcetonuria e Hipotiroidismo Congénito se lleva a cabo en Andalucía desde 1978 y en 2009 se fue extendiendo hasta 30 enfermedades metabólicas diferentes con la misma muestra de sangre, incluyendo la Fibrosis Quística.

Durante el año 2022, se realizaron 1740 Pruebas del Talón a recién nacidos con domicilio en la ciudad de Granada, para descartar enfermedades congénitas graves, de las que 99,9% resultaron normales y 2 patológicas.

- 4.2.2- Vacunaciones:

- Calendario de Vacunaciones, Primovacunación y Vacunación Completa a los 2 años.

El calendario de vacunaciones, también llamado calendario sistemático, es la secuencia cronológica de las vacunas que se recomiendan de forma fija en ciertas edades a la población, con el esquema más adecuado para evitar infecciones prevenibles.



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Coberturas vacunales en cohortes nacidas en 2020 y 2021. Año 2022.

Destaca la alta cobertura de las vacunaciones incluidas en el Calendario de Vacunaciones de Andalucía, para los niños/as nacidos en 2020 (vacunación completa) de la UA Zaidín Centro y Sur, superiores al 99%. En Primovacunación (nacidos/as 2021) las coberturas en ambas UA son superiores al 94%.

Para los nacidos/as en el 2018 (2ª dosis de vacuna Triple Vírica a los 4 años), las coberturas en la UA Zaidín Sur son del 97,2% y las de Zaidín Centro son del 100%.

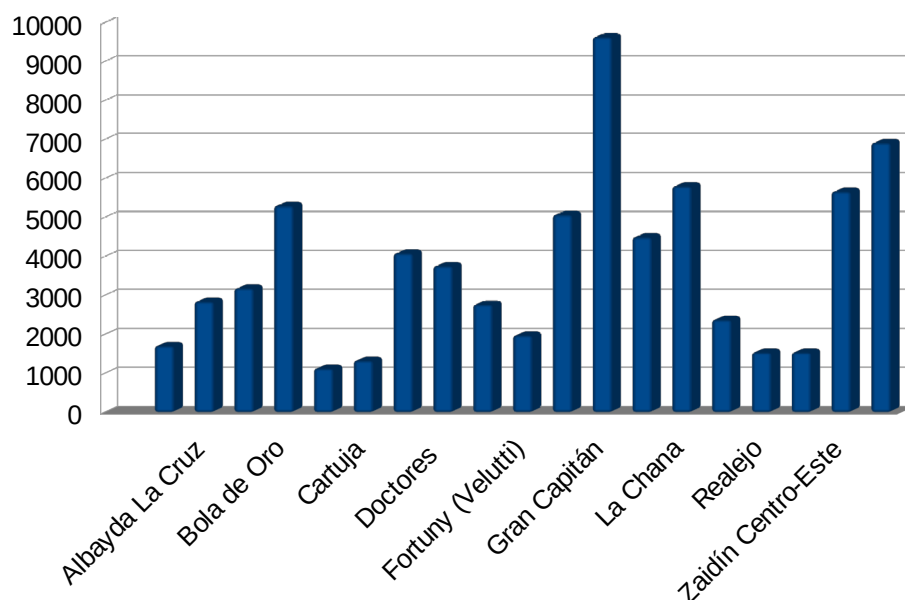
- Vacunación contra la Gripe, Total y en mayores de 65 años.

El objetivo de los programas de vacunación frente a la gripe es disminuir la carga de morbilidad causada por el virus de la gripe y reducir el impacto de la enfermedad en la comunidad.

La indicación de vacunación contra la gripe no es sistemática para toda la población, así, en la campaña 2022/2023, el objetivo era vacunar a toda la población de edades entre 6 y 59 meses y mayores de 65 años, además de personas mayores de 59 meses de edad con algún factor de riesgo (diabetes, bronquitis crónica,...) o situación especial (sanitarios, embarazadas,...).

En el siguiente gráfico puede observarse el número de personas vacunadas en la ciudad de Granada, por punto de administración.

Vacunación Poblacional de Gripe, Campaña 2022/2023



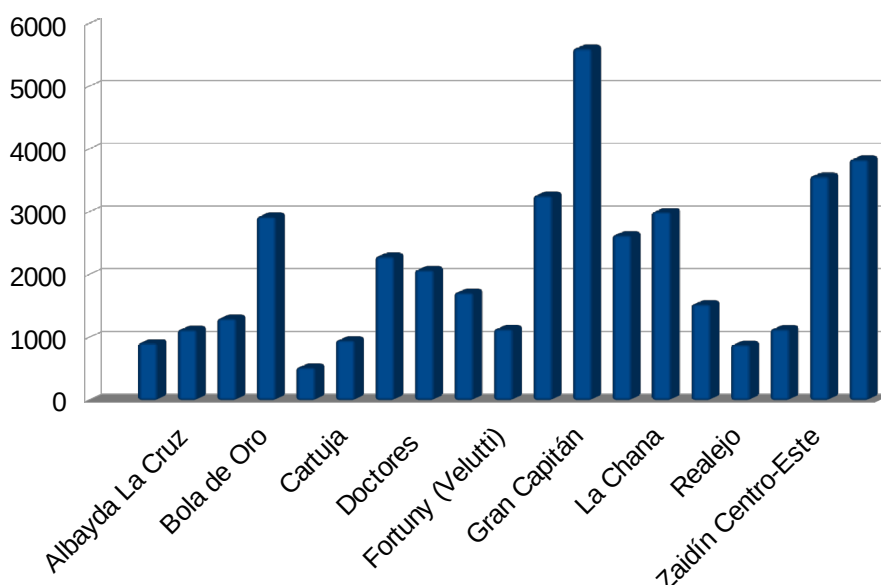
Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número de vacunas de la Campaña de Vacunación Antigripal de 2022/2023 administradas según Unidad Asistencial de Granada.

Uno de los principales grupos de riesgo de presentar complicaciones al padecer la gripe, son los mayores de 65 años; En Andalucía la cobertura de vacunación antigripal en este grupo fue del 70,6%, en la UA Zaidín Centro fue del 74,5% y en la UA Zaidín Sur del 69,3%.

En el siguiente gráfico puede observarse el número de personas mayores de 65 años vacunadas en la ciudad de Granada, por punto de administración.

Vacunación Mayores 65 años de Gripe, Campaña 2022/2023



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número de vacunas de la Campaña de Vacunación Antigripal de 2022/2023 administradas según Unidad Asistencial de Granada en mayores de 65 años.

- 4.2.3- Embarazo:

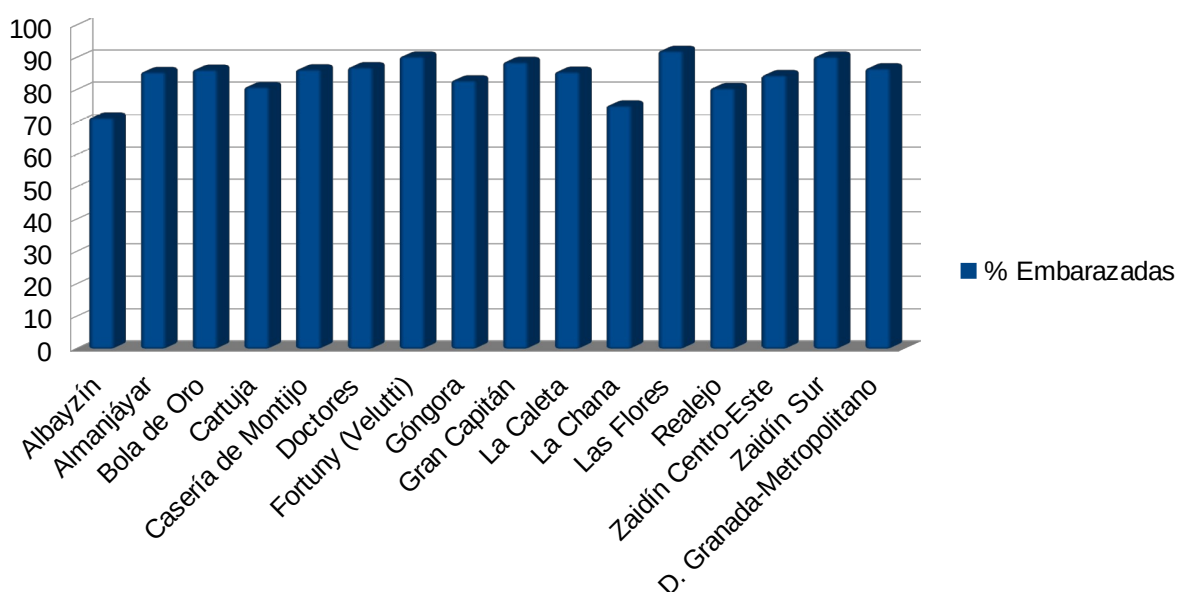
- Captación Precoz en el Embarazo.

El embarazo es un proceso natural que requiere unos cuidados específicos y un seguimiento especializado con el fin de preservar en todo momento la salud y bienestar de la madre y del bebé.

En el Sistema Sanitario Público Andaluz los controles del curso del embarazo vienen definidos en el Proceso Asistencial Integrado Embarazo, Parto y Puerperio, donde se determina el número de visitas (de 8 a 10, una al mes, aproximadamente) y la frecuencia de éstas dependerá de si es un embarazo de bajo riesgo o no, pues si existen desviaciones de la normalidad requerirá visitas más próximas en el tiempo, actividades educativas (formativas/informativas), las exploraciones y pruebas diagnósticas o complementarias.

La mayoría de las embarazadas acude precozmente, antes de las 12 semanas de gestación al Centro de Salud, así, el 84,7% lo hacen en la UA Zaidín Centro y 90,3% en la UA Zaidín Sur (86,7% en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano).

% Captación Precoz Embarazo (antes de las 12 semanas), año 2021



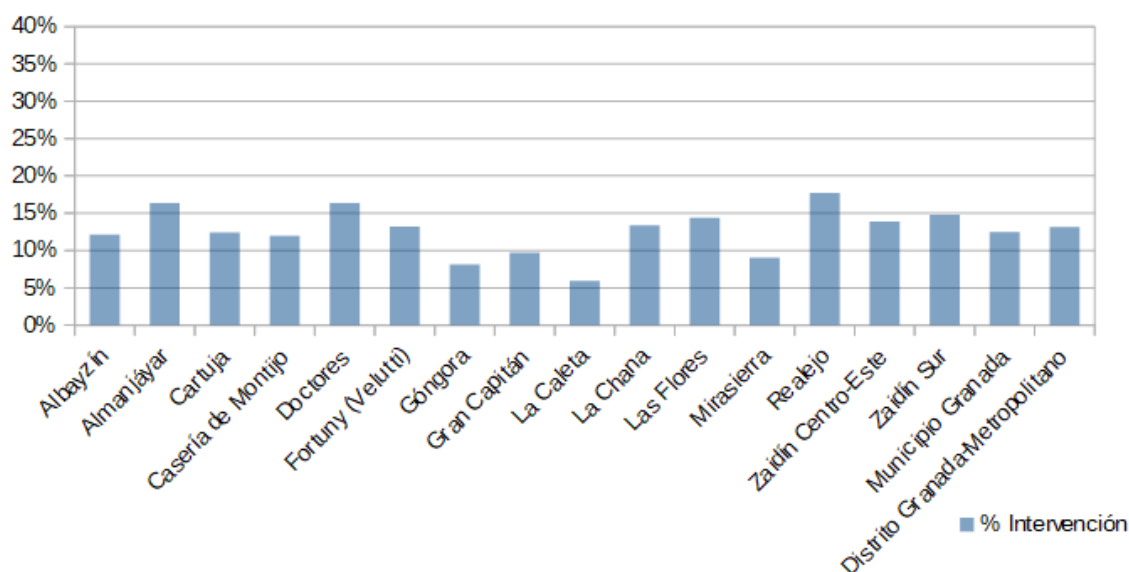
- 4.2.4- Estilos de Vida:

Las intervenciones en los estilos de vida, se ha visto muy afectada por la pandemia de covid19, al disminuir la presencialidad de los usuarios en los Centros de Salud y priorizar otras intervenciones consideraras más urgentes.

- Intervención Avanzada en Obesidad Infantil de 6 a 14 años (IAOI).

Se basa en intervenciones para promover una alimentación saludable y fomentar la actividad física, donde debe estar implicada la familia.

Porcentaje (%) niños/as con I.A.I. en Obesidad Infantil, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico

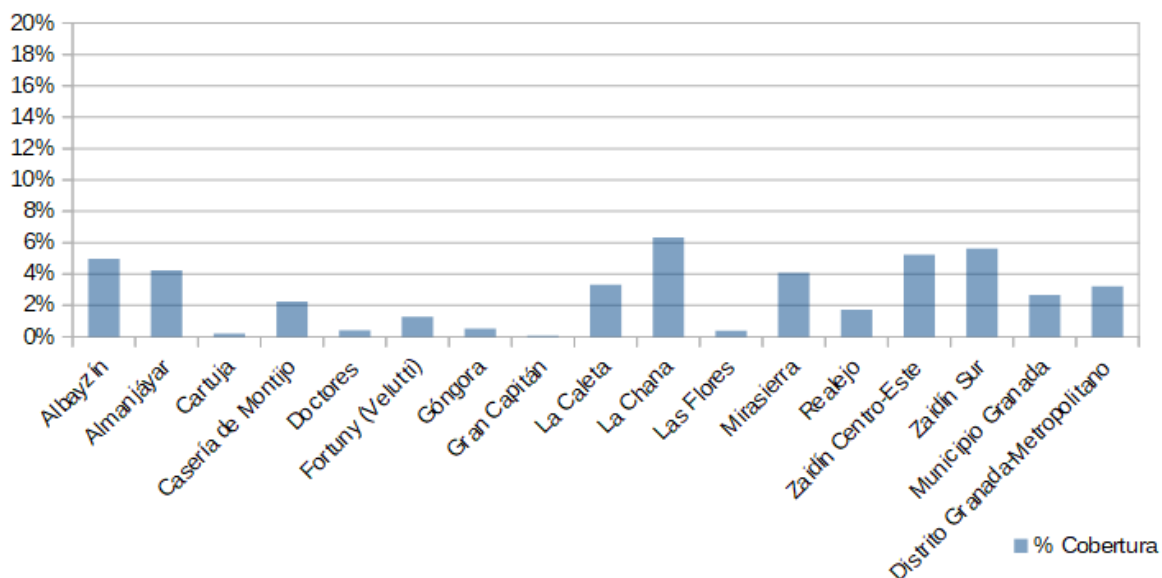


La mediana del periodo 2018-2021 en el porcentaje de IAOI disminuyó con respecto al periodo 2013-2017, esta disminución no afectó tanto a las UA del Zaidín, así, en la UA Zaidín Centro el resultado fue del 3,7%, y en la UA Zaidín Sur del 6,3%, sin embargo en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano fue del 1,9%,

- Consejo Dietético Individual en adultos.

Al igual que en la población infantil, también se vieron afectadas las intervenciones en Consejo Dietético en adultos. Así en el periodo 2013-2017, destacaban las UA del Zaidín.

Porcentaje (%) adultos que reciben Consejo Dietético Intensivo Individual, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico



En el periodo 2018-2021, en la UA Zaidín Centro el resultado fue del 0,65% y en la UA Zaidín Sur del 0,63%, mientras que en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano fue del 0,15%.

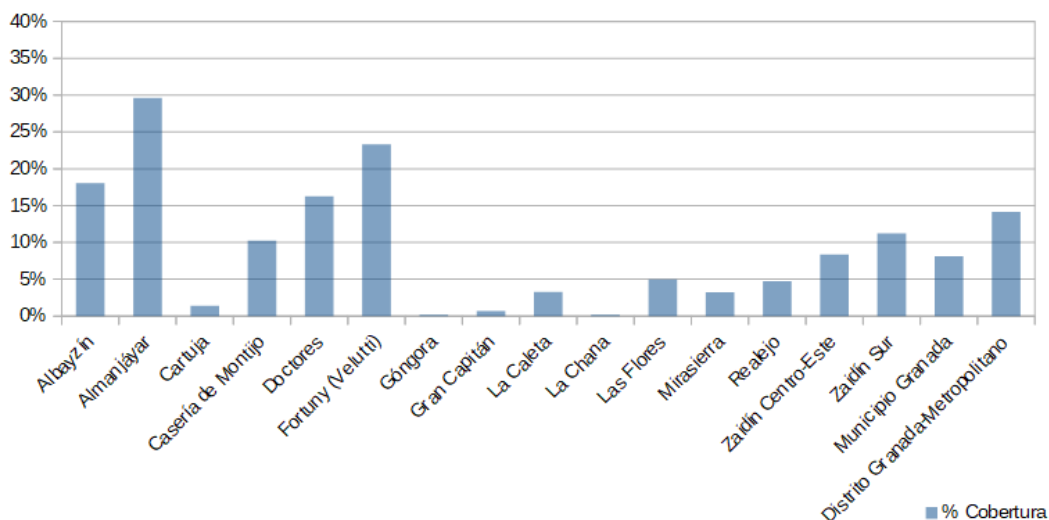
- Intervención Avanzada Individual para dejar el tabaco.

El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y recidivante; es la primera causa evitable de morbilidad y mortalidad en el mundo desarrollado.

El consumo de tabaco ha sido uno de los más importantes problemas de salud pública, originando más muertes que el SIDA, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos.

El dejar de fumar produce importantes beneficios para la salud tanto si se han desarrollado enfermedades relacionadas con el tabaco como si no.

Porcentaje (%) de mayores de 16 años con Intervención Avanzada Individual en Tabaquismo, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico



En el periodo 2018-2021, la Intervención Avanzada Individual para dejar el tabaco en adultos, en la UA Zaidín Centro el resultado fue del 10,7% de los fumadores y en la UA Zaidín Sur del 1%, mientras que en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano fue del 8%.

4.3 Análisis de la mortalidad

Se analiza la mortalidad general y la mortalidad por causas específicas del municipio de Granada, al no existir estadísticas oficiales por barrios o Unidades Asistenciales:

- 4.3.1.- Mortalidad General:

En el año 2021, fallecieron en el municipio de Granada 2.444, 1.142 hombres y 1.302 mujeres (2.340 personas, 1.111 hombres y 1.229 mujeres en 2016), que se corresponde con una Tasa Bruta de Mortalidad de 10,6‰ (Andalucía 9,4‰). Sin embargo, si esta tasa se diferencia por sexo, es superior en los hombres (10,7‰) con respecto a las mujeres (10,4‰), debido a que la población de mujeres es mayor; es decir, los hombres tienen más riesgo de morir aunque mueren más mujeres.

La Mortalidad General o mortalidad por todas las causas (2015), está elevada de manera significativa con respecto a España, tanto en mujeres como en los hombres, en los grupos etarios de 45-64, 65-74 y 75-84 años de edad.

- 4.3.2.- Mortalidad Específica:

En la ciudad de Granada, durante 2021, las principales causas de defunción fueron por enfermedades del sistema circulatorio con el 27% (28% en Andalucía), por tumores con el 25% (24% en Andalucía) y por enfermedades Infecciosas con el 11% (10% en Andalucía).

Las defunciones por causa de muerte, según capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición (CIE 10) son:

CIE 10 (año 2021)	Granada (ciudad)	Granada (Provincia)	Andalucía
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	259	933	7.803
II. Tumores	611	2.090	19.013
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	7	39	334
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	73	296	2.792
V. Trastornos mentales y del comportamiento	64	266	2.615
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	179	515	4.513
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	665	2.431	22.394
X. Enfermedades del sistema respiratorio	182	636	5.742
XI. Enfermedades del sistema digestivo	145	465	4.241
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6	25	247
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	33	103	793
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	92	329	2.808
XV. Embarazo, parto y puerperio	0	1	3
XVI. Afecciones originadas en el período perinatal	4	15	134
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	11	152
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	55	320	3.057
XX. Causas externas de mortalidad	62	292	2.698
Total	2.444	8.767	79.339

En el año 2015, las causas específicas de mortalidad que presentaron un exceso de riesgo significativo con respecto a España y que por tanto pueden explicar el exceso en la mortalidad general, fueron (por sexo y grupo de edad):

- Accidentes de Tráfico: en mujeres de 75 a 84 años.
- Cáncer de Colon-Recto: en mujeres mayores de 85 años.
- Cáncer de Próstata: en hombres de 75 a 84 años.
- Cirrosis: en hombres de 65 a 75 años.
- Diabetes: en hombres de 75 a 84 años de edad.
- Enfermedad de Alzheimer: en hombres y mujeres mayores de 75 años.
- Enfermedad Cerebrovascular: En hombres de 45 a 85 años y en mujeres de 65 a 75 y mayores de 85 años.
- Enfermedad Isquémica del Corazón: en hombres mayores de 75 y en mujeres mayores de 65 años.
- Suicidio: en hombres de 15 a 44 años.

5. Análisis Encuesta Andaluza de Salud: Promoción de la Salud (estilos de vida)

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. La referencia es la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986. La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los *determinantes de la salud* y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud.

En este caso, en este diagnóstico de salud, se relaciona la promoción de la salud con uno de los determinantes sociales de la salud (tiene mayor incidencia sobre la enfermedad), los estilos de vida.

A continuación, se realiza un breve análisis de diferentes estilos de vida, con datos recogidos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS), de la Encuesta Andaluza de Salud (EAS), además de otras fuentes de interés, desagregados a nivel de la provincia de Granada, Andalucía y España, salvo casos aislados en la que se disponen de datos a nivel local.

5.1 Estilos de vida:

5.1.1 Alimentación Saludable

- Consumo de lácteos, frutas y verduras en población adulta

En el año 2007 el 93,6%, 78,9% y el 67% de la población residente en Andalucía manifestó consumir al menos tres veces a la semana productos lácteos, fruta fresca y verduras, respectivamente. Para los tres productos estudiados se observa un mayor porcentaje de consumo en el caso de las mujeres que en el de los hombres.

Córdoba destaca como la provincia en la que mayor porcentaje de habitantes consumen lácteos (96,1%) y verduras (75,2%) con al menos una periodicidad de tres veces semanales, mientras que el consumo de fruta fresca es más frecuente entre la población residente en Granada (86,7%).

Realizando la comparativa entre Granada y Andalucía, es significativa la diferencia en las pautas de consumo, muy superiores para el caso de Granada provincia (87%-79% en consumo de frutas y 73%-67% en consumo de verduras).

- Lactancia materna (% menores)

En la Encuesta Andaluza de Salud con datos de 2012, ha aumentado ligeramente el porcentaje de menores que recibieron lactancia materna exclusiva durante los tres primeros meses de vida alcanzando el 45,3% (43,9% de los niños y 46,7% de las niñas).

Por grupos de edad un 46,3% del grupo de 0 a 4 años recibió lactancia materna exclusiva al menos durante los tres primeros meses, descendiendo 41,3% en el grupo intermedio para volver a aumentar al 47,7% en el grupo de mayores de 10 años.

En el caso de Granada, el % de menores que han recibido lactancia materna es ligeramente superior, 47,5%, y según datos de la ENS 2006, el % en España es muy superior, situándose en 64,5%.

- Consumo de frutas y verduras en población infantil (% al menos 5 veces a la semana):

- Las pautas de consumo en la población infantil de la provincia de Granada son ligeramente superiores a las de Andalucía, 73,7% - 70,4%.
- Por sexos, el porcentaje de niños y niñas granadinas que consumen frutas y verduras, es superior con respecto a los niños y niñas andaluzas.
- Efectuando la comparativa con los datos disponibles de España, el % se sitúa en 62,3%, siendo el comportamiento similar tanto en niños/as, manteniendo la tendencia de ser muy inferiores a los datos de Andalucía y la provincia de Granada.

- Consumo embutidos población infantil (%)

- Los datos disponibles se refieren a Andalucía en comparación con España, en este caso, el consumo de embutidos es inferior en Andalucía (25,8%), frente a los datos de España (29,1%).
- Desagregado por sexo, el % es ambos casos es muy similar, ligeramente mayor para el caso de los niños.

- Consumo refrescos población infantil (%)

- El consumo de refrescos en los niños/as andaluzas es muy superior a la media nacional (22,6%-14,2%).
- Por sexo, es ligeramente superior en el caso de los niños.

- Consumo dulces población infantil (%)

- En el caso del consumo de dulces, el porcentaje en Andalucía se sitúa en el 33,7% frente al 45% de España.
- Por sexo, la tendencia en ambos casos es superior en los niños/as.

5.1.2 Sobrepeso

En el año 2007 el 53,5% de la población andaluza tenía un peso superior al normal (sobrepeso u obesidad), mayor en hombres (59,8%) que en mujeres (47,3%).

Huelva (58,9%) y Granada (57,3%) son las provincias en las que se registraron mayores porcentajes de personas con sobrepeso u obesidad.

5.1.3 Obesidad infantil (2-15 años)**- Evolución prevalencia sobrepeso infantil (EAS 2012)**

La prevalencia de sobrepeso aumenta con la edad en ambos sexos, presentando la última encuesta los valores más altos en todos los grupos de edad y sexo. Veamos a continuación, los datos referidos a Andalucía y Granada:

- La media provincial se sitúa en 25,4% y en Andalucía en 18,6%.
- Desagregado por sexos, en niños en Granada 24,8 y Andalucía 19,9%, mientras que en niñas en la provincia de Granada 26,0% frente al 17,3% de Andalucía.

En general, la prevalencia de sobrepeso infantil en la provincia de Granada es superior a la media de Andalucía, destacando por encima de todo, una mayor prevalencia en el caso de las niñas.

- Evolución prevalencia obesidad infantil, a destacar lo siguiente:

- La prevalencia en Granada se sitúa muy por debajo de la de Andalucía, 5,6% frente al 13,1%.
- No se presentan apenas diferencias la prevalencia entre niños/as

- Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil de Andalucía en relación con España y Europa:

- En Andalucía se sitúa ligeramente por encima en niños, aunque es muy superior en las niñas (ENS 2006)
- Relacionando los datos de España con los países europeos, se sitúa en el 3º lugar de los países con mayor prevalencia en niños/as de 7-11 años (por encima del 30%), algo menor en el intervalo 13-17 años (sobre el 20%).

5.1.4 Tabaquismo: Consumo y edad de inicio

En el año 2012 casi un tercio (31,1%) de la población andaluza manifestó consumir tabaco a diario, porcentaje superior en hombres (39,4%) que en mujeres (23,1%). Por áreas geográficas, Granada (33,8%) y Huelva (33,7%) son las zonas en las que se recogen mayores porcentajes de personas que fumadoras, aunque las diferencias entre las 8 provincias son pequeñas.

La edad media de inicio del consumo de tabaco se situó en 16,3 años en los varones y de 17,4 años en las mujeres. El estudio por grupos etarios señala cómo cada vez más los jóvenes, hombres y mujeres, comienzan a fumar a edades más tempranas.

En el caso de la provincia de Granada, la media se sitúa en 16,9 años, muy similar a la de Andalucía: 16,7 años.

5.1.5 Consumo de alcohol. Edad de inicio

En el año 2012 el 41,8% de la población andaluza manifestó consumir alcohol al menos una vez al mes: porcentaje doble de hombres (57,4%) que de mujeres (26,5%).

Por provincias, Jaén (55,2%), Granada (49,7%) y Sevilla (48,1%) son las áreas en las que se recogen mayores proporciones de personas que declaran que al menos una vez al mes beben alcohol.

En el año 2012 la edad media de inicio al consumo de alcohol era de 17,1 años en los varones y de 18,1 años en las mujeres. El estudio por grupos etarios señala cómo cada vez más comienza a tomarse alcohol a edades más tempranas.

En el caso de la provincia de Granada, la edad media de inicio coincide con la media de Andalucía, situada en los 17,4 años.

5.1.6 Seguridad vial

- Uso del casco y cinturón de seguridad en ciudad/carretera

En 2012, el porcentaje de hombres que siempre usaron casco cuando viajaron en moto o motocicleta fue del 69% en ciudad y 90,5% en carretera, mientras que en mujeres fue del 67,3% y 85,3%, respectivamente.

En cuanto al uso del cinturón de seguridad, las mujeres dicen usar siempre el cinturón en ciudad un 8% más que los hombres. En carretera, tanto mujeres como hombres usan el cinturón siempre en más del 97% de los casos estudiados (97,1% en hombres y 97,9% en mujeres).

En el caso de la provincia de Granada, el uso del casco tanto en ciudad/carretera se sitúa en los promedios de Andalucía (68-88), mientras que el uso del cinturón es ligeramente inferior en ciudad (78-83), y se iguala en carretera (98,5-97,5).

5.1.7 Accidentes de tráfico

- Modelo de accidentabilidad en Andalucía

Modelización

El análisis del desplazamiento nos permite establecer para Andalucía, dos **modelos de accidentalidad** distintos, atendiendo al lugar de ocurrencia del accidente.

Tabla 2. Tabla resumen de la accidentabilidad por provincias en el 2009.

MODELOS DE ACCIDENTABILIDAD EN ANDALUCÍA	
MODELO 1	MODELO 2
Se caracteriza porque en el grupo de edad entre 15 y 24 años la tasa de víctimas en zona urbana es superior a la tasa de víctimas en carretera.	Se caracteriza por presentar una tasa de número de víctimas para todos los grupos de edad mayor en desplazamientos en carretera que en zona urbana.
La tasa máxima es de 386,59 para el grupo de 15-24 años en zona urbana	La tasa máxima es de 294,50 para el grupo de 15-24 años en carretera
Dentro de este modelo se incluyen las provincias con grandes áreas metropolitanas andaluzas: Sevilla, Cádiz, Málaga.	Dentro de este modelo se incluyen las provincias con áreas metropolitanas más pequeñas: Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva.
Mayor frecuencia de accidentes y de víctimas	Menor frecuencia de accidentes y de víctimas
Menor razón: víctimas/accidente; muertes/accidente; muertes/víctimas	Mayor razón: víctimas/accidente; muertes/accidente; muertes/víctimas

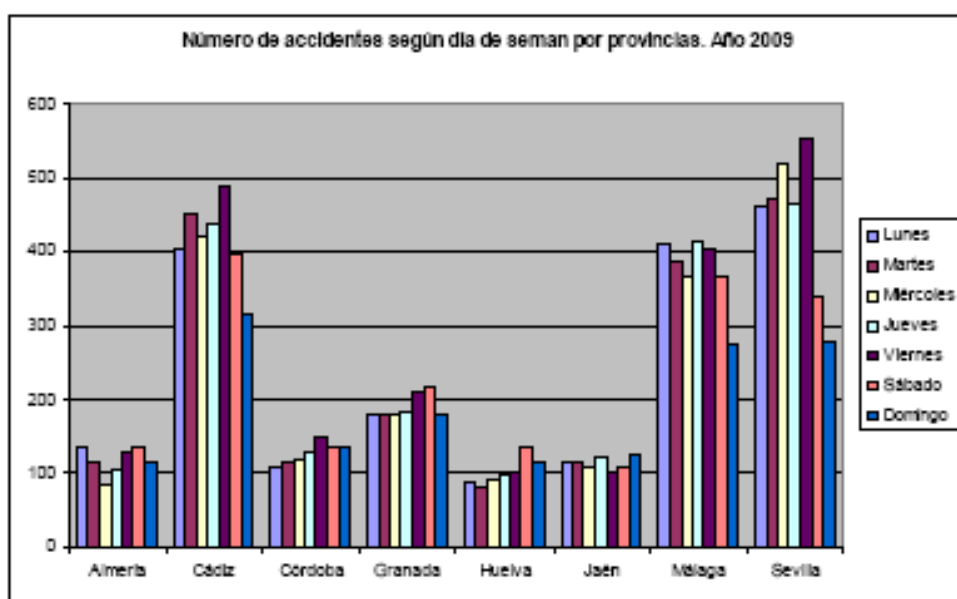
- **Tipo de vehículo**, Si añadimos la variable tipo de vehículo, considerando sólo los dos tipos que presentaban mayor frecuencia de accidentalidad tendremos en cuenta:

- Vehículo de dos ruedas: Bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
- Resto de vehículos (vehículos de cuatro ruedas): Turismos, ambulancias, furgonetas, camiones < 3500 Kg., tractor agrícola y otros.

Se puede observar que las tasas de víctimas son mayores en todas las edades cuando de vehículo es de cuatro ruedas. En vehículos de dos ruedas la tasa máxima se alcanza en el grupo de 15-24 años (tasa de 183,92).

En el 2009 se han registrado 296 personas ingresadas por AT en vehículo no motocicleta y 1.182 personas ingresadas por AT en vehículo motocicleta. El perfil de los afectados coincide con el identificado en los datos de la DGT para ambos tipo de vehículo. Las víctimas son predominantemente varones de edades comprendidas entre los 15-24 años.

- **Accidentes según día de la semana**, la mayor parte de los accidentes suceden en día laboral, destacando las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz (coincide con el modelo 1 de mayor tasa en accidentes urbanos en los grupos de edad joven) y Granada (modelo 2).



Fuente: Dirección General de Tráfico

Elaboración: Servicio de Epidemiología y Salud Laboral. Consejería de Salud

- Perfil accidentabilidad en la provincia de Granada. Se realiza un breve resumen, extraído del Informe *“Monografías de la accidentabilidad en Andalucía 2010”*:

- A lo largo del año 2009 se han producido 1.333 accidentes de tráfico en la provincia de Granada, lo que representa el 10,11% del total de Andalucía.
- El número de víctimas ha sido de 2129 (10,3%) con 56 muertes (14,4%).
- La evolución respecto a la frecuencia de víctimas registra dos picos máximos: uno en 2003 (2767 víctimas) y otro en 2007 (2129). Desde 2007 a 2009 se observa una reducción del 22%.
- Las tasas de víctimas por 100.000 hab. son más altas en el grupo de 15 a 24 años, seguidas por el grupo de 25 a 34, y a distancia, por los restantes grupos de edad. En 2009 se observa una reducción en la tasa de víctimas en todos los grupos de edad.
- En 2009 la mortalidad en el grupo de edad de 15-24 años ha descendido: la tasa de mortalidad en este grupo de edad en 2008 fue de 13,59 y se reduce a 9,08 en 2009.
- Los afectados son principalmente hombres, jóvenes y adultos jóvenes.
- Granada dentro del patrón global pertenece al modelo 2, el que engloba además a Córdoba, Almería, Jaén y Huelva. Se define por presentar una tasa de número de víctimas mayor en desplazamientos de carretera que en desplazamientos urbanos.
- En carretera la mayor parte de la accidentalidad ocurre con vehículos ligeros en todas las edades y, principalmente en jóvenes y adultos jóvenes. En desplazamientos urbanos las tasas son mayores en vehículos de dos ruedas para el grupo de edad 15-24.
- Analizando la distribución por día de la semana en la provincia, se puede ver un ligero incremento en el número de accidentes durante los viernes y sábados. La media de accidentes por día es de 190,4.
- El área de la provincia con mayor porcentaje de accidentes es Granada capital (91 %).

5.1.8 Patologías crónicas: Diabetes, Hipertensión,...

En el año 2012 las enfermedades crónicas más prevalentes en la población andaluza fueron la alergia (8,1%), artrosis (12,6%), colesterol (9,2%), diabetes (6,4%), hipertensión (6,4%), problemas de nervios (10,4%), problemas cardíacos (4,3%) y varices en las piernas (13,3%). Todas ellas se presentan con mayor frecuencia en las mujeres, salvo los problemas cardíacos, los cuales son más comunes en los hombres.

En el caso de Granada, la prevalencia de casos de personas con diabetes e hipertensión se sitúa en 5,4%, estando por debajo de la prevalencia de Andalucía.

5.1.9 Sedentarismo y actividad física

- **Sedentarismo en el puesto de trabajo y tiempo libre.** En el año 2012 el 83,3% de la población andaluza ejercía un trabajo sedentario, entendido éste como aquel que se realiza sentado o de pie sin realizar esfuerzos, siendo más frecuente este tipo de trabajos entre las mujeres (89,2%) que en los hombres (77,2%). Durante el tiempo libre, el sedentarismo alcanzó el 43,1% de la población, mayor también entre las mujeres (45,5%) que entre los hombres (40,7%).

Cádiz es la provincia que presentó mayores porcentajes de sedentarismo en el tiempo de trabajo (87,4%) y Huelva en el tiempo de ocio (58,5%). En el caso de Granada presenta unos valores de 81% y 40%, muy por debajo de la media de Andalucía.

- **Sedentarismo en población infantil. Porcentaje de población infantil que ve tv, videojuegos,...** En este caso, el % para el caso de la provincia de Granada se sitúa en el 93%, mientras que en Andalucía está en el 88%, siendo superior para el caso de los niños.

- **Sedentarismo en población infantil. Prevalencia de sedentarismo en población infantil.** En el año 2012 la frecuencia de sedentarismo se situaba en el 24,0% en el caso de los niños y en el 26,2% en las niñas, frecuencia que disminuía conforme aumentaba la edad del menor, niña o niño.

Así, en los grupos etarios de 3 a 7 años y de 8 a 15, el porcentaje de menores que no hace ningún tipo de actividad física en su tiempo libre es del 21,4% y del 10,8% respectivamente.

Por provincias Cádiz (19%) y Granada (19,4%) son las áreas en las que se encontraron menores frecuencias de sedentarismo entre la población menor de 16 años, frente a Huelva, que con un 44% destaca por ser la provincia con mayor tasa de sedentarismo entre la población infantil.

- **Evolución población infantil que realiza actividad física regularmente.** El porcentaje de menores que realizan actividad física regularmente en el caso de Andalucía es 26% y Granada 32,9%, siendo en ambos casos muy superior en los niños frente a las niñas.

5.1.10 Salud Laboral (condiciones de trabajo)

- **Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas.** En el año 2012 el porcentaje de personas trabajadoras expuestas a respirar vapores, humos u otras sustancias peligrosas fue del 11,8% (15,2% en hombres y 5,6% en mujeres). Por grupos de edad, se observa que son las personas de 55 años en adelante las más expuestas a este tipo de sustancias.

Sevilla (15,8%) y Cádiz (14,8%) fueron las provincias en las que la exposición a estas sustancias de las personas trabajadoras tuvo lugar con mayor frecuencia. Granada se sitúa en la media de Andalucía, 11,3%.

- **Exposición a sustancias y productos peligrosos.** En el año 2007, el 9,8% de los hombres estuvo expuesto laboralmente al manejo de sustancias peligrosas, mientras que este porcentaje en mujeres fue del 4,4%.

Sevilla (10,3%) y Córdoba (9,6%) fueron las provincias en las que fue mayor la exposición en el lugar de trabajo a sustancias peligrosas, mientras que Granada se sitúa en el 7,9%.

- **Exposición a posiciones fatigantes o dolorosas.** En el año 2012 el 35,5% de la población trabajadora estuvo muy expuesta a posiciones dolorosas/fatigantes en el trabajo, más los hombres (40,7%) que las mujeres (25,7%).

Por provincias, Málaga (44,5%) y Cádiz (40,4%) fueron las áreas en las que era más frecuente que las personas trabajadoras tuvieran posiciones fatigantes o dolorosas. Granada se sitúa muy por debajo de estos valores, 28,4%.

- **Percepción de afectación negativa del trabajo en la salud.** En el año 2012 el 23,8% de las personas trabajadoras creían que el trabajo les afectaba negativamente en su salud: esta percepción fue más alta entre los hombres (24,8%) que entre las mujeres (22%).

Por zonas, Málaga (26,2%), Cádiz (25,5%) y Almería (25,5%) son las provincias donde más frecuentemente las personas trabajadoras pensaron que el trabajo les afectaba negativamente a su salud y Huelva (18,7%) la que registró los valores más bajos. Granada presenta valores intermedios, 22,3%.

5.1.11 Percepción estado de salud en población adulta

En el año 2012 el 4,1% de la población residente en Andalucía declaró tener una mala o muy mala percepción de su salud. La proporción de personas que valoraban negativamente su estado de salud en el caso de las mujeres era mayor que en el de los hombres (5,7% y 2,5% respectivamente). En el caso de la provincia de Granada, la percepción de su salud se sitúa en 4,2%.

5.1.12 Percepción de mala salud en población infantil.

En el año 2012 el 2,7% de la población andaluza percibía el estado de salud de sus hijos e hijas menores de 16 años como regular o malo, siendo esta sensación más frecuente cuando se preguntaba por la salud de los niños (3,5%) que en el caso de las niñas (1,8%).

Un análisis más detallado de esta información señala que a edades más tempranas es mejor la percepción que se tiene del estado de salud del niño o la niña, siendo también mejores las opiniones cuanto más favorecido es el perfil socioeconómico del entorno familiar (mayor nivel de estudios del padre o la madre y clase social más alta).

Por áreas geográficas, el estado de salud de las y los menores se percibe mejor en las provincias de Granada y Jaén, y peor en Huelva y Málaga.

En resumen

Promoción de la salud (estilos de vida)

RELACIÓN DE INDICADORES CON VALORES INFERIORES RELATIVOS A LOS ESTILOS DE VIDA (PROMOCIÓN DE LA SALUD)

SEGÚN LA EAS Y ENS DE LA PROVINCIA DE GRANADA CON RESPECTO ANDALUCÍA

(valores registrados, en función de la información disponible)



Promoción de la salud (estilos de vida)

RELACIÓN DE INDICADORES CON VALORES SUPERIORES RELATIVOS A LOS ESTILOS DE VIDA (PROMOCIÓN DE LA SALUD)

SEGÚN LA EAS Y ENS DE LA PROVINCIA DE GRANADA CON RESPECTO ANDALUCÍA

(valores registrados, en función de la información disponible)



6. Problemas de Salud y Factores de Riesgo: IV Plan Andaluz de Salud y proceso de provincialización.

En Granada se inició el proceso de provincialización del IV Plan Andaluz de Salud (IV PAS) con la elaboración de un Análisis de Situación de Salud (similar a este mismo informe para Granada capital), realizado por un grupo de trabajo constituido con profesionales del Sistema Sanitario (Unidad de Gestión Clínica de Promoción de Salud y Vigilancia y Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales).

Tras la constitución del Comité Técnico de Salud en Todas las Políticas, este Análisis se completó con las aportaciones de otros sectores tales como Medio Ambiente, Agricultura, Vivienda, Educación y Empleo, dando lugar al documento Informe de Salud Provincial.

En el informe se detectaron una serie de problemas de salud, hábitos y determinantes en los cuales se haría necesaria la intervención.

Al tener como condición indispensable la máxima eficiencia en las intervenciones que el Plan Provincial determinará, se hacía necesario realizar una priorización de problemas en función de diversas variables a contemplar y desde diferentes ámbitos y visiones.

Para conseguir esta meta el método utilizado ha sido el Hanlon que permite establecer las prioridades basándose en una serie de criterios básicos, que tiene en cuenta, el volumen de población afectada, la disponibilidad de recursos, la factibilidad,...

Este método se ha llevado a cabo en tres reuniones diferentes y en fechas distintas. En dichas reuniones se expuso el resumen del Perfil Provincial de Salud y de las conclusiones con el objetivo de contextualizar y suministrar información acerca de los problemas detectados y en la segunda parte de la reunión se desarrolló la técnica utilizando el método antes descrito:

1ª) 28 de octubre de 2014: Reunión con personal técnico de Delegaciones Territoriales y de Servicios Provinciales de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial (33 asistentes), la mayor parte con nivel de Jefatura de Servicio.

2ª) 30 de octubre de 2014: Reunión con agentes locales pertenecientes a Ayuntamientos adheridos a la Red Local de Acción en Salud (28 participantes).

3ª) 31 de octubre de 2014: Encuentro de Asociaciones del ámbito de Salud y del ámbito Comunitario (84 participantes).

El resultado fue el siguiente:

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Granada	PRIORIZACIÓN FACTORES DE RIESGO/PROBLEMAS DE SALUD	PUNTUACIÓN TOTAL
	Dieta inadecuada	63
	Sedentarismo (tiempo libre)	59
	Sobrepeso-obesidad	57
	Sedentarismo en la población infantil	56
	Diabetes	51
	Enfermedades cardio-vasculares	51
	Tabaquismo	48
	Consumo de alcohol	47
	Accidentes de tráfico	39
	Consumo de medicamentos (trastornos depresivo-mentales)	38
	Fracaso escolar elevado y abandono escolar prematuro de casi el 30%	33
	Tendencia creciente consumo cannabis	32
	Trastornos depresivos-mentales	31
	Alta tasa de desempleo	28
	Esperanza de Vida en Buena Salud por debajo de la media de Andalucía	23
	La frecuentación en consulta médica en los Centros Sanitarios de Atención Primaria ha subido en 2013 con respecto a 2009 y en mujeres es muy superior a la de hombres	22
	Calidad del aire (Superación de valores legales tanto en Partículas en suspensión como en Dióxido de Nitrógeno en Granada y Área Metropolitana)	19
	Percepción mala salud	19
	Insuficiente infraestructuras para uso de transportes alternativos no contaminantes (carriles bici)	18
	Elevado número de infraviviendas	11
	Suicidio	8
	Progresivo envejecimiento población provincia	6

Los 22 problemas de salud, factores de riesgo o determinantes de la salud que fueron valorados en las tres reuniones ya priorizados en función de su magnitud, severidad, eficacia y factibilidad, se fueron agrupando de la siguiente manera, para conformar el Plan Provincial de Salud de Granada.

FACTORES DE RIESGO/ PROBLEMAS DE SALUD		AREA DE INTERVENCIÓN
Dieta inadecuada	ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	
Sedentarismo (tiempo libre)		
Sobrepeso-obesidad		
Sedentarismo en la población infantil		
Diabetes		
Enfermedades cardio-vasculares		
Tabaquismo	SALUD MENTAL Y ADICCIONES	
Consumo de alcohol		
Tendencia creciente consumo cannabis		
Consumo de medicamentos (trastornos depresivo-mentales)		
Trastornos depresivos-mentales		
Suicidio		
Fracaso escolar elevado y abandono escolar prematuro de casi el 30%	DESIGUALDADES SOCIALES	
Alta tasa de desempleo		
Elevado número de infraviviendas		
Desigualdad de género		
Accidentes de tráfico	MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	
Calidad del aire (Superación de valores legales tanto en Partículas en suspensión como en Dióxido de Nitrógeno en Granada y Area Metropolitana)		
Insuficiente infraestructuras para uso de transportes alternativos no contaminantes (carriles bici)		

Conclusión: se tiene en cuenta la importancia del trabajo intersectorial, la participación de todos los sectores y sus aportaciones claves, así como, la detección/identificación de las necesidades “sentidas” a través de los problemas de salud y/o factores de riesgo presentes en el territorio.

7. Recursos/Activos en Salud

7.1 Salud. Atención Primaria / Especializada y Centros

La relación de centros de salud del municipio de Granada son los siguientes:

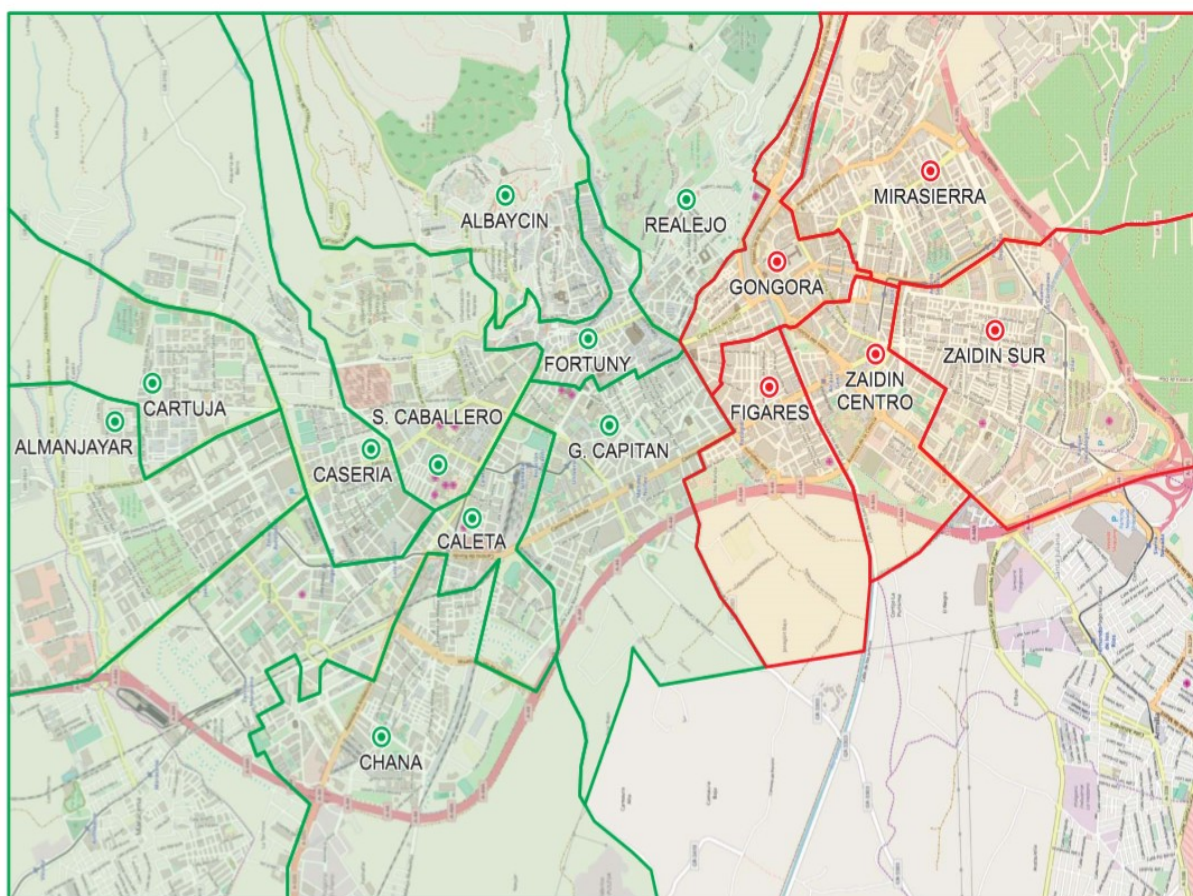
Nombre del centro	Tipo de centro	Distrito	Municipio	Provincia
Albaycín	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Albayda La Cruz	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Almanjáyar	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Cartuja	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Casería de Montijo	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Doctores Dr. Salvador Caballero García	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Fígares	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Fortuny (Velutti)	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Góngora	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Gran Capitán	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
La Caleta	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
La Chana	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Las Flores	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Mirasierra	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Realejo	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Zaidín Centro-Este	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Zaidín Sur	Centro de salud	Granada	Granada	Granada
Carretera de la Sierra	Consultorio	Granada	Granada	Granada
Cerrillo de Maracena	Consultorio	Granada	Granada	Granada
El Fargue	Consultorio	Granada	Granada	Granada
Parque Nueva Granada	Consultorio	Granada	Granada	Granada

Otros servicios y centros sanitarios:

Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía			
Criterios de búsqueda: Tipo de centro: Centros de consultas externas Provincia: Granada Municipio: granada			
Nombre del centro	Tipo de centro	Municipio	Provincia
C.P.E. Cartuja de Granada	Centro de consultas externas	Granada	Granada
C.P.E. Zaidín de Granada	Centro de consultas externas	Granada	Granada
Centro Licinio de la Fuente	Centro de consultas externas	Granada	Granada

Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía			
Criterios de búsqueda: Tipo de centro: Hospitales Provincia: Granada Municipio: granada			
Nombre del centro	Tipo de centro	Municipio	Provincia
Hospital Universitario San Cecilio	Hospital de especialidades	Granada	Granada
Hospital Universitario Virgen de las Nieves	Hospital regional	Granada	Granada

Mapa Sanitario por Unidades Gestión Clínica Granada (capital)



7.2 Proyectos y Programas de Prevención, Protección y Promoción de la Salud:

En este apartado, se incluyen aquellos proyectos, programas y demás intervenciones realizadas en Granada, relacionadas con la Promoción, Protección y Prevención de la Salud, puestos en marcha por las diferentes instituciones y organismos como Consejería y Delegación Territorial de Salud y Consumo, Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, por iniciativa propia por formar parte de sus contratos-programa y demás objetivos a cumplir, y/o en colaboración con la entidad local.

7.2.1.- Puntos Forma Joven:

El Programa Forma Joven es una estrategia de promoción de salud que consiste en acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación atendidas por un equipo de profesionales de diferentes sectores, para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables.

- **7.2.1.1.- Forma Joven IES y otros centros educativos**, en el curso 2022-2023, para más información sobre centros adheridos se puede consultar la web:

<https://www.formajoven.org/red-forma-joven-granada/>

- 7.2.1.2.- Puntos Forma Joven (externos, total de centros inscritos 14)

Entidad	Municipio
AGRAMECE- Plena Inclusión Andalucía	Granada
Aldeas infantiles SOS Granada	Granada
Centro de Día de Justicia Juvenil	Granada
Centro de Menores Ángel Ganivet	Granada
Centro de Menores Bermudez de Castro	Granada
Centro de Menores San Miguel Alto	Granada
Ciudad de los Niños	Granada
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada	Granada
El Pilar	Granada
Forma Joven Universidad de Granada	Granada
Fundación Purísima Concepción	Granada
Mensajeros de la Paz-Jardin de Daraja	Granada
Piso-Hogar "Hermanas Trinitarias"	Granada
SIMA Granada	Granada

7.2.2.- Programa “Creciendo en Salud”:

El Programa Creciendo en Salud, tiene como objetivo promover, entrenar y capacitar al alumnado para el desarrollo de habilidades cognitivos-conductuales que, de forma adaptada a cada edad, les permitan adoptar estilos de vida saludables, mediante la toma de decisiones razonadas en el marco de entornos no siempre favorables a la protección y al fomento de la salud.

Para más información, en el curso 2022-2023, se puede consultar la web:

<https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/creciendo-en-salud>

7.4 Asociaciones y Entidades de Voluntariado:

Pendiente de completar con la colaboración de los profesionales del Ayuntamiento de Granada.

7.5 Otros recursos Sociosanitarios:

Pendiente de completar con la colaboración de los profesionales del Ayuntamiento de Granada.

7.6 Infraestructuras para Ocio y Tiempo Libre:

Pendiente de completar con la colaboración de los profesionales del Ayuntamiento de Granada.

7.7 Equipamientos Polideportivos:

Pendiente de completar con la colaboración de los profesionales del Ayuntamiento de Granada.

Anexos

1. Resumen con una serie de indicadores sobre la situación de salud por Distritos Censales de Granada capital















Indicadores			Socio-Demográficos				Atención Salud (cobertura)		Estilos de vida (mediana)			Morbilidad (tasas)				
UGC	Distrito Censal	Barriadas de referencia	Ind. Envejecimiento	Ind. Dependencia	Ind. Juventud	Tasa Población Extranjera	Vacuna infantil menos de 2 años	Vacuna gripe +65 años	Interv. Av. Ind. ObesInf	Interv. Av. Ind. Tabag.	Interv. Consejo Dietético Adultos	Tasa Insuficiencia Cardíaca	Tasa HTA	Tasa Diabetes	Tasa EPOC	Tasa Asma Infantil (<14 años)
Albaicín	Albaicín	Albaicín, El Fargue, Haza Grande, Sacromonte	18,03	45,9	13,43	15,23	86,0%	54,0%	12,0%	17,7%	5,0%	3,2	12,8	6,6	4,1	15,6
Almanjazar	Norte	Almanjazar, La Paz, Rey Badi, Joaquina Egvaras	12,7	49,19	20,28	14,21	98,0%	62,0%	16,0%	29,8%	4,1%	7,2	12,5	6,2	3,9	23,0
Cartuja	Norte	Cartuja, Campo Verde	12,7	49,19	20,28	14,21	97,5%	46,0%	12,5%	1,7%	0,2%	3,2	10,0	7,8	5,5	16,0
Casería Montijo	Norte	Parque Nueva Granada, Casería de Montijo, San Francisco Javier	12,7	49,19	20,28	14,21	99,0%	54,0%	12,4%	10,1%	2,2%	3,3	13,5	7,5	5,1	16,2
Doctores	Beiro	Plaza de Toros-Doctores-San Lázaro, San Ildefonso, Cartuja	20,11	50,32	13,36	6,4	98,8%	60,0%	16,0%	16,0%	0,3%	2,9	12,9	5,9	3,6	12,4
Fortuny Velutti	Centro	Centro, San Ildefonso	21,92	49,15	11,03	12,51	97,5%	47,0%	13,2%	23,0%	1,5%	2,9	9,0	5,8	3,7	7,2
Góngora	Genil	Centro, Carretera de la Sierra, Cervantes	18,53	50,97	15,23	4,13	96,0%	57,0%	8,0%	0,2%	0,4%	2,1	9,8	6,5	3,6	12,7
Gran Capitán	Centro/Ronda	Centro, Camino Ronda	25,39	59,74	12,01	8,3	97,8%	50,0%	10,0%	0,4%	0,2%	2,8	11,0	5,8	3,8	4,9
La Caleta Albayda	Beiro	La Cruz, Cerrillo Maracena, Pajaritos, Camino Ronda, Juventud	20,11	50,32	13,36	6,4	97,8%	55,0%	6,0%	3,0%	3,4%	4,1	10,2	5,9	3,6	8,2
La Chana	Chana	Chana, Bobadilla, Rosaleda	19,48	47,97	12,94	8,63	99,0%	65,0%	14,0%	0,2%	6,2%	3,1	10,1	7,2	2,7	11,4
Las Flores	Ronda Centro	Camino Ronda, Centro, Figares	25,39	59,74	12,01	8,3	97,8%	54,0%	14,8%	5,0%	0,4%	1,7	11,0	6,8	2,8	7,7
Bola de Oro Mirasierra	Genil	Bola Oro, Cervantes, Carretera Sierra, Castaño Mirasierra, Lancha Genil, Camino Neveros	18,53	50,97	15,23	4,13	99,4%	60,0%	9,0%	3,0%	4,0%	2,5	13,8	6,6	3,2	7,2
Realejo	Centro	Realejo, San Matías	21,92	49,15	11,03	12,51	97,8%	50,0%	17,5%	4,8%	1,8%	6,8	11,4	6,0	3,9	13,4
Zaidín Sur	Zaidín	Zaidín-Vergeles	23,86	58,76	13,16	9,22	97,8%	52,0%	15,0%	11,0%	5,8%	5,1	13,8	7,8	4,6	12,3
Zaidín Centro Este	Zaidín	Zaidín-Vergeles	23,86	58,76	13,16	9,22	96,0%	58,0%	14,0%	8,0%	5,6%	2,7	14,0	7,8	4,0	10,0
Municipio Granada			21,13	55,99	14,35	8,49	97,1%	55,0%	12,5%	7,6%	2,5%	3,2	11,9	6,5	3,8	12,4
Distrito Granada-Metrop			15,73		19,13		98,0%	58,0%	12,8%	14,8%	3,1%	4,4	12,1	7,2	3,9	12,5
Provincia Granada			18,12	50,73	15,75	6,25										

Descripción de Indicadores

Socio-Demográficos



Índice envejecimiento: proporción de población mayor de 65 años, sobre el total de la población de referencia

Índice dependencia: refleja la proporción: Población joven 0-15 años + Población más de 65/ Población adulta 16-64 años) x 100

Índice de juventud: población menor de 16 años frente a la población total).

Tasa de población extranjera: refleja la proporción de población extranjera sobre el total de la población de referencia

Atención Salud (coberturas)

Vacuna infantil (-2 años): cobertura de vacunación completa hasta los 2 años

Vacuna gripe (+65 años): cobertura de vacunación de la gripe para 65 y más años

Estilos de vida (medianas, período de referencia)

Intervención avanzada individual obesidad infantil: porcentaje de niños/as con intervención avanzada individual en consulta (con padres/madres)

Intervención avanzada individual tabaquismo: porcentaje de personas mayores de 16 años con intervención avanzada individual en tabaquismo

Intervención consejo dietético adultos: porcentaje de personas adultas (mayores de 14 años), que reciben consejo dietético

Morbilidad (tasas)

Tasa insuficiencia cardíaca: porcentaje de personas con IC sobre el total de la población de referencia

Tasa de HTA: porcentaje de personas hipertensas sobre el total de la población de referencia

Tasa de Diabetes: porcentaje de personas con diabetes mellitus sobre el total de la población de referencia

Tasa EPOC: porcentaje de personas con EPOC sobre el total de la población de referencia

Tasa Asma infantil: porcentaje de personas menores de 14 años con asma infantil sobre el total de la población de referencia

2. Tabla de Equivalencias Distritos Censales Ayuntamiento Granada – Unidades Asistenciales Salud

Distritos	Composición Barriadas
-----------	-----------------------

Censales	
Albaicín	Albaicín, El Fargue, Haza Grande y Sacromonte.
Beiro	Joaquina Eguaras, La Cruz, Pajaritos, Plaza de Toros-Doctores-San Lázaro, San Francisco Javier y San Ildefonso
Centro	Centro-Sagrario y Realejo-San Matías.
Chana	Angustias-Chana-Encina, Bobadilla y Cerrillo de Maracena.
Genil	Bola de Oro, Camino de los Neveros, Carretera de la Sierra, Castaño-Mirasierra, Cervantes y Lancha del Genil.
Norte	Almanjáy, Campo Verde, Cartuja, Casería de Montijo, Parque Nueva Granada, La Paz y Rey Badis.
Ronda	Camino de Ronda, Figares y Rosaleda.
Zaidín	Zaidín-Vergeles.

Centro Salud Referencia	Distrito Censal de referencia	Barriadas de referencia
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Albaicín	Albaicín	Albaicín, El Fargue, Haza Grande, Sacromonte, Beas de Gr., Jun y Huetor Santillan
Albayda La Cruz	Beiro	La Cruz, Cerrillo Maracena
Doctores Dr. Salvador Caballero García	Beiro	Plaza de Toros-Doctores-San Lázaro, San Ildefonso, Cartuja
La Caleta	Beiro	Pajaritos, Camino Ronda, Juventud
Las Flores (Fígares)	Centro	Centro, Fígares
Fortuny (Velutti)	Centro	Centro, San Ildefonso
Gran Capitán	Centro	Centro, Camino Ronda
Realejo	Centro	Realejo, San Matías
La Chana	Chana	Chana, Bobadilla, Rosaleda
Góngora	Genil	Centro, Carretera de la Sierra, Cervantes
Mirasierra (Bola de Oro)	Genil	Bola Oro, Cervantes, Carretera Sierra, Castaño-Mirasierra, Lancha Genil, Cno. Neveros
Almanjáyar	Norte	Almanjayar, La Paz, Rey Badis, Joaquina Eguaras
Cartuja	Norte	Cartuja, Campo Verde
Casería de Montijo	Norte	Parque Nueva Granada, Casería de Montijo, San Francisco Javier
Gran Capitán (II)	Ronda	Camino Ronda
Las Flores (Fígares II)	Ronda	Camino Ronda
Zaidín Centro-Este	Zaidín	Zaidín-Vergeles
Zaidín Sur	Zaidín	Zaidín-Vergeles

ANEXO. 4,4 DATOS ANTERIORES A 2019 DESAGREGADOS POR UNIDADES ASISTENCIALES

4.1 Morbilidad y principales problemas de salud.

La Morbilidad es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es un dato estadístico de importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.

- 4.1.1.-Enfermedades Crónicas:

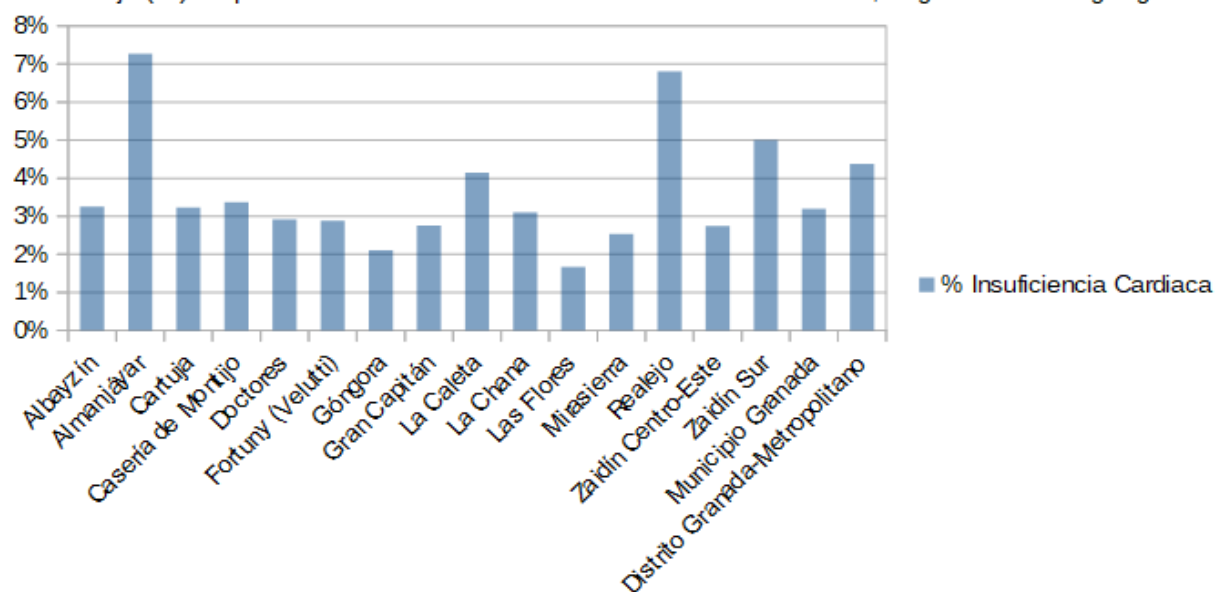
Las enfermedades crónicas, según la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta, como las cardiovasculares y respiratorias, el cáncer o la diabetes. Son patologías para las cuales aún no se conoce una solución definitiva, produciendo el 63% de las muertes en el mundo.

La distribución por las diferentes Unidades de Gestión Clínica de Granada son (Ver su correspondencia por barrios en el Mapa Sanitario, apartado 7.1.):

- Insuficiencia Cardíaca (IC):

El porcentaje de personas diagnosticadas de IC, en relación a los mayores de 65 años en la ciudad de Granada, es similar al del Distrito Sanitario, por zonas destacan las UGC de Almanjáyar y Realejo.

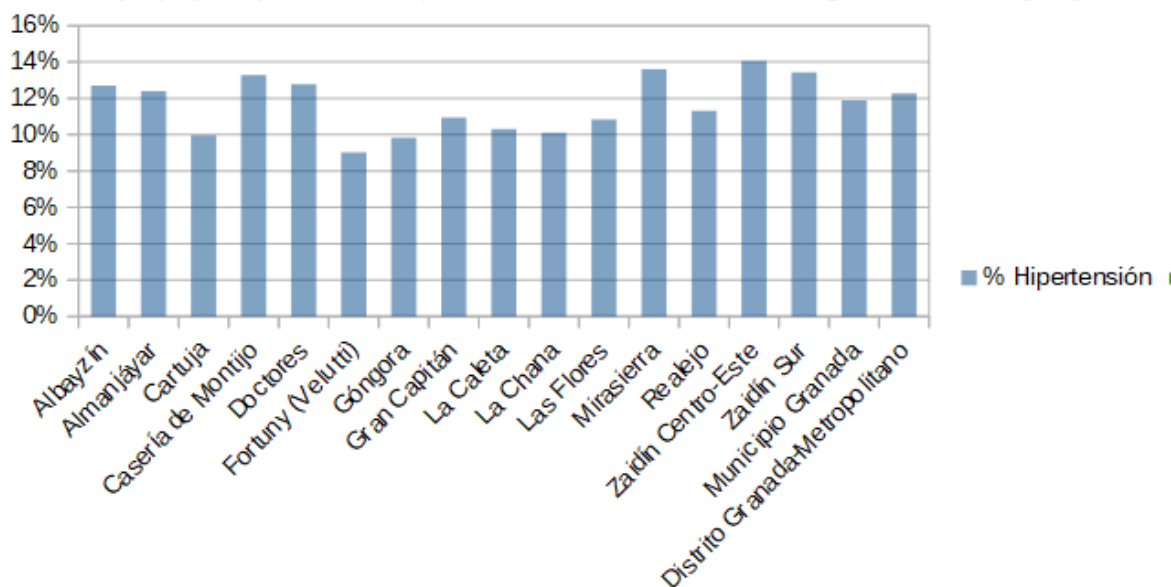
Porcentaje (%) de personas con Insuficiencia Cardíaca en el año 2017, según el ámbito geográfico



- Hipertensión Arterial :

El porcentaje de personas hipertensas en la ciudad de Granada, es similar al del Distrito Sanitario. Destaca la prevalencia en las UGC de Zaidín Centro y Sur, Mirasierra y Casería de Montijo.

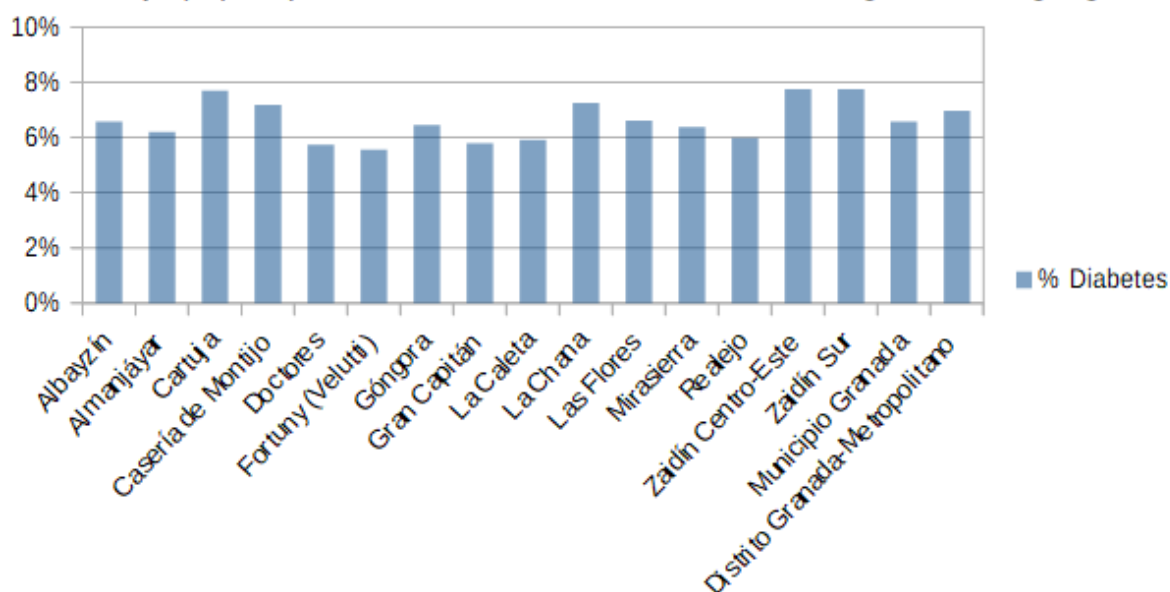
Porcentaje (%) de personas hipertensas en el año 2017, según el ámbito geográfico



- Diabetes Mellitus:

El porcentaje de personas diabéticas en la ciudad de Granada, es similar a la del Distrito Sanitario. La mayor prevalencia se localiza en las UGC del Zaidín y Cartuja.

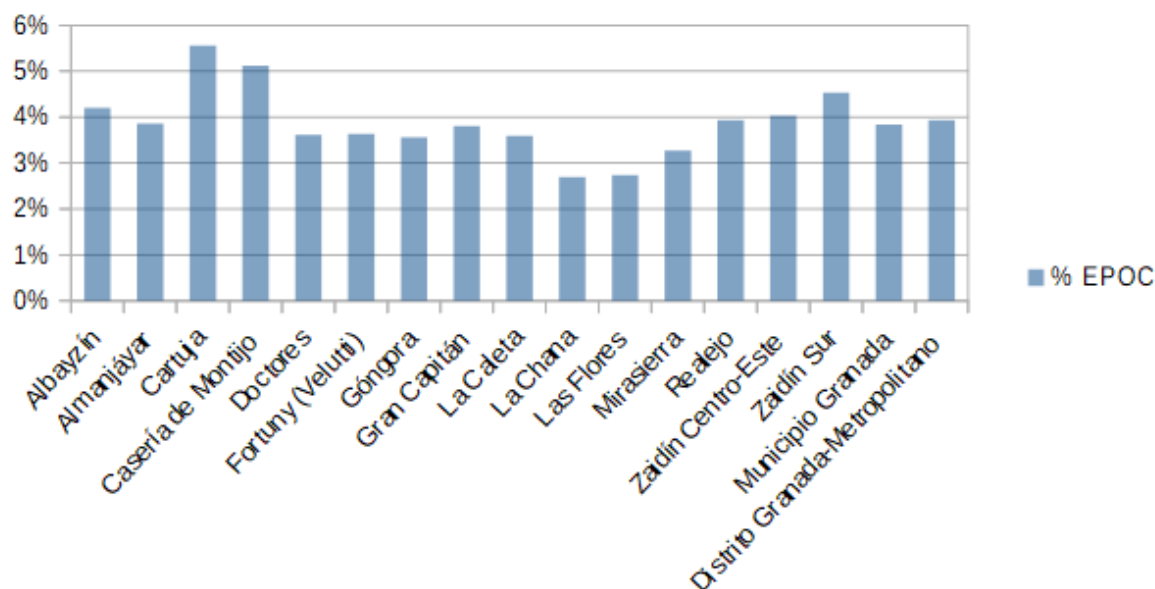
Porcentaje (%) de personas diabéticas, en el año 2017, según ámbito geográfico



- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC):

El porcentaje de personas con EPOC, en relación a los mayores de 40 años en la ciudad de Granada, es similar a la del Distrito Sanitario. La mayor prevalencia se localiza en las UGC de Cartuja y Casería de Montijo.

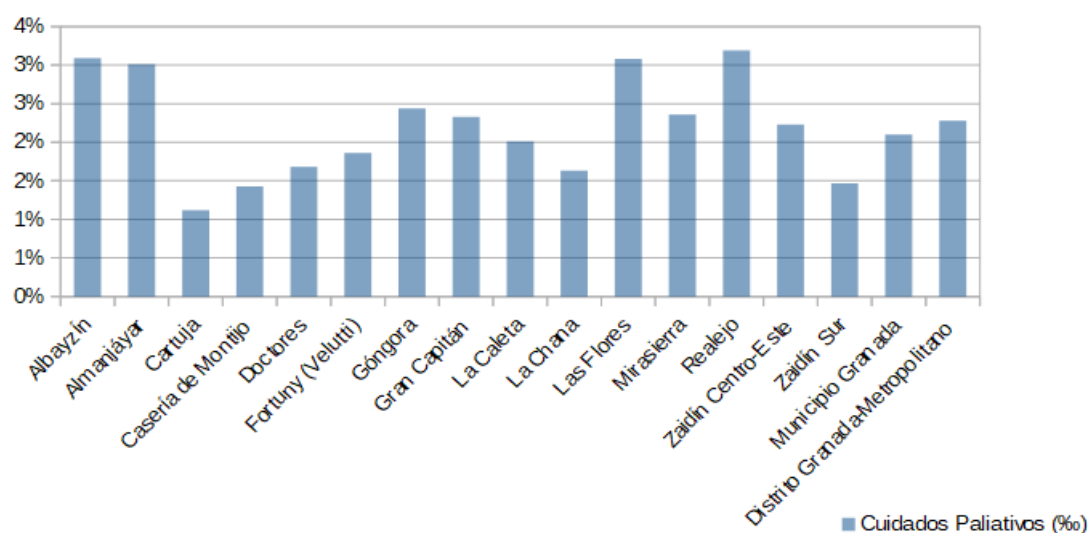
Porcentaje (%) de personas con EPOC, en el año 2017, según ámbito geográfico



- Cuidados Paliativos:

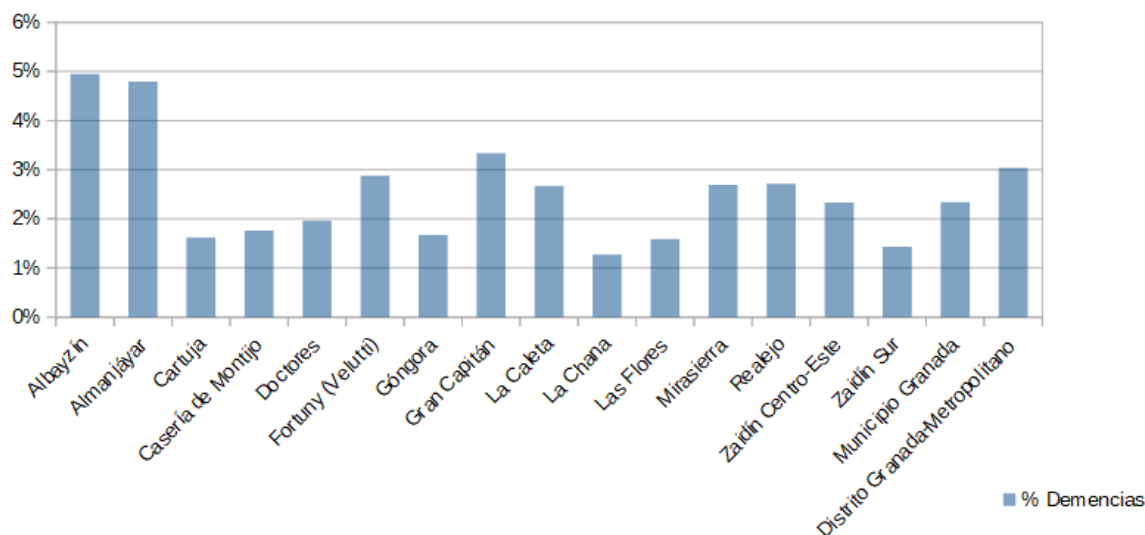
Las personas incluidas en Cuidados Paliativos en la ciudad de Granada, es similar a la del Distrito Sanitario y las UGC con cifras superiores son Realejo, Albayzín y Las Flores.

Cobertura de personas en Cuidados Paliativos, año 2017, según ámbito geográfico (x 1000 hab.)



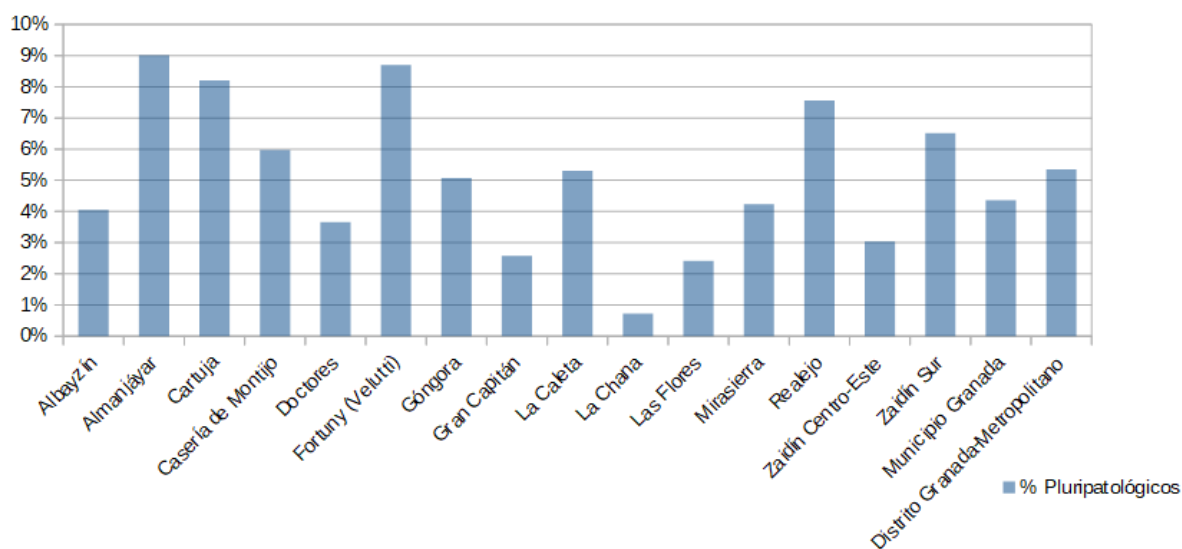
Demencias: Las personas diagnosticadas de Demencia, en relación a los mayores de 65 años en Granada, es inferior a la del Distrito Sanitario, siendo las UGC con cifras más altas Albayzín y Almanjáy, aunque pueden estar vinculadas con la existencia de Residencias de Mayores.

Porcentaje (%) de personas con Demencias en mayores de 65 años, año 2017, según ámbito geográfico



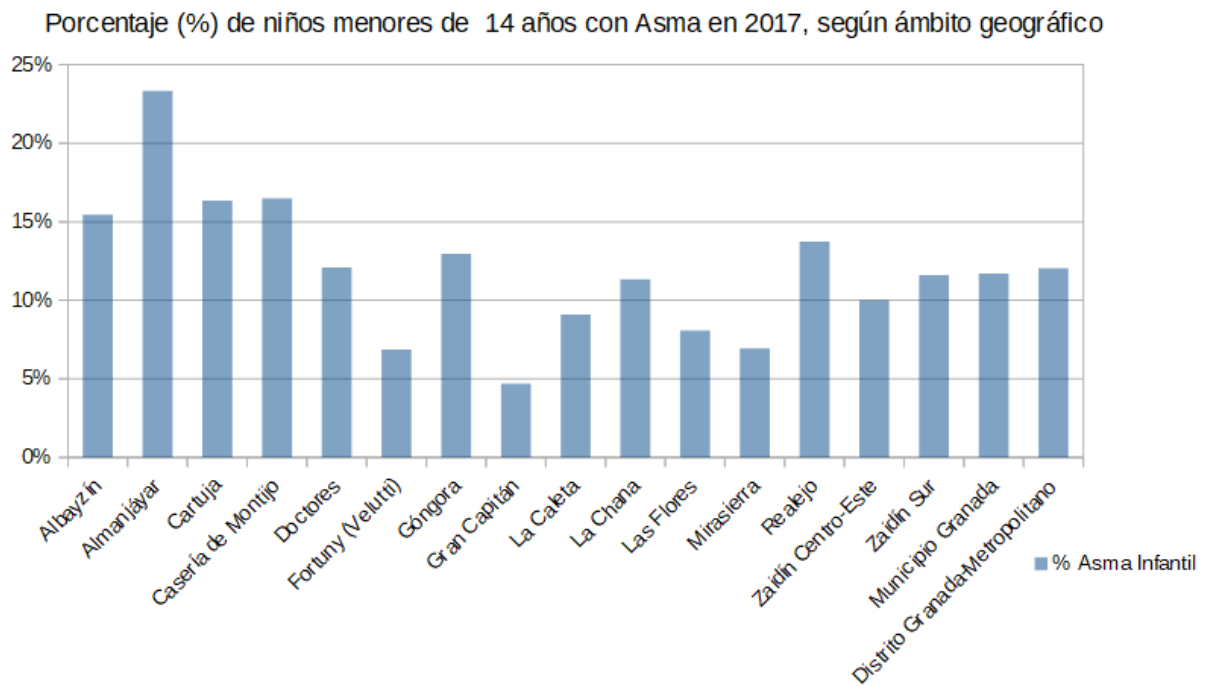
- **Atención al Paciente Pluripatológico:** Las personas incluidas en el Proceso Asistencial Integrado (PAI) de Atención al Paciente Pluripatológico (pacientes crónicos con necesidades complejas de salud), en relación a los mayores de 65 años de Granada, es inferior a la del Distrito Sanitario, siendo las UGC con cifras más altas Almanjáy y Fortuny.

Porcentaje (%) de personas incluidas en el PAI Atención al Paciente Pluripatológico, en mayores de 65 años, año 2017, según ámbito geográfico



Asma Infantil:

Los usuarios diagnosticados de Asma Infantil, menores de 14 años de Granada, son similares a los del Distrito Sanitario, siendo las UGC con cifras más altas Almanjáyar, Casería de Montijo y Cartuja.



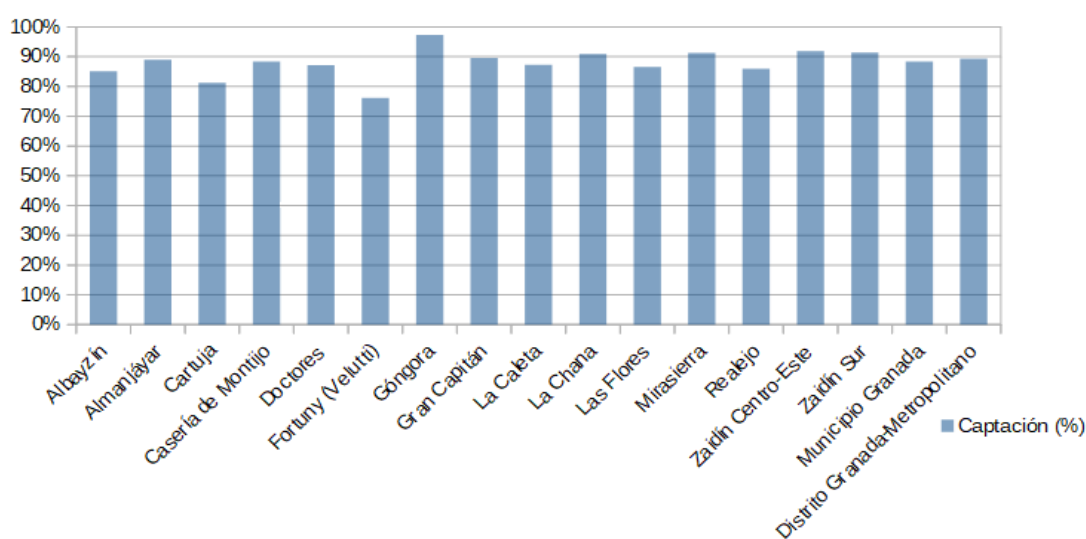
4.2 Atención a la salud a lo largo de la vida:

- 4.2.1- Diagnostico Precoz Cáncer y Cribados:

- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama.

La proporción de mujeres (50 y 69 años), que acuden a la cita para diagnóstico precoz de cáncer de mama (tasa de captación) es alto, destacando la UGC de Góngora. La tasa de detección de tumores de mama fue de 3,63‰, de las mujeres exploradas.

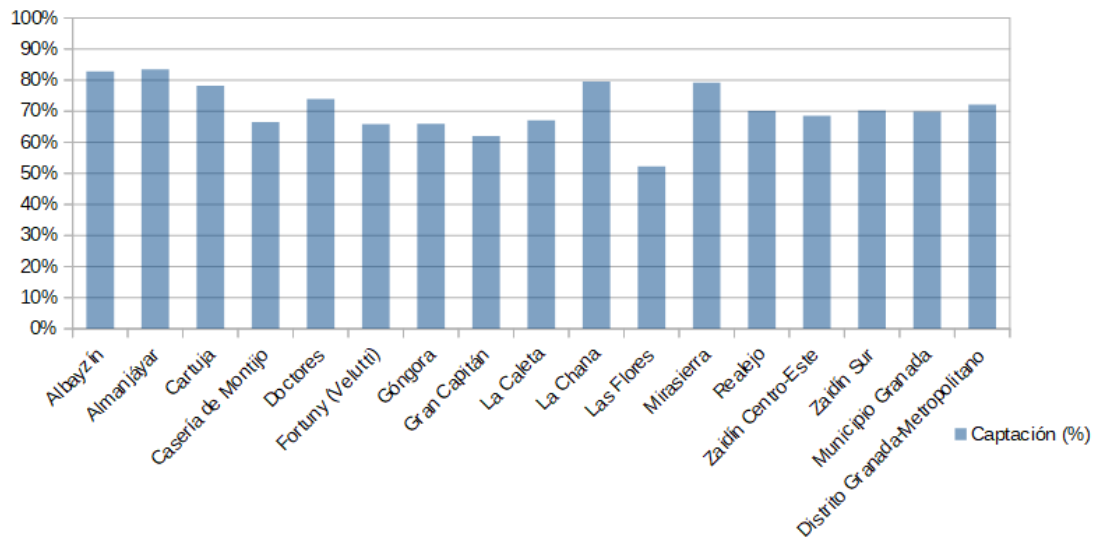
Porcentaje (%) de mujeres que acuden a la cita, entre las citadas, en el año 2017, según el ámbito geográfico



- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Cérvix/Útero.

El porcentaje de mujeres, entre 25 y 64 años de edad, que acuden a la cita para diagnóstico precoz de cáncer de cervix/útero, es similar al del Distrito, destacando las UGC de Almanjáy y Albayzín.

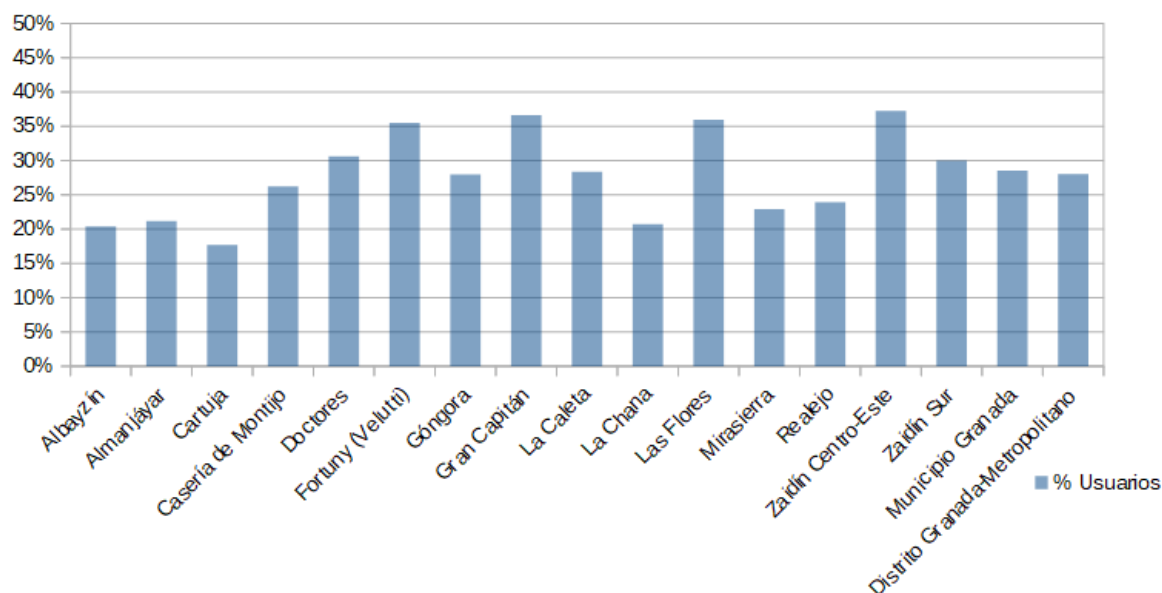
Porcentaje (%) de mujeres incluidas en el diagnóstico Precoz del Cáncer de Cervix/Útero, en el año 2017, según el ámbito geográfico



- Diagnóstico Precoz de Cáncer de Próstata/Hiperplasia Benigna (HBP).

El porcentaje de hombres, entre 50 y 70 años de edad, que acuden a la cita para diagnóstico precoz de Cáncer de Próstata/HBP, es algo superior al del Distrito, destacando las UGC de Gran Capitán y Las Flores.

Porcentaje (%) de hombres incluidos en el diagnóstico de Cáncer de Próstata/HBP, en el año 2017, según el ámbito geográfico



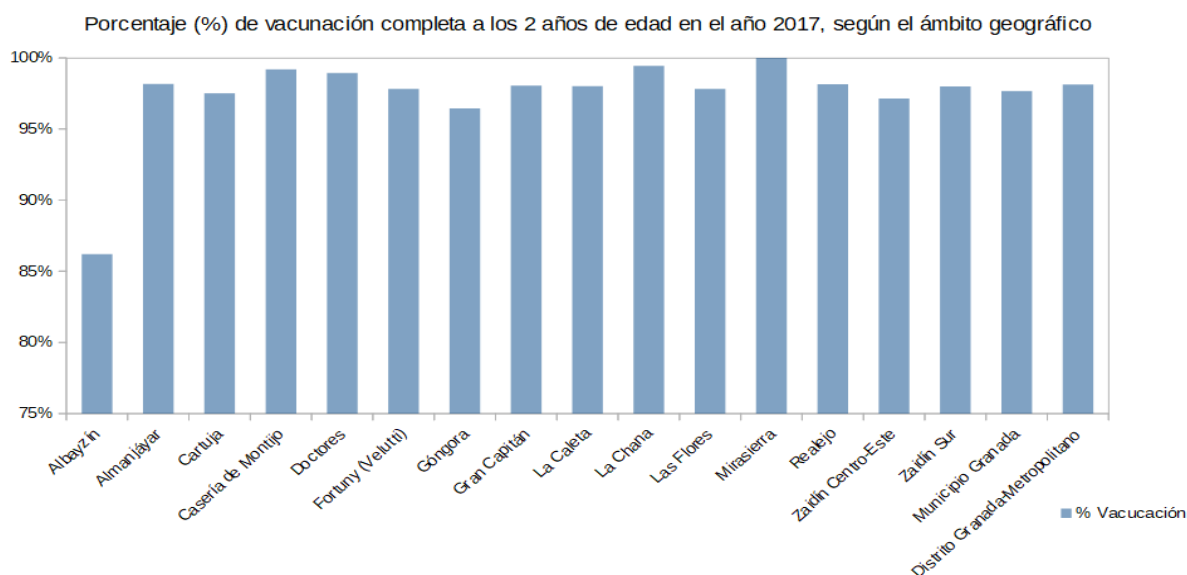
- Prueba del Talón.

Durante el año 2017, se realizaron 2081 pruebas del Talón a recién nacidos con domicilio en la ciudad de Granada, para descartar enfermedades congénitas graves, de las que 2079 (99,9%) resultaron normales.

4.2.2- Vacunaciones:

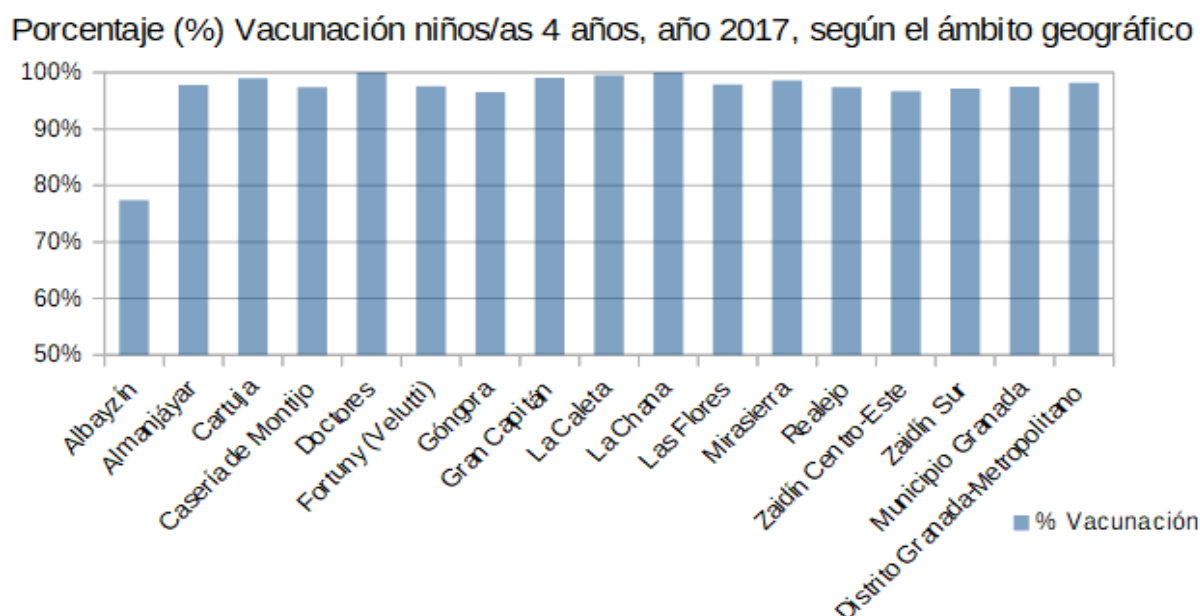
- Calendario de Vacunaciones, Vacunación Completa a los 2 años.

Destaca la alta cobertura de las vacunaciones incluidas en el Calendario de Vacunaciones de Andalucía, para los niños /as de 2 años de edad, salvo en la UGC de Albayzín.



- Calendario de Vacunaciones, Vacunación 4 años, con 2 dosis de Triple Vírica.

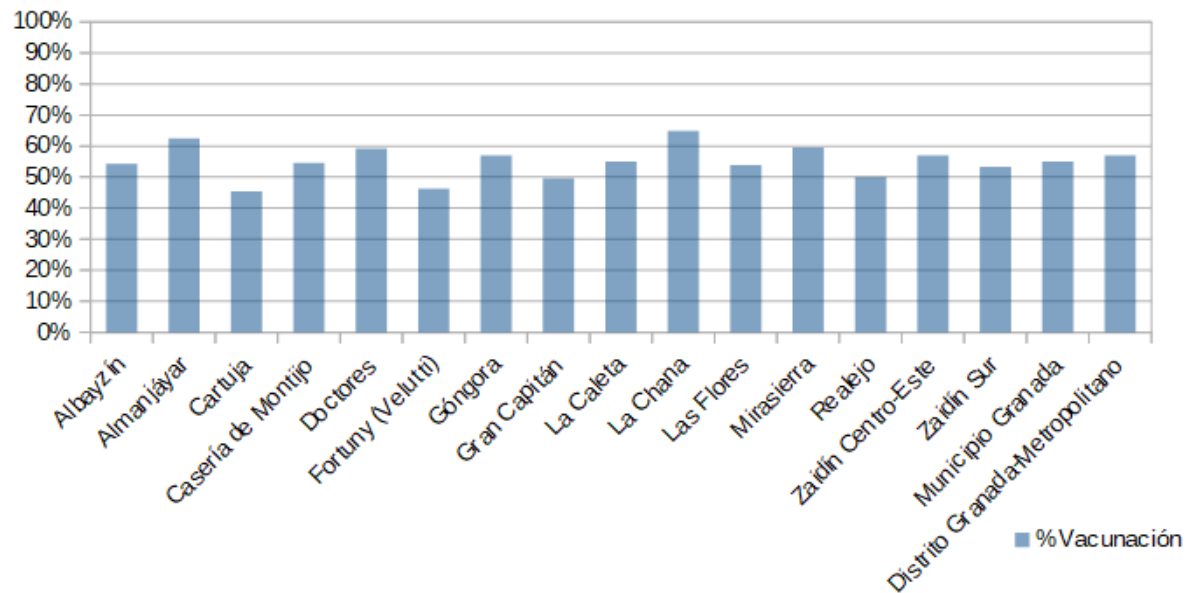
Alta cobertura de la vacunación con 2 dosis de Triple Vírica, para los niños/as de 4 años de edad, salvo en la UGC de Albayzín.



- Vacunación contra la Gripe, en mayores de 65 años.

Uno de los principales grupos de riesgo de presentar complicaciones al padecer la gripe, son los mayores de 65 años; las coberturas de vacunación más altas están en las UGC de La Chana y Almanjáy.

Porcentaje (%) de vacunación en los mayores de 65 años, año 2017, según el ámbito geográfico

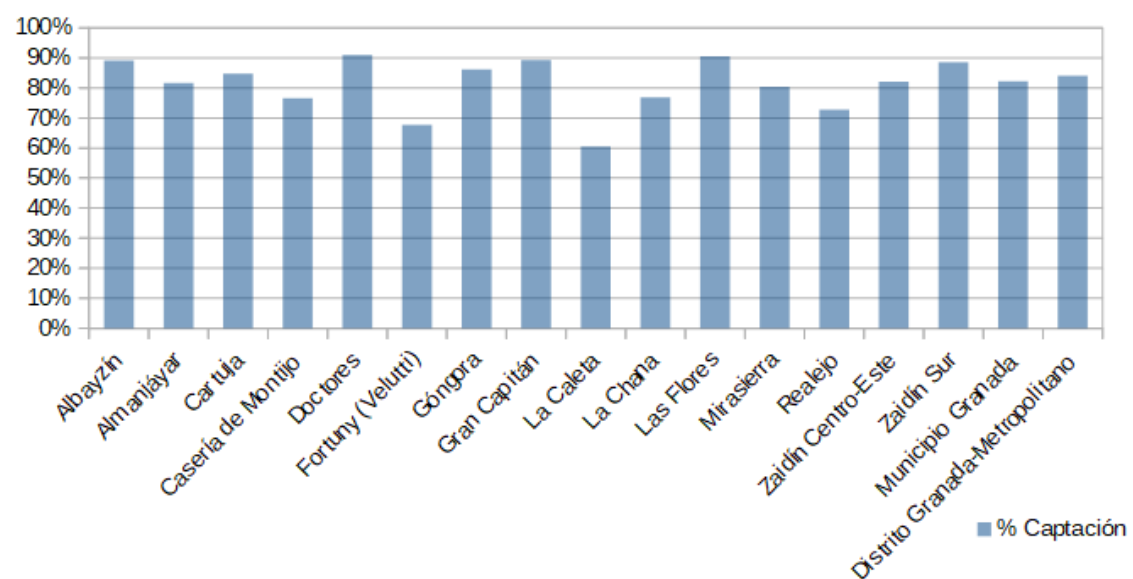


- 4.2.3- Embarazo:

- Captación Precoz en el Embarazo.

La mayoría de las embarazadas acude precozmente al Centro de Salud, destacando en las UGC de Doctores y Las Flores.

Porcentaje (%) de embarazadas con 1ª visita antes de la 12 semana Gestación, año 2017, según el ámbito geográfico

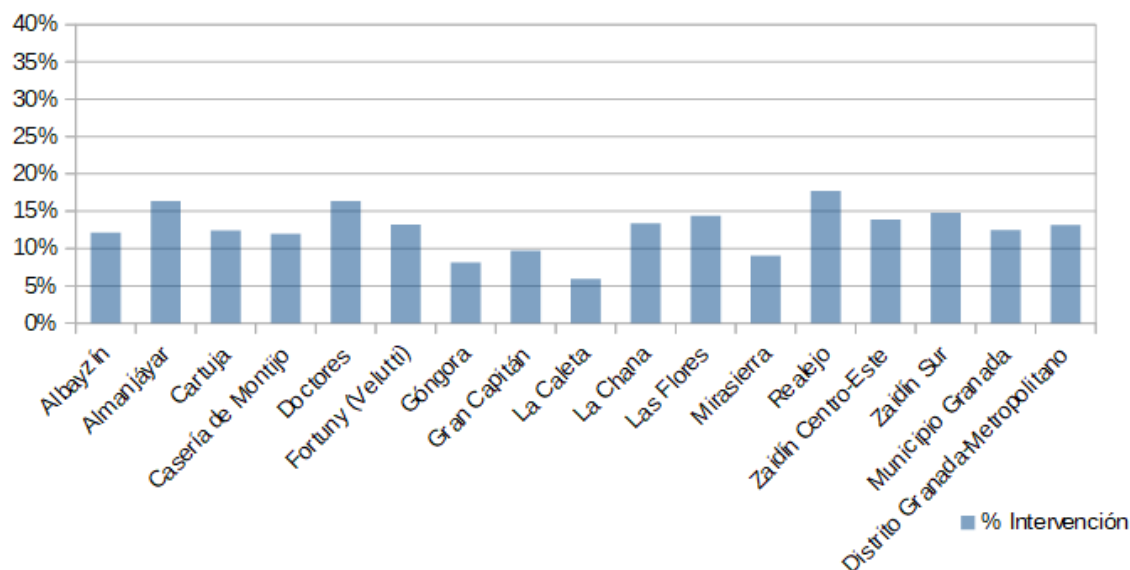


- 4.2.4- Estilos de Vida:

- Intervención Avanzada en Obesidad Infantil (IAI).

En las UGC del Realejo, Doctores y Almanjáyar es donde más intervenciones avanzadas individuales realizan los pediatras, con los padres en temas relacionados con la Obesidad Infantil (menores entre 6 y 14 años).

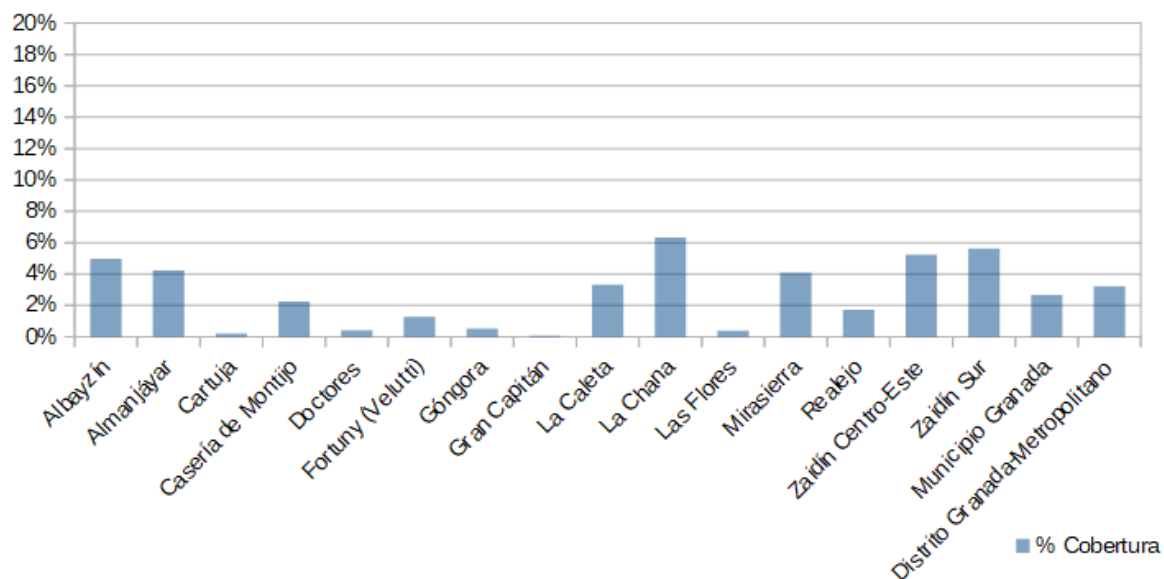
Porcentaje (%) niños/as con I.A.I. en Obesidad Infantil, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico



- Consejo Dietético Individual en adultos.

También se llevan a cabo actividades relacionadas con la alimentación en adultos (mayores de 14 años), destacando las UGC de La Chana, Zaidín Centro y Sur.

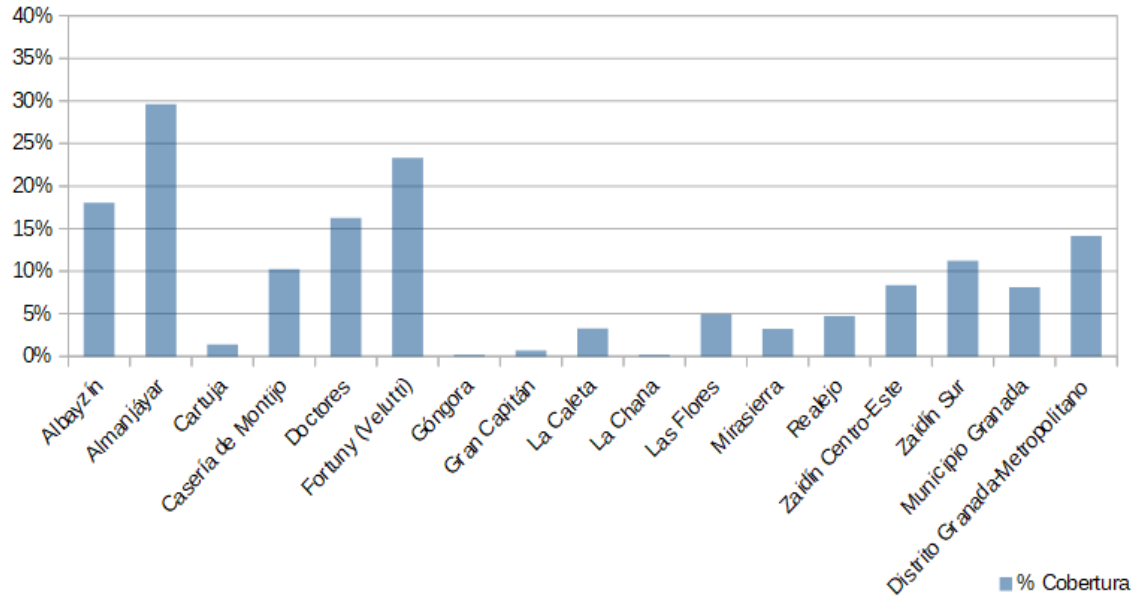
Porcentaje (%) adultos que reciben Consejo Dietético Intensivo Individual, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico



- Intervención Avanzada Individual para dejar el tabaco.

En las UGC de Almanjáy y Fortuny, son donde destacan las actividades relacionadas con el Tabaquismo en adultos (mayores de 16 años).

Porcentaje (%) de mayores de 16 años con Intervención Avanzada Individual en Tabaquismo, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico



4. Análisis Epidemiológico

La información que aporta la Epidemiología contribuye al conocimiento de la situación de salud una población y es una ayuda importante para la planificación y diseño de las estrategias de intervención para el control de los distintos problemas de Salud Pública.

4.1 Morbilidad y principales problemas de salud.

La Morbilidad es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es un dato estadístico de importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.

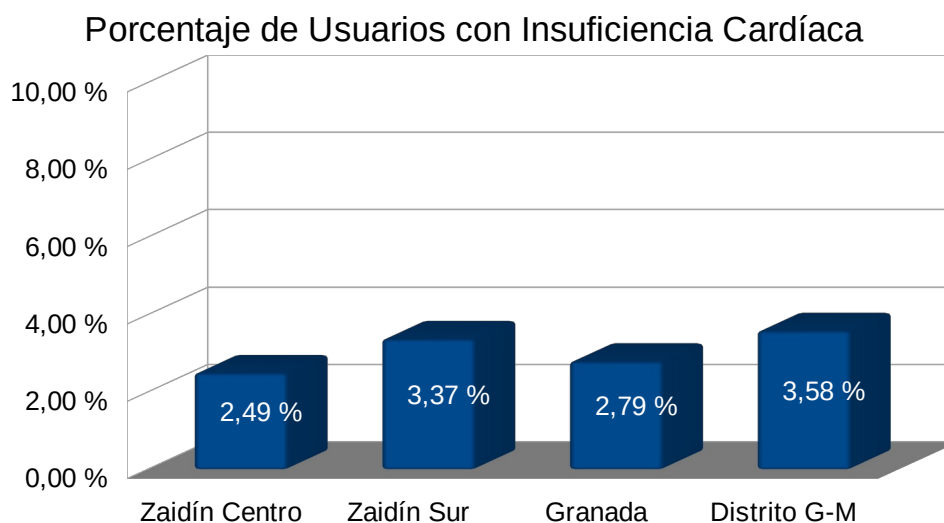
- 4.1.1.-Enfermedades Crónicas:

Las enfermedades crónicas, según la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta, como las cardiovasculares y respiratorias, el cáncer o la diabetes mellitus. Son patologías para las cuales aún no se conoce una solución definitiva, relacionándose con el 63% de las muertes en el mundo. Se han seleccionado las patologías crónicas más prevalentes y de mayor relevancia.

La distribución de estas enfermedades crónicas entre la población del barrio del Zaidín de Granada y en sus correspondientes Unidades Asistenciales del Zaidín Centro y Sur puede verse a continuación:

- Insuficiencia Cardíaca (IC):

Durante el año 2021, el porcentaje de personas diagnosticadas de IC, en relación a los mayores de 65 años en la U.A. Zaidín Sur es ligeramente superior a U.A. Zaidín Centro y a la ciudad de Granada, aunque inferior a la del Distrito Sanitario Granada Metropolitano.

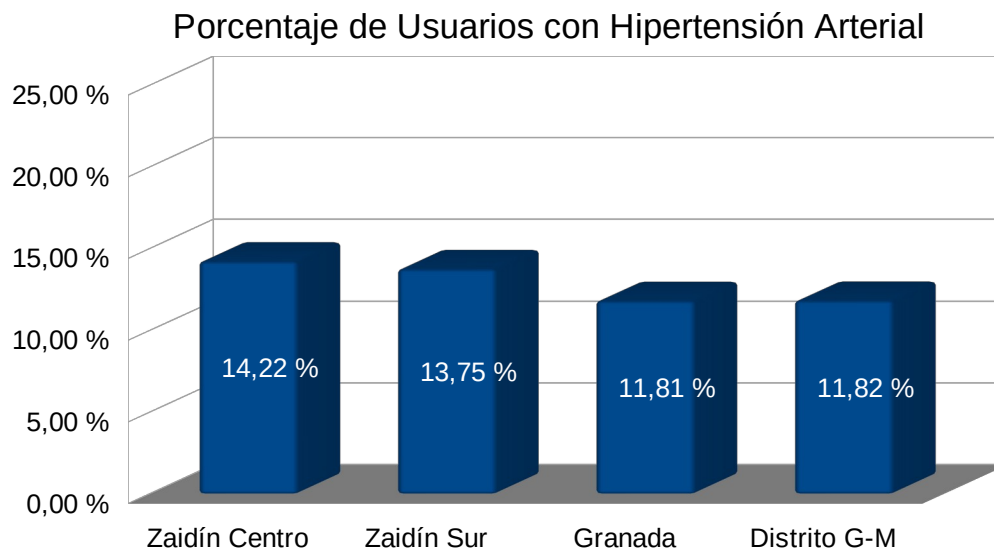


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas mayores de 65 años, incluidos en el Proceso Asistencial de Insuficiencia Cardíaca, año 2021.

- Hipertensión Arterial :

El porcentaje de personas hipertensas durante el año 2021, en las UA del Zaidín son similares entre ellas y ligeramente superiores a las de la ciudad de Granada y Distrito Sanitario Granada Metropolitano.

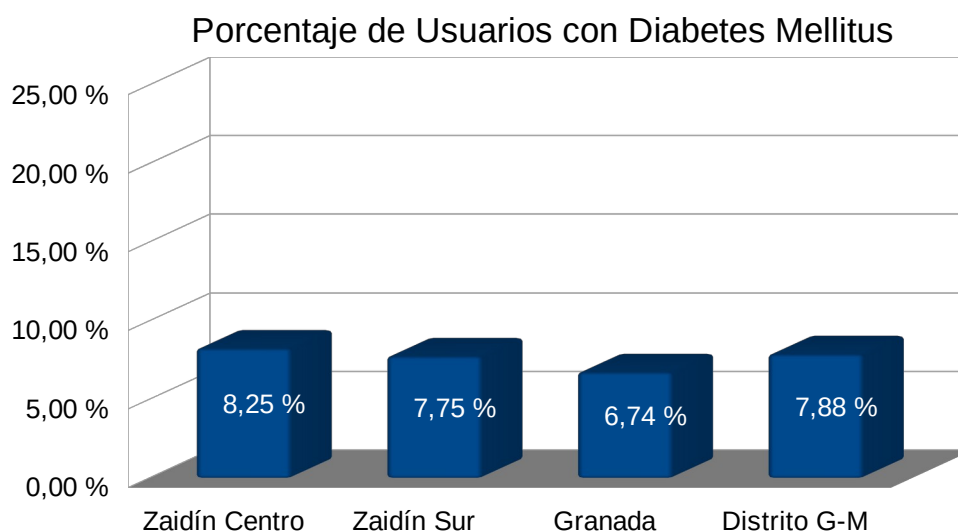


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas diagnosticadas de Hipertensión Arterial, año 2021.

- Diabetes Mellitus:

Durante 2021, el porcentaje de personas diabéticas es muy similar en los diferentes ámbitos geográficos, destacando ligeramente la UA Zaidín Centro.

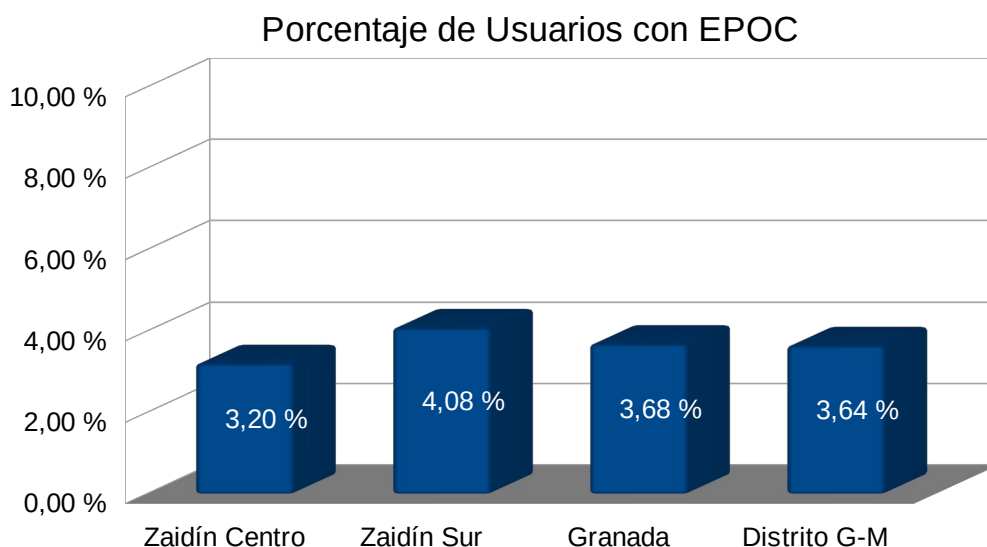


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas con Diabetes Mellitus, año 2021.

- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC):

El porcentaje de personas con EPOC mayores de 40 años durante 2021, fue similar en los diferentes ámbitos geográficos; la mayor prevalencia se localiza en la UA Zaidín Sur.

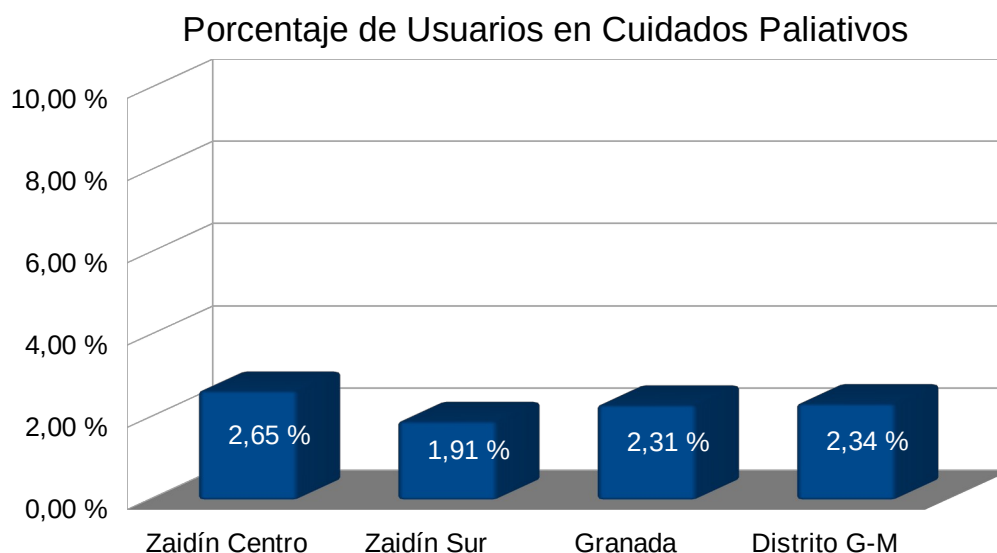


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas diagnosticadas de EPOC, año 2021.

- Cuidados Paliativos:

El porcentaje de personas incluidas en Cuidados Paliativos durante 2021, fue similar en los diferentes ámbitos geográficos; destaca ligeramente la prevalencia en la UA Zaidín Centro.

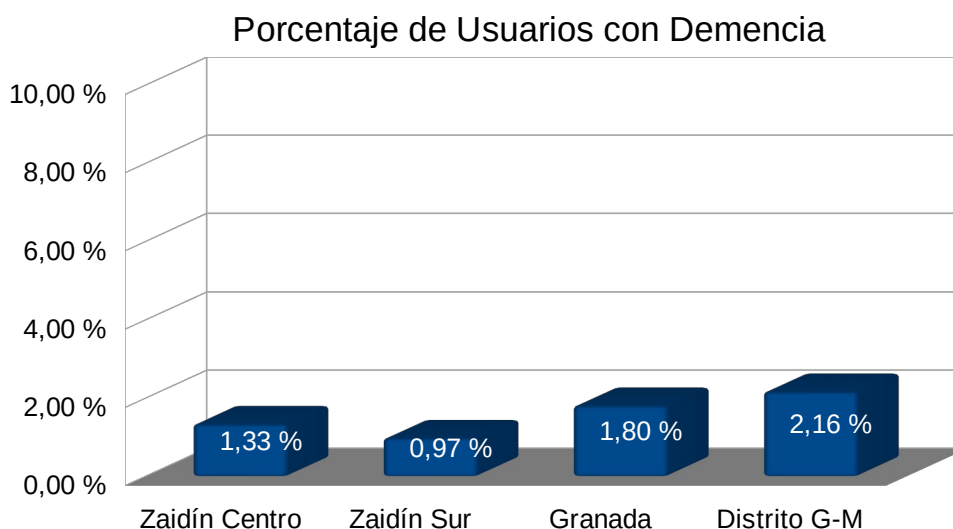


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas incluidas en Cuidados Paliativos, año 2021.

- Demencias:

El porcentaje de personas diagnosticadas de Demencia, en relación a los mayores de 65 años en las UA del Zaidín, es inferior a las del Distrito Sanitario y ciudad de Granada. Estas cifras pueden estar vinculadas con la mayor existencia de Residencias de Mayores en otros ámbitos.

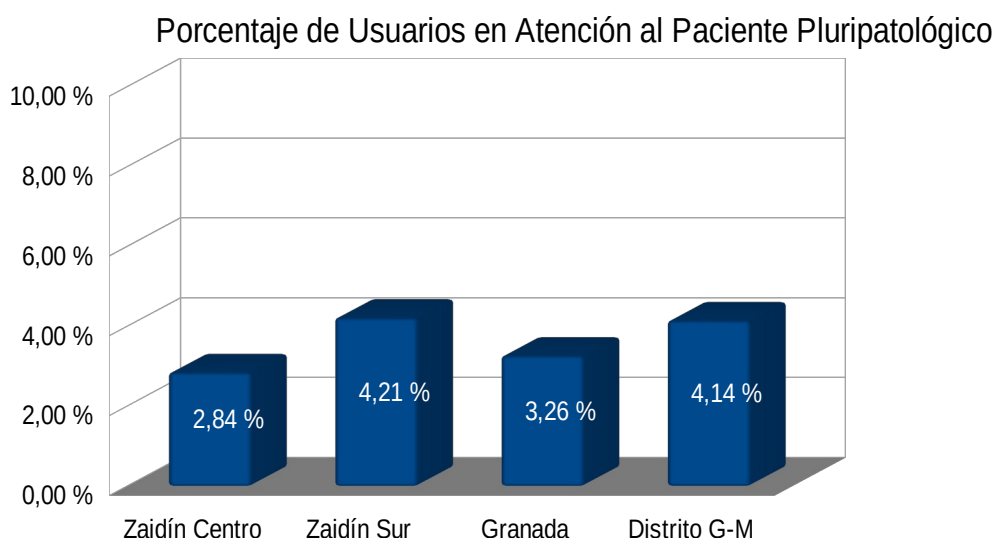


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas mayores de 65 años con Demencia, año 2021.

- Atención al Paciente Pluripatológico:

Las personas incluidas en el Proceso Asistencial Integrado de Atención al Paciente Pluripatológico (pacientes crónicos con necesidades complejas de salud), en relación a los mayores de 65 años, es inferior en a UA Zaidín Centro.

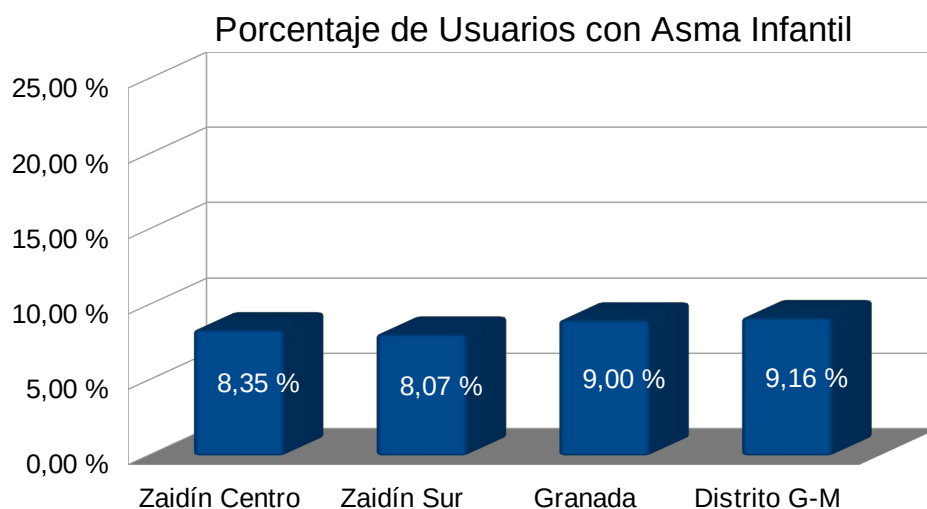


Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas mayores de 65 años incluidas en el Proceso de Atención al Paciente Pluripatológico, año 2021.

- Asma Infantil:

La prevalencia de Asma Infantil (menores de 14 años), es similar en los diferentes ámbitos geográficos, siendo ligeramente más baja en la UA Zaidín Sur.



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Porcentaje de personas menores de 14 años con diagnóstico de Asma Infantil, año 2021.

– 4.1.2.- Incidencia de Cáncer:

No hay estadísticas oficiales consistentes y fiables por barrios o Unidades Asistenciales, por lo que se analiza el municipio de Granada.

La incidencia de cánceres en la ciudad de Granada ha aumentado un 9% entre los quinquenios 2009/2013 al 2013/2017, debido fundamentalmente al crecimiento del cáncer de piel no melanoma, que es un tumor de buen pronóstico en general; así, la Tasa Bruta de incidencia pasó de 760 casos por 100.000 habitantes a 839, en el segundo quinquenio.

TIPO CÁNCER	Nº de Cánceres Hombres (2013-2017)	Nº de Cánceres Mujeres (2013-2017)	Nº de Cánceres Ambos Sexos (2013-2017)	Nº de Cánceres Ambos Sexos (2009-2013)	Tasas Brutas GRANADA (Municipio) Media anual (2013- 2017)
Piel (no melanoma)	1524	1437	2961	2190	251,2
Mama	10	984	994	867	155,8 (mujeres)
Colón-Recto	550	419	969	957	82,2
Próstata	719	-	719	795	131,4 (hombres)
Pulmón, Tráquea, Bronquios	491	153	644	596	54,6
Vejiga	436	111	547	533	46,4
Cerebro, Sistema Nervioso	94	136	230	271	19,5
Linfoma No Hodgkin	115	104	219	217	18,6
Útero (cuerpo)	-	219	219	211	34,7 (mujeres)
Melanoma de Piel	101	102	203	203	17,2
Total todos los Cánceres	5160	4732	9892	9046	839,2

Fuente: Registro de Cáncer de Granada. Tasas por 100.000 habitantes

Tabla- Incidencia y Tipos de Cáncer en el municipio de Granada, periodo 2013- 2017

En los hombres, para el periodo 2013-2017, los cánceres más frecuentes en Granada fueron el Cáncer de Piel no Melanoma, Cáncer de Próstata, de Colon-Recto, de Pulmón, de Vejiga y Linfoma No Hodgkin.

Si esta frecuencia de cánceres la comparamos en la misma población para el quinquenio 2009-2013, se comprueba que para los 6 tumores más frecuentes, han aumentado los cánceres de Piel no Melanoma y de Pulmón, mientras que el cáncer de Próstata ha descendido y se estabilizan el cáncer de Colon-Recto, de Vejiga y Linfoma No Hodgkin.

En las mujeres, para el periodo 2013-2017, los tumores más frecuentes fueron el Cáncer de Piel no Melanoma, de Mama, de Colon-Recto, de Útero, Pulmón y Cerebro.

Si la comparamos con la frecuencia del quinquenio 2009-2013 se comprueba que han aumentado la frecuencia de los cánceres de Piel No Melanoma, de Mama y Pulmón, permanecen estables el cáncer de Colon-Recto y Útero, descendiendo el cáncer de Cerebro.

Para poder comparar la frecuencia de cáncer de la población de Granada (Tasa Bruta) con otra población, es necesario estandarizar para descartar el factor edad, debido a que la diferente estructura de la población por el envejecimiento, produce un aumento en la frecuencia de cáncer; así, el mayor número de nuevos diagnósticos de cáncer se produce en los estratos de edad más altos.

La Tasa de Incidencia Estandarizada (por estructura de población europea) por todos los cánceres en Granada ciudad es de 569 casos por 100.000 habitantes, que es superior a la de la provincia de Granada que fue para el mismo periodo 2013-2017 de 491.

Los diferentes tipos de Cáncer en el municipio también tienen tasas más altas a las de la provincia de Granada.

TIPO CÁNCER	Tasas Estandarizadas GRANADA (Municipio) Media anual (2013-2017)	Tasas Estandarizadas PROVINCIA (Provincia) Media anual (2013-2017)
Piel (no melanoma)	162,1	131,2
Mama	116,2 (mujeres)	92,6 (mujeres)
Colón-Recto	52,4	46,7
Próstata	96,1 (hombres)	79,3 (hombres)
Pulmón, Tráquea, Bronquios	35,9	33,8
Vejiga	28,7	25,4
Cerebro, Sistema Nervioso	15	13,7
Linfoma No Hodgkin	14,1	11,2
Útero (cuerpo)	24,0 (mujeres)	22,7 (mujeres)
Melanoma de Piel	13,5	12,1
Total todos los Cánceres	569,5	491,5

Fuente: Registro de Cáncer de Granada. Tasas por 100.000 habitantes

Tabla- Comparativa de tasas estandarizadas de cáncer entre el Municipio y Provincia de Granada periodo 2013- 2017.

La mayoría de estos cánceres tienen relación con nuestro estilo de vida (consumo de tabaco y alcohol, dieta pobre en fibra, sedentarismo, etc.).

- 4.1.3.- Enfermedades de Declaración Obligatoria (Extracto):

Es la notificación que hacen los Médicos/as ante la sospecha de la existencia de cualquiera de las enfermedades comprendidas dentro del listado de ellas, para definir estrategias de prevención y control, o establecer medidas de intervención inmediata sobre los contactos o el medio.

Las tasas de incidencia de las enfermedades de declaración obligatoria en el quinquenio 2018-2022, son similares en las UA del Zaidín, e inferiores al resto de barrios de la ciudad.

Entre las enfermedades destaca la covid19 y las infecciones de transmisión sexual (infección gonocócica, Chlamydia trachomatis, sífilis, herpes genital).

Se aprecia la baja incidencia de enfermedades vacunables, salvo los casos de parotiditis y tosferina que están asociados a brotes nacionales.

Baja incidencia de enfermedades como Tuberculosis y VIH/SIDA.

Resumen del número de Casos de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), 2018-2022	ZAIDIN CENTRO	ZAIDIN SUR	D. ZAIDIN VERGELES	GRANADA MUNICIPIO
Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae	1	1	2	9
Enfermedad meningocócica	0	1	1	6
Enfermedad neumocócica invasora	7	5	12	68
Enfermedad por Coronavirus COVID-19	3771	5436	9207	60223
Hepatitis A	0	2	2	17
Hepatitis B	1	2	3	22
Hepatitis C	6	8	14	109
Herpes Genital	13	8	21	293
Infección genital por Chlamydia trachomatis	34	52	86	646
Infección gonocócica	36	51	87	711
Infección por VIH y SIDA	2	10	12	198
Legionelosis	0	2	2	20
Leishmaniasis	0	2	2	7
Listeriosis	4	3	7	42
Meningitis víricas	8	3	11	55
Parotiditis	6	14	20	315
Sífilis	17	30	47	316
Tosferina	2	0	2	30
Tuberculosis	3	6	9	106
Viruela de los monos	0	3	3	31
Total EDO	3909	5632	9541	64413
Tasas Incidencia anual (por 100.000 hab.)	3996	3860	3914	4683

Fuente: Redalerta

Tabla- Extracto del listado de Enfermedades de Declaración Obligatoria de las Unidades Asistenciales Zaidín Centro, y Sur, junto con Distrito Zaidín y Municipio de Granada; periodo 2018-2022.

- 4.1.4.- Alertas Sanitarias:

Las Alertas Sanitarias detectadas en el último quinquenio en las UA del Zaidín han sido escasas y predominan fundamentalmente los brotes por covid19.

Tipo de Brote o Alerta Sanitaria	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Brote de T.I.A.	0	1	1	0	0	2
Brote de brucelosis	0	0	0	0	0	0
Brote de enfermedad vacunable	0	1	0	0	0	1
Brote de gastroenteritis inespecífica	1	1	0	0	0	2
Brote de gripe	0	0	0	0	1	1
Brote de hepatitis A	0	0	0	0	0	0
Brote de origen hídrico	0	0	0	0	0	0
Brote Covid19	0	0	3	6	10	19
Brote de tuberculosis	0	0	0	0	0	0
Brote o Cluster de meningitis	0	0	0	0	0	0
Brote o Cluster de legionelosis	0	0	0	0	0	0
Brote por exposición a tóxicos	0	0	0	0	0	0
Brote por infestación	0	0	0	0	0	0
Total Zaidín Centro y Zaidín Sur	1	3	4	6	11	25
Total Granada (Municipio)	29	51	166	149	133	528

Fuente: Redalerta

Tabla- Tipos de brotes del Distrito Zaidín Vergeles y municipio de Granada; periodo 2018-2022.

4.2 Atención a la salud a lo largo de la vida:

- 4.2.1- Diagnostico Precoz Cáncer y Cribados:

- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Colon.

El cáncer de colon, es el más frecuente en la población si exceptuamos el de piel no melanoma. Puede detectarse antes de que aparezcan síntomas, cuando está aún en las fases iniciales, que es cuando es más fácil de tratar y con más posibilidades de curación.

Esta enfermedad empieza con el crecimiento anormal del tejido del propio intestino, dando lugar a pólipos o adenomas, en los que es frecuente el sangrado. La mayoría de los pólipos intestinales son benignos (no cancerosos), pero un pequeño porcentaje de casos son malignos.

El cribado consiste en la realización de una prueba para analizar la presencia de sangre oculta en las heces; se recomienda a todos los hombres y mujeres entre los 50 y 69 años (una prueba cada dos años). En el caso de resultar positiva esta prueba, se da cita en el centro de salud para informar y recomendar otras exploraciones (Colonoscopia).

En la ciudad de Granada, en el año 2022, la población diana elegible era de 77.835 personas, de las que 13.250 corresponden al barrio del Zaidín (4.963 a la UA de Zaidín Centro y 8.287 a la UA Zaidín Sur).

La participación en el programa es baja, aunque superior a la cifra en Andalucía que es del 37%. Se detecta sangre en heces en aproximadamente en el 8% de las muestras recogidas en el programa de prevención.

	Población Invitada Participar	Población Acepta (%)	N.º Test sangre en heces Válidos	N.º Test Positivos	% Positividad
U.A. Zaidín Centro	4963	2145 (43%)	1563	124	7,9 %
U.A. Zaidín Sur	8287	3262 (39%)	2311	194	8,4 %
Granada	77835	31402 (40%)	22111	1697	7,7 %

Fuente BPS y elaboración propia.

Tabla: coberturas de participación y de positividad de test de sangre oculta en heces, año 2022.

De las personas que han resultado con Test positivos, en las que se indicó la realización de Colonoscopias para detectar lesiones, se diagnosticaron fundamentalmente lesiones premalignas (adenomas). El resultado fue ligeramente superior en la UA Zaidín Sur.

	Adenomas	Cáncer invasivo	Diagnósticos Totales	% Diagnósticos
U.A. Zaidín Centro	59	3	62	4,0%
U.A. Zaidín Sur	130	2	132	5,7%
Granada	757	23	780	3,5%
Andalucía				3,7%

Fuente BPS y elaboración propia.

Tabla. Resultados del cribado de cáncer de Colon en la ciudad de Granada y Unidades Asistenciales (U.A.) Zaidín Centro y Sur, año 2022.

- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama.

El Cáncer de Mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas. En la actualidad no es posible llevar a cabo medidas para evitar que la enfermedad aparezca, pero se puede detectar en fases tempranas cuando aún no ha producido síntomas, por lo que aplicando el tratamiento adecuado, se mejora el pronóstico y aumenta la supervivencia.

La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas.

Consiste en la realización de mamografías cada 2 años a toda la población femenina entre 50 y 69 años, residente en Andalucía.

Las mujeres son citadas mediante carta que reciben en su domicilio para acudir a una Unidad de exploración mamográfica específica en donde se hacen dos placas por mama.

El resultado lo recibe la interesada por correo y en el caso de que deba ser derivada al hospital para completar el estudio o para realizar algún tipo de tratamiento también recibirá dicha cita por correo.

La población diana en la ciudad de Granada es de 33.775 mujeres, de las que 5.528 corresponden al barrio del Zaidín (2.246 a la UA de Zaidín Centro y 3282 a la UA Zaidín Sur, respectivamente).

La proporción de mujeres a las que se ha ofrecido la realización de la exploración de cribado (captación) es alto, diagnosticándose entre 3 y 4 tumores por cada mil mujeres participantes en el programa de prevención.

	Tasa Captación	N.º Tumores	Tasa Detección (%)
UA Zaidín Centro	87%	3	3,23
UA Zaidín Sur	86%	6	4,42
Hospital San Cecilio	84%	23	1,63
Hospital Virgen de las Nieves	86%	52	4,48

Fuente: PPCM y elaboración propia.

Tabla: Tasa de captación y de Detección de tumores de mama en el Programa de Prevención Precoz de Cáncer de Mama, año 2022.

- Diagnóstico Precoz del Cáncer de Cérvix/Útero.

El Programa de Detección de Cáncer de Cérvix/Útero es muy efectivo para identificar lesiones precursoras, disminuyendo la probabilidad de desarrollarlo.

El cáncer de cuello de útero tarda más de 10 años en desarrollarse, por lo que se dispone de un plazo prolongado para detectarlo, tratarlo y curarlo; al no producir molestias o síntomas al principio, la manera de saber su existencia es a través del cribado.

El programa va dirigido a mujeres entre 25 y 65 años a las que se realiza citología, a través de la cuál es posible detectar precozmente las células cervicales anómalas, pudiendo ser tratadas antes de que el cáncer aparezca.

La población diana en el municipio de Granada es de 80.586 mujeres, de las que 14.482 corresponden al barrio del Zaidín (6015 a la UA de Zaidín Centro y 8.467 al Zaidín Sur).

	N.º mujeres estudiadas (25-64 años)	Población Diana (25-64 años)	% Mujeres estudiadas (25-64 años)
UA Zaidín Centro	4395	6015	73,0%
UA Zaidín Sur	6323	8567	72,6%
Granada	60680	81622	74,3%
Distrito Granada Metropolitano	150854	196386	76,8%

Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número y porcentaje de mujeres entre 25 y 64 años, incluidas en el Diagnóstico Precoz de cáncer de Cérvix/útero, año 2021.

La proporción de mujeres que participan en el programa de Diagnóstico Precoz es muy similar en los diferentes ámbitos geográficos.

- Diagnóstico Precoz de Cáncer de Próstata/Hiperplasia Benigna Próstata (HBP).

El Cáncer de Próstata es el cáncer más frecuente en hombres, si se exceptúa el cáncer de piel no melanoma. No hay un cribado poblacional, pero sí existe un Proceso Asistencial donde se especifican la realización de una serie de actividades secuenciales destinadas a establecer el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con manifestaciones clínicas y/o analíticas de hipertrofia benigna de próstata y/o cáncer de próstata.

	N.º Hombres estudiados (50-70 años)	N.º total hombres (50-70 años)	% hombres estudiados (50-70 años)
UA Zaidín Centro	768	2302	33,4%
UA Zaidín Sur	954	3750	25,4%
Granada	8402	33150	25,3%
Distrito Granada Metropolitano	20410	86199	23,7%

Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número y porcentaje de hombres entre 50 y 70 años, incluidos en el Proceso Asistencial de HBP/Cáncer de Próstata, año 2021.

La proporción de hombres incluidos y estudiados en el Proceso Asistencial de HBP/Cáncer de Próstata es superior en la UA Zaidín Centro al resto de ámbitos geográficos.

- Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-metabólicas de Andalucía

El Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-metabólicas de Andalucía, popularmente conocido como la prueba del talón, tiene como objetivo la detección precoz de un grupo de enfermedades, en las que existe una intervención eficaz que permite modificar favorablemente su pronóstico, reduciendo la morbilidad y las posibles discapacidades asociadas a esas enfermedades.

Se ofrece activa y sistemáticamente a todos los recién nacidos con independencia de su nacimiento en un centro público o privado.

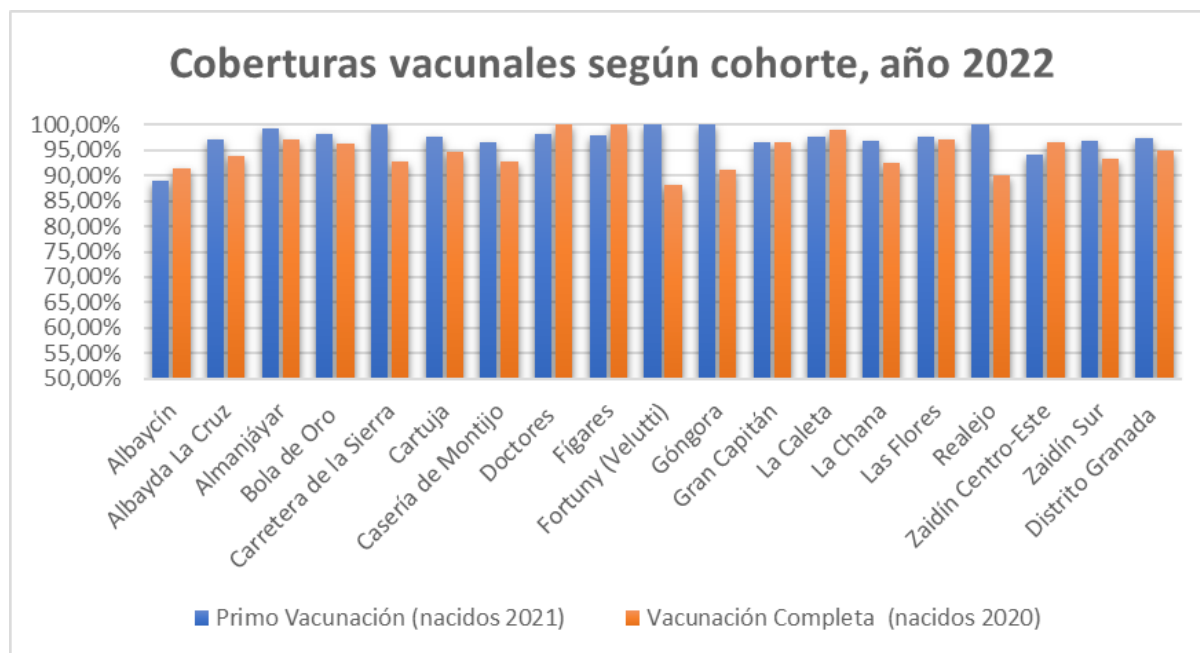
El cribado de Fenilcetonuria e Hipotiroidismo Congénito se lleva a cabo en Andalucía desde 1978 y en 2009 se fue extendiendo hasta 30 enfermedades metabólicas diferentes con la misma muestra de sangre, incluyendo la Fibrosis Quística.

Durante el año 2022, se realizaron 1740 Pruebas del Talón a recién nacidos con domicilio en la ciudad de Granada, para descartar enfermedades congénitas graves, de las que 99,9% resultaron normales y 2 patológicas.

- 4.2.2- Vacunaciones:

- Calendario de Vacunaciones, Primovacunación y Vacunación Completa a los 2 años.

El calendario de vacunaciones, también llamado calendario sistemático, es la secuencia cronológica de las vacunas que se recomiendan de forma fija en ciertas edades a la población, con el esquema más adecuado para evitar infecciones prevenibles.



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Coberturas vacunales en cohortes nacidas en 2020 y 2021. Año 2022.

Destaca la alta cobertura de las vacunaciones incluidas en el Calendario de Vacunaciones de Andalucía, para los niños/as nacidos en 2020 (vacunación completa) de la UA Zaidín Centro y Sur, superiores al 99%. En Primovacunación (nacidos/as 2021) las coberturas en ambas UA son superiores al 94%.

Para los nacidos/as en el 2018 (2ª dosis de vacuna Triple Vírica a los 4 años), las coberturas en la UA Zaidín Sur son del 97,2% y las de Zaidín Centro son del 100%.

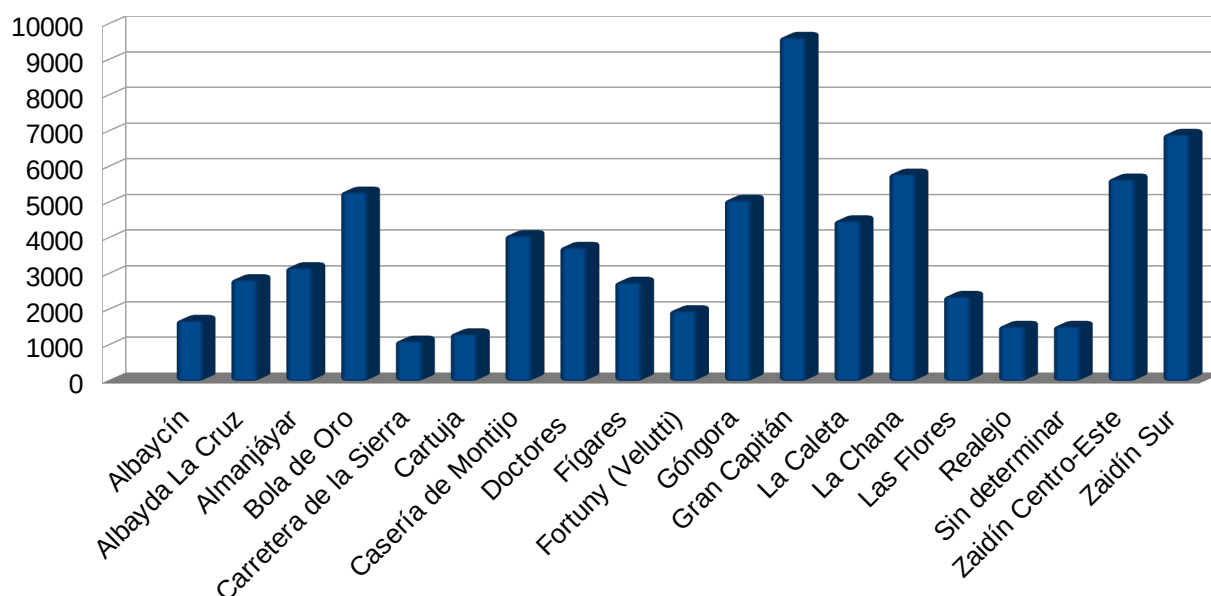
- Vacunación contra la Gripe, Total y en mayores de 65 años.

El objetivo de los programas de vacunación frente a la gripe es disminuir la carga de morbilidad causada por el virus de la gripe y reducir el impacto de la enfermedad en la comunidad.

La indicación de vacunación contra la gripe no es sistemática para toda la población, así, en la campaña 2022/2023, el objetivo era vacunar a toda la población de edades entre 6 y 59 meses y mayores de 65 años, además de personas mayores de 59 meses de edad con algún factor de riesgo (diabetes, bronquitis crónica,...) o situación especial (sanitarios, embarazadas,...).

En el siguiente gráfico puede observarse el número de personas vacunadas en la ciudad de Granada, por punto de administración.

Vacunación Poblacional de Gripe, Campaña 2022/2023



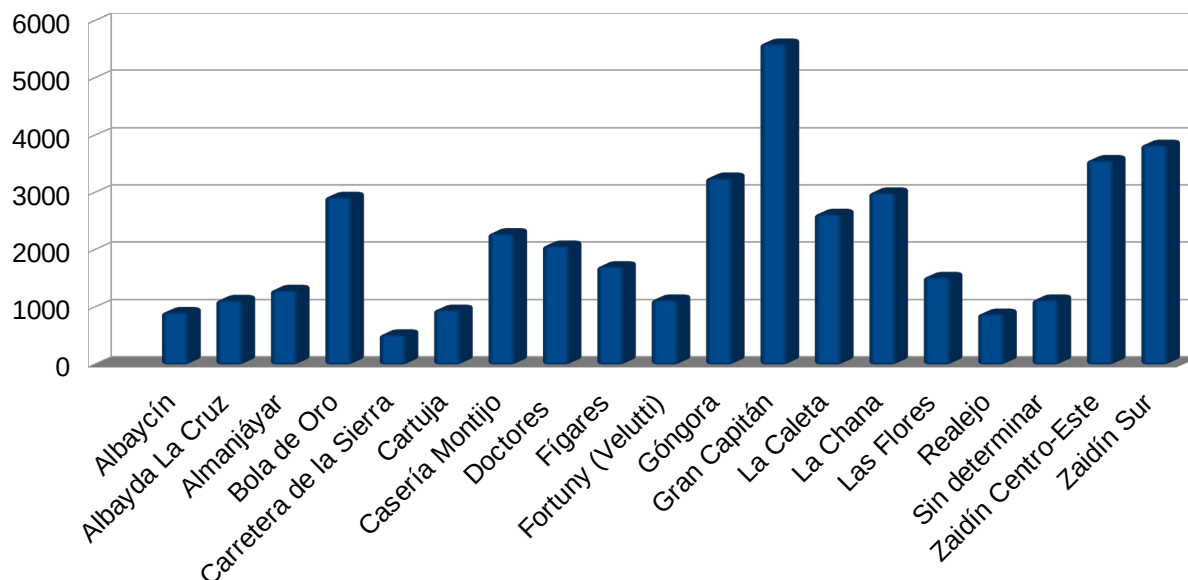
Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número de vacunas de la Campaña de Vacunación Antigripal de 2022/2023 administradas según Unidad Asistencial de Granada.

Uno de los principales grupos de riesgo de presentar complicaciones al padecer la gripe, son los mayores de 65 años; En Andalucía la cobertura de vacunación antigripal en este grupo fue del 70,6%, en la UA Zaidín Centro fue del 74,5% y en la UA Zaidín Sur del 69,3%.

En el siguiente gráfico puede observarse el número de personas mayores de 65 años vacunadas en la ciudad de Granada, por punto de administración.

Vacunación Mayores 65 años de Gripe, Campaña 2022/2023



Fuente: Aplicación Apoyo a la Gestión Clínica y elaboración propia.

Tabla: Número de vacunas de la Campaña de Vacunación Antigripal de 2022/2023 administradas según Unidad Asistencial de Granada en mayores de 65 años.

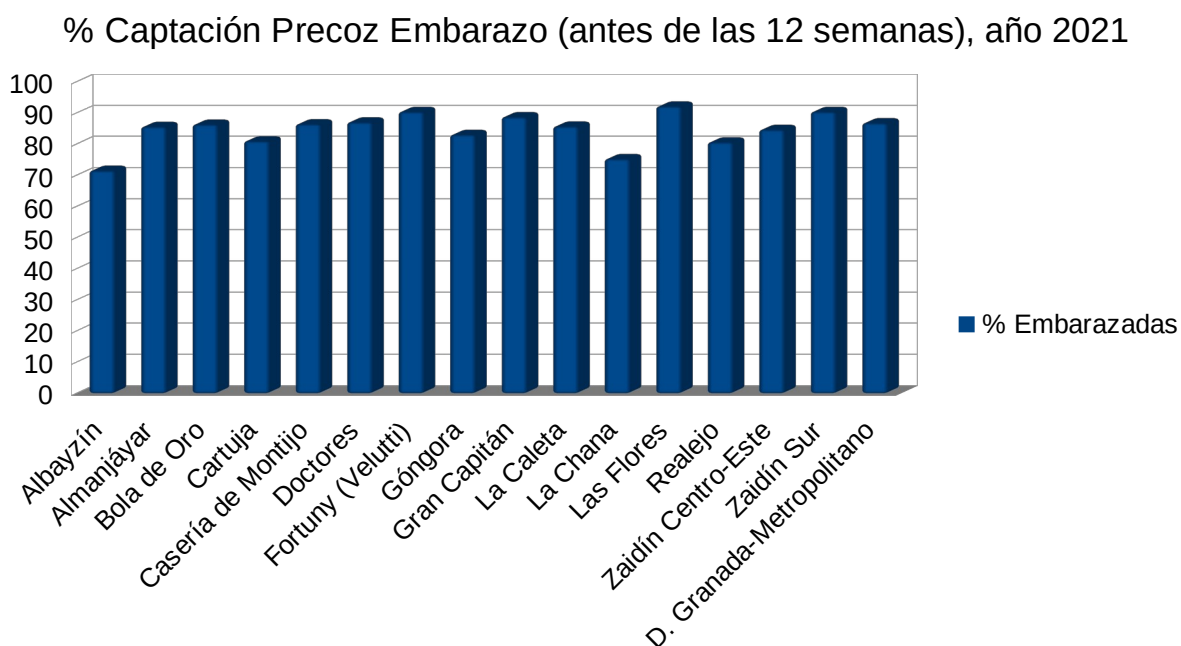
- 4.2.3- Embarazo:

- Captación Precoz en el Embarazo.

El embarazo es un proceso natural que requiere unos cuidados específicos y un seguimiento especializado con el fin de preservar en todo momento la salud y bienestar de la madre y del bebé.

En el Sistema Sanitario Público Andalúz los controles del curso del embarazo vienen definidos en el Proceso Asistencial Integrado Embarazo, Parto y Puerperio, donde se determina el número de visitas (de 8 a 10, una al mes, aproximadamente) y la frecuencia de éstas dependerá de si es un embarazo de bajo riesgo o no, pues si existen desviaciones de la normalidad requerirá visitas más próximas en el tiempo, actividades educativas (formativas/informativas), las exploraciones y pruebas diagnósticas o complementarias.

La mayoría de las embarazadas acude precozmente, antes de las 12 semanas de gestación al Centro de Salud, así, el 84,7% lo hacen en la UA Zaidín Centro y 90,3% en la UA Zaidín Sur (86,7% en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano).



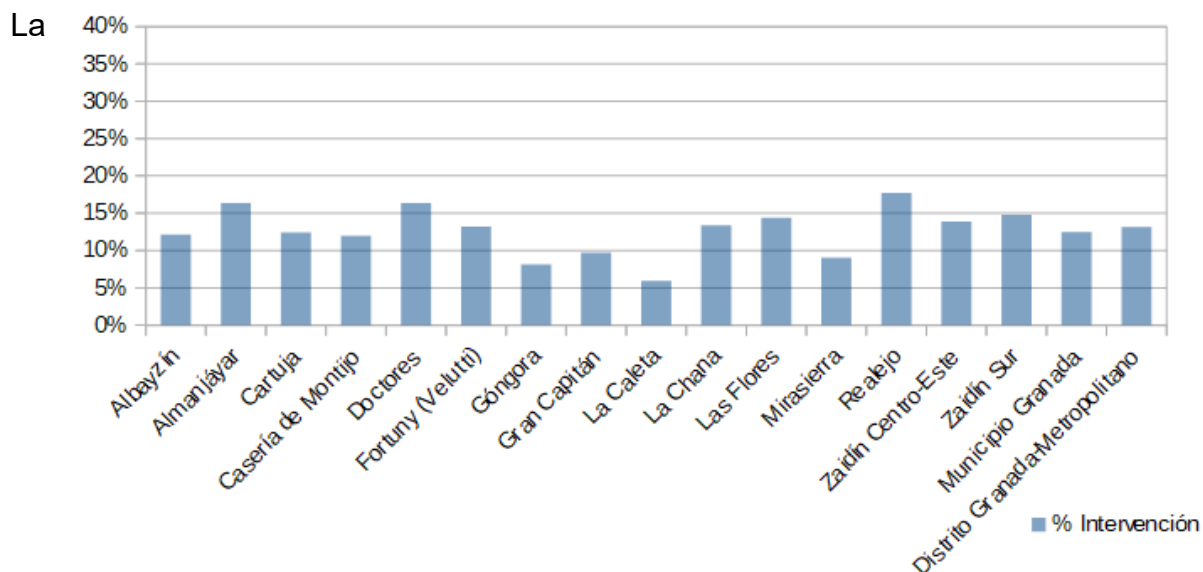
- 4.2.4- Estilos de Vida:

Las intervenciones en los estilos de vida, se ha visto muy afectada por la pandemia de covid19, al disminuir la presencialidad de los usuarios en los Centros de Salud y priorizar otras intervenciones consideraras más urgentes.

- Intervención Avanzada en Obesidad Infantil de 6 a 14 años (IAOI).

Se basa en intervenciones para promover una alimentación saludable y fomentar la actividad física, donde debe estar implicada la familia.

Porcentaje (%) niños/as con I.A.I. en Obesidad Infantil, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico

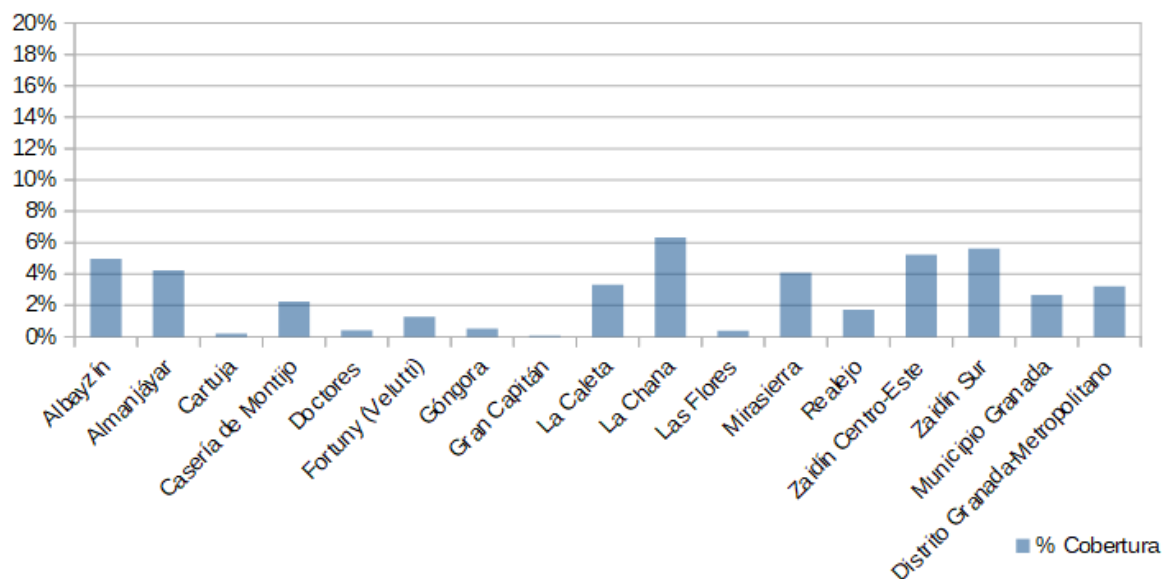


mediana del periodo 2018-2021 en el porcentaje de IAOf disminuyó con respecto al periodo 2013-2017, esta disminución no afectó tanto a las UA del Zaidín, así, en la UA Zaidín Centro el resultado fue del 3,7%, y en la UA Zaidín Sur del 6,3%, sin embargo en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano fue del 1,9%,

- Consejo Dietético Individual en adultos.

Al igual que en la población infantil, también se vieron afectadas las intervenciones en Consejo Dietético en adultos. Así en el periodo 2013-2017, destacaban las UA del Zaidín.

Porcentaje (%) adultos que reciben Consejo Dietético Intensivo Individual, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico



En el periodo 2018-2021, en la UA Zaidín Centro el resultado fue del 0,65% y en la UA Zaidín Sur del 0,63%, mientras que en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano fue del 0,15%.

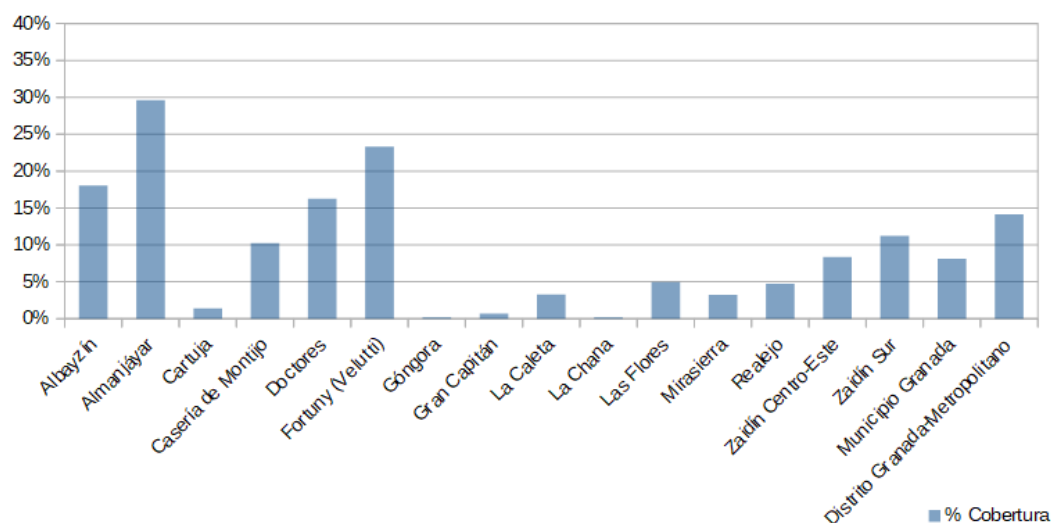
- Intervención Avanzada Individual para dejar el tabaco.

El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y recidivante; es la primera causa evitable de morbilidad y mortalidad en el mundo desarrollado.

El consumo de tabaco ha sido uno de los más importantes problemas de salud pública, originando más muertes que el SIDA, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos.

El dejar de fumar produce importantes beneficios para la salud tanto si se han desarrollado enfermedades relacionadas con el tabaco como si no.

Porcentaje (%) de mayores de 16 años con Intervención Avanzada Individual en Tabaquismo, mediana 2013-2017, según el ámbito geográfico



En el periodo 2018-2021, la Intervención Avanzada Individual para dejar el tabaco en adultos, en la UA Zaidín Centro el resultado fue del 10,7% de los fumadores y en la UA Zaidín Sur del 1%, mientras que en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano fue del 8%.

4.3 Análisis de la mortalidad

Se analiza la mortalidad general y la mortalidad por causas específicas del municipio de Granada, al no existir estadísticas oficiales por barrios o Unidades Asistenciales:

- 4.3.1.- Mortalidad General:

En el año 2021, fallecieron en el municipio de Granada 2.444, 1.142 hombres y 1.302 mujeres (2.340 personas, 1.111 hombres y 1.229 mujeres en 2016), que se corresponde con una Tasa Bruta de Mortalidad de 10,6‰ (Andalucía 9,4‰). Sin embargo, si esta tasa se diferencia por sexo, es superior en los hombres (10,7‰) con respecto a las mujeres (10,4‰), debido a que la población de mujeres es mayor; es decir, los hombres tienen más riesgo de morir aunque mueren más mujeres.

La Mortalidad General o mortalidad por todas las causas (2015), está elevada de manera significativa con respecto a España, tanto en mujeres como en los hombres, en los grupos etarios de 45-64, 65-74 y 75-84 años de edad.

- 4.3.2.- Mortalidad Específica:

En la ciudad de Granada, durante 2021, las principales causas de defunción fueron por enfermedades del sistema circulatorio con el 27% (28% en Andalucía), por tumores con el 25% (24% en Andalucía) y por enfermedades Infecciosas con el 11% (10% en Andalucía).

Las defunciones por causa de muerte, según capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición (CIE 10) son:

CIE 10 (año 2021)	Granada (ciudad)	Granada (Provincia)	Andalucía
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	259	933	7.803
II. Tumores	611	2.090	19.013
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	7	39	334
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	73	296	2.792
V. Trastornos mentales y del comportamiento	64	266	2.615
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	179	515	4.513
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	665	2.431	22.394
X. Enfermedades del sistema respiratorio	182	636	5.742
XI. Enfermedades del sistema digestivo	145	465	4.241
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6	25	247
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	33	103	793
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	92	329	2.808
XV. Embarazo, parto y puerperio	0	1	3
XVI. Afecciones originadas en el período perinatal	4	15	134
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	11	152
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	55	320	3.057
XX. Causas externas de mortalidad	62	292	2.698
Total	2.444	8.767	79.339

En el año 2015, las causas específicas de mortalidad que presentaron un exceso de riesgo significativo con respecto a España y que por tanto pueden explicar el exceso en la mortalidad general, fueron (por sexo y grupo de edad):

- Accidentes de Tráfico: en mujeres de 75 a 84 años.
- Cáncer de Colon-Recto: en mujeres mayores de 85 años.
- Cáncer de Próstata: en hombres de 75 a 84 años.
- Cirrosis: en hombres de 65 a 75 años.
- Diabetes: en hombres de 75 a 84 años de edad.
- Enfermedad de Alzheimer: en hombres y mujeres mayores de 75 años.
- Enfermedad Cerebrovascular: En hombres de 45 a 85 años y en mujeres de 65 a 75 y mayores de 85 años.

- Enfermedad Isquémica del Corazón: en hombres mayores de 75 y en mujeres mayores de 65 años.
- Suicidio: en hombres de 15 a 44 años.